VI. Seelische Störungen und Hochbegabung

> Sit down before fact as a little child, be prepared, to give up every preconcieved notion, follow humbly wherever and to whatever abyss nature leads, or you shall learn nothing. *T. H. Huxley*

Forschungsstand

Systematische Studien zu seelischen Störungen bei Hochbegabten sind noch spärlich, deuten jedoch darauf hin, dass die große Mehrzahl Hochbegabter als psychisch gesund einzustufen ist.
Die wegweisende Langzeitstudie von Terman (1925, 1947, 1959) zeichnet zunächst ein durchweg positives Bild der psychosozialen Entwicklung Hochbegabter: Sie seien nicht nur intellektuell überlegen, sondern auch beliebter, sozial anpassungsfähiger und emotional stabiler als durchschnittlich Begabte.
Winner (1998) hingegen wendet ein, dass »Termans These von der glänzenden psychischen Gesundheit und Anpassungsfähigkeit des hochbegabten Kindes in dieser extremen Form nicht haltbar« sei (S. 195); in Termans Folgestudien sei deutlich geworden, dass auch erfolgreiche Hochbegabte sich in ihrer Jugend sozial stärker benachteiligt und häufiger ausgeschlossen fühlten. Selbst Terman räumte ein, dass extrem hochbegabte Personen vor größeren sozialen Problemen stehen (Burks, Jensen & Terman, 1930). Scheidt (2004) weist zudem darauf hin, dass problematische Hochbegabte mit Leistungsschwierigkeiten von vornherein nicht in Termans Studien aufgenommen wurden.
Neuere Studien wie z. B. von Schilling (2002) und Freund-Braier (2001) kommen ebenfalls zu dem Ergebnis, dass hochbegabte Kinder und Jugendliche nicht häufiger unter sozialen oder psychischen Problemen leiden als die Durchschnittsbevölkerung, sondern sogar eine günstigere Entwicklungsprognose aufweisen. Dyker (2004) merkt jedoch zu Recht an, dass gerade Hochbegabte mit schwerwiegenden Problemen von den Identifikationsverfahren (Schnell-

und Gruppentests in der Schule) nicht in ausreichendem Maße erfasst werden, wenn sie etwa unter Motivationsmangel, Lernschwierigkeiten oder Selbstzweifeln leiden.
Dieffenbach (2003) geht von rund 18 % behandlungsbedürftiger Störungen bei hochbegabten Kindern und Jugendlichen aus, wobei Lernstörungen, depressive Entwicklungen und Kontaktschwierigkeiten zu den häufigsten Störungsbildern zählen.
Im Hinblick auf die Häufigkeit seelischer Erkrankungen bei hochbegabten Erwachsenen gibt es nach meinem Wissensstand bislang keine systematischen Untersuchungen.

Mir persönlich scheint der Diskussion um seelische und soziale Probleme Hochbegabter weder eine einseitig positive noch eine einseitig negative Darstellung förderlich zu sein. Festzuhalten ist, dass Hochbegabte ebenso unter psychischen Störungen leiden können wie alle anderen Begabungsgruppen auch. Im Laufe meiner langjährigen therapeutischen Arbeit machte ich jedoch bei der Diagnostik, Beratung und Behandlung von Hochbegabten eine Reihe von Beobachtungen, die für mich weitaus interessantere Fragestellungen aufwerfen:
Welche *Befähigungen und Kenntnisse* braucht der *Behandler* in der Therapie mit einem Hochbegabten?
Welche Aspekte sind in der *Beziehungsgestaltung* zu beachten?
Welchen Einfluss hat eine *unerkannte Hochbegabung* auf den Therapieerfolg?
Wann ist von einer *psychischen Störung* zu sprechen und wann handelt es sich um *›ganz normale‹ Hochbegabungs-Symptome*?

Bevor ich im Einzelnen auf die psychotherapeutische Behandlung seelischer Störungen bei Hochbegabten eingehe, scheinen mir einige Vorbemerkungen zu meiner therapeutischen Haltung und Methodik nötig.

Zu meiner Arbeitsweise

Ich möchte nicht verschweigen, dass meine Zusammenarbeit mit Hochbegabten sowohl meinen *Störungsbegriff* als auch meine Vorstellungen von einem *methodischen therapeutischen Vorgehen* ge-

hörig ins Wanken gebracht hat. Dafür bin ich besonders den widerspenstigen, kritischen und eigensinnigen meiner hochbegabten Klienten dankbar. Ihre Abneigung gegen technisch-methodische Interventionen, ihr hartnäckiges Hinterfragen meiner Arbeitsweise und meiner Person verlangten mir ein hohes Maß an Flexibilität, stetiges Umdenken und eine zunehmend individuelle Therapie-Gestaltung ab.

In den Behandlungen zeigte sich auffallend häufig, dass Hochbegabte mit seelischen Störungen sich schon nach kurzer Zeit deutlich weniger ›gestört‹ fühlten, als sie von ihrer Hochbegabung und den damit verbundenen Besonderheiten im Denken, Wahrnehmen und emotionalen Erleben erfuhren. Sich ›anders als alle andern‹ zu fühlen, kann zur Entstehung und Aufrechterhaltung einer psychischen Erkrankung offenbar mit beitragen. Sich zumindest einer Minderheit zugehörig fühlen zu können, scheint hingegen einen maßgeblichen Anteil an der Linderung psychischer Beschwerden zu haben.

Ich bin daher zu dem Schluss gekommen, dass die Heilung von seelischen Störungen bei Hochbegabten (nicht im Sinne einer hinreichenden, jedoch einer notwendigen Bedingung) auch auf der Kenntnis der mit einer Hochbegabung verbundenen Phänomene basiert.

Wie ist aber vor diesem Hintergrund der *Begriff der psychischen Störung* zu definieren? Es fällt mir zunehmend schwerer, diese Frage zu beantworten, und ich bin immer öfter versucht, diesen Begriff in Anführungszeichen zu setzen; er scheint vielmehr etwas über die *Beziehung zwischen dem Individuum und seinem Umfeld* auszusagen als über das Individuum selbst. Was in einem bestimmten Kontext als gesund und normal empfunden wird, kann unter anderen Bedingungen als gestört oder abnorm angesehen werden. In einem Schwimmbad gilt eine bis auf die Bikinihose entkleidete Frau als normal; beträte sie in derselben Aufmachung eine Straßenbahn, gälte sie als abnormal. In manchen Kulturen werden schizophrene Menschen oder Autisten als Heilige verehrt, in anderen als Schwerstkranke behandelt. Hier ließen sich zahllose weitere Beispiele anführen. Bei Hochbegabten (wie vielleicht auch bei allen anderen) stellt sich immer die Frage: In welchem *Umfeld* und unter welchen *Bedingungen* fühlt sich der Betreffende *nicht* gestört?

Bewegt er sich unter Schauspielern, wird er gerade *wegen* seiner Gefühlsintensität geschätzt; arbeitet er in einem wissenschaftlichen Symposium mit, nimmt man sein kritisches Hinterfragen und Analysieren positiv auf; in einer Künstlerkolonie wird sein skurriler Lebensstil als selbstverständlich akzeptiert; unter Gleichbegabten verhält er sich möglicherweise sozial kompetent und selbstsicher. Statt von ›psychischen Störungen‹ würde ich daher lieber von ›Leiden‹ oder ›Beschwerden‹ sprechen.
Diese Grundannahmen bewirkten auch eine Veränderung meiner therapeutischen *Haltung*: Ich sehe mich nicht einem ›gestörten Patienten‹ gegenüber, den ich aus der objektiven Warte eines erfahrenen Therapeuten behandle, sondern *einer im Kern gesunden Persönlichkeit, die subjektiv unter bestimmten Gegebenheiten leidet* und gleichberechtigt mit mir an einer Veränderung arbeitet. Diese Haltung überträgt sich unweigerlich auf meine Klienten und fördert Therapieerfolge in maßgeblicher Weise.

Hinsichtlich meiner *Methodik* war ich als ausgebildete Verhaltenstherapeutin zunächst einem sehr didaktischen und strukturierten Arbeitsstil verpflichtet. Damit stieß ich besonders bei Hochbegabten immer wieder an Grenzen: Die meisten sind Individualisten und Nonkonformisten und reagieren fast reflexhaft abwehrend auf vorgefertigte Therapie-Techniken und therapeutische ›Tricks‹. Nicht wenige haben Kenntnisse über psychotherapeutische Verfahren und wollen darüber diskutieren. Viele haben ein ausgeprägtes Gespür für die Authentizität einer Person, verlangen persönliche Stellungnahmen oder provozieren mich diesbezüglich. So war ich unter anderem aufgefordert, mich zu fragen, welche Maßnahmen für mich selbst hilfreich sind, wenn ich mich in kritischen Lebensphasen befinde oder unter starker seelischer Belastung stehe. Viele Therapeuten halten es für einen Fehler, etwas von sich selbst preiszugeben, und legen großen Wert auf Neutralität und Anonymität. Ich bin jedoch zu der Auffassung gelangt, dass nur ein ehrlicher Therapeut ein glaubwürdiger Therapeut sein kann. ›Ehrlich‹ bedeutet, keine Unsicherheiten zu überspielen, eigene Schwächen zu bekennen oder zu schildern, wie man selbst mit bestimmten Schwierigkeiten umgeht.
Zu dieser Erkenntnis haben mich meine hochbegabten Klienten

mehr oder weniger gezwungen; inzwischen profitiert davon mein gesamtes therapeutisches Arbeiten. Erleichtert stellte ich kürzlich fest, dass die Wirksamkeit der »Selbstoffenbarung des Therapeuten« empirisch untersucht und belegt wird (Knox, 2003). Die Selbstoffenbarungen sollten natürlich nicht ausufern, nicht zu intim sein und immer in Bezug zu den Äußerungen des Klienten stehen.
Mein therapeutisches Grundinventar entstammt also der Verhaltenstherapie mit zusätzlichen Elementen aus der Familien-, Gesprächs- und Traumatherapie. Wenn ich *Methoden* anwende, erkläre ich sie vorher und mache mein Vorgehen transparent.
Meine therapeutische *Haltung* habe ich von meinen Klienten gelernt: Ich arbeite auf Augenhöhe mit ihnen zusammen, stelle mich kritischen und persönlichen Fragen und lerne dabei ebenso viel von meinen Klienten wie sie von mir.

1. Psychotherapie mit hochbegabten Kindern und Jugendlichen

Elternberatung

Zu Fragen der Elternberatung im Hinblick auf schulische Fördermaßnahmen empfehlen sich etwa die Veröffentlichungen von Elbing (2000), Heinbokel (1997, 2001) oder Wittmann & Holling (2001).
Die Beratung von Eltern hochbegabter Kinder umfasst neben der Vermittlung der Testergebnisse und schulischer Fördermöglichkeiten auch die Erörterung familiärer Aspekte und möglicher seelischer Probleme. Einige Lösungsansätze lassen sich bereits aus den bisherigen Schilderungen ableiten. Zu den häufigsten Fragen, die Eltern mir stellen, möchte ich im Folgenden nochmals ausführlicher Stellung nehmen.

Was sage ich meinem Kind?

Die meisten Eltern möchten wissen, ob sie ihrem Kind nach einem Test die »Diagnose« einer Hochbegabung mitteilen sollen. Darüber habe ich mit vielen Klienten gemeinsam nachgedacht und disku-

tiert. Meine Antwort lautet: Ja, die Kinder müssen Bescheid wissen, und zwar unabhängig davon, ob sie fünf oder fünfzehn Jahre alt sind. Dies gilt insbesondere dann, wenn bereits Probleme im Zusammenhang mit der Hochbegabung auftreten. Natürlich müssen bestimmte Dinge beachtet werden, wenn man Kindern das Ergebnis mitteilt:

1. Die Mitteilung muss altersentsprechend formuliert sein. Einem sechsjährigen Kind kann man etwa sagen: »Du kannst besonders schnell denken, deshalb ist dir in der Schule auch oft besonders langweilig.«
2. Den Kindern soll verständlich gemacht werden, dass ihre Intelligenz eine schöne Gabe ist, auf die sie stolz sein dürfen, die aber auch gewisse Schwierigkeiten mit sich bringen kann. Sie sollen die Stärken und Schwächen, die mit ihrer hohen Begabung verbunden sein können, erkennen und verstehen.
3. Wie wir gesehen haben, wissen die meisten Kinder selbst sehr gut, dass sie mit ihrer hohen Intelligenz nicht prahlen sollten, weil sie sich damit unbeliebt machen. Sicherheitshalber kann man es aber nochmal erwähnen.
4. Je besser die Eltern über das Phänomen Hochbegabung informiert sind, umso sicherer und gelassener können sie sich gegenüber ihrem Kind verhalten und umso genauer können sie ihm alles erklären.
5. Auch Hochbegabte brauchen *Lob* und *Anerkennung* und das Gefühl, von ihren Eltern so akzeptiert und geliebt zu werden, wie sie sind. Viele Eltern halten sich besonders dann mit Lob etwas zurück, wenn ihre Kinder vorlaut erscheinen und viel Aufmerksamkeit für ihre besonderen Befähigungen oder Kenntnisse fordern. Nach meiner Erfahrung *beruhigen* sich die Kinder jedoch eher, wenn man ihnen bestätigt, dass sie einige Dinge besonders gut können.

Die »Gefahr«, dass ein hochbegabtes Kind sich anders entwickelt als seine Altersgenossen, wird nicht dadurch gebannt, dass man sie verschweigt oder leugnet. Die Befürchtung (die ich zu Beginn meiner Tätigkeit teilte), die Kinder könnten vielleicht erschrecken, wenn sie erfahren, dass sie in mancherlei Hinsicht außergewöhnlich sind, hat sich in bislang allen von mir untersuchten und beglei-

teten Fällen als unbegründet erwiesen. Ebenso wie die Sorge, die Kinder könnten »abheben« und hochmütig werden, wenn sie wissen, dass sie besonders intelligent sind.
Zum einen spüren die Kinder meist ohnedies, dass sie »irgendwie anders« sind als die meisten Gleichaltrigen. Wenn sie aber dafür keine Erklärung finden, werden sie immer dazu neigen, sich unzulänglich und unsicher zu fühlen und an sich selbst zu zweifeln. Zweitens ist es von größter Wichtigkeit, dass die Kinder *in ihren eigenen Wahrnehmungen bestätigt* werden, damit sie mit ihrem Anderssein besser umgehen können. Es ist manchmal ein langwieriger Weg, bis Eltern ihren Kindern vermitteln können, dass sie ruhig ein wenig »besonders« sein dürfen und nicht mehr versuchen müssen, sich zu verstellen. Letztlich liegt darin sogar oft eine größere Chance, sich anderen gegenüber zu behaupten und von ihnen akzeptiert zu werden.

»Seit meine Tochter sich nicht mehr so sehr bemüht, sich den anderen anzupassen, wird sie erstaunlicherweise viel mehr akzeptiert. Sie hat zwar bei ihren Mitschülern einen Sonderstatus, aber seit Clara dies selbstbewusster auslebt, kommt sie mit den anderen viel besser zurecht. Sie organisiert in der Schule kleine Wettbewerbe, führt in den Pausen Zauberkunststücke vor und hat ein skurriles Kartenspiel erfunden, an dem viele sich beteiligen. Die anderen sehen, dass sie von Claras originellen Einfällen profitieren können.«
»Michael ist wie ausgewechselt, seit er getestet wurde. Er hat mehr Selbstvertrauen, ist verantwortungsbewusster und sogar ordentlicher als vorher. Er verfolgt jetzt mehr Interessen und ist aktiver geworden.«

Leider verläuft dieser Prozess nicht bei allen Kindern so optimal. Aber in keinem einzigen Fall hat es sich bislang negativ ausgewirkt, wenn man den Betroffenen erklärte, warum sie ein wenig anders sind als andere Kinder. Die meisten hochbegabten Kinder und Jugendlichen erleben es als wohltuend und befreiend, wenn man ihnen bestätigt und erläutert, was sie selbst bislang nur unterschwellig oder diffus wahrgenommen haben. Diese Mitteilung hatte *fast ausnahmslos einen positiven, nie aber einen negativen Einfluss* auf

ihre Entwicklung. Zu diesem Ergebnis kommt unter anderem auch Dieffenbach (2003).

Wie verhindere ich, dass mein Kind zum Einzelgänger wird?
Auch wenn es paradox klingt: Je mehr Mut Eltern aufbringen, ihr Kind in seinem Besonderssein zu akzeptieren und zu fördern, umso mehr Selbstbewusstsein wird es entwickeln und umso eher kann es sowohl in der Gruppe seinen Platz als auch Kontakt zu Gleichgesinnten finden.
Konkret bedeutet dies:

- auch mit jüngeren Kindern anspruchsvolle Themen zu besprechen, wenn sie danach verlangen
- die Stärken und Begabungen des Kindes zu fördern
- das Kind für seine besonderen Fähigkeiten zu loben
- zu akzeptieren, wenn das Kind seine sozialen Kontakte auf einen oder wenige Spielkameraden beschränkt
- die Stärken von eher schüchternen und introvertierten Kindern zu betonen (z. B. ihre Fähigkeit zur genauen Beobachtung; ihre Neigung zu wenigen, aber beständigeren Kontakten)
- das Kind in seinem Mut zum ›Anderssein‹ zu unterstützen
- das Kind nicht zu Aktivitäten zu zwingen, die es nicht tun möchte, zum Beispiel einen Fußballverein zu besuchen oder an großen Veranstaltungen teilzunehmen
- dem Kind Respekt zu zollen, wenn es etwa in Auseinandersetzungen überlegen argumentiert oder sich früh mit schwierigen Themen befasst
- dem Kind die Teilnahme an Aktivitäten mit anderen Hochbegabten zu ermöglichen.

Langfristig entwickeln auch sehr zurückhaltende und stille hochbegabte Kinder mehr Selbstvertrauen, wenn man versucht, Bedingungen zu schaffen, die ihrem Wesen gerecht werden und ihren Stärken entsprechen.

Wie gehe ich mit den Stimmungsschwankungen meines Kindes um?
Es ist zunächst wichtig, dem Kind die Zusammenhänge zwischen hoher Begabung und hoher Sensibilität zu erläutern. Eine einfache

Erklärung lautet: »Hochbegabung bedeutet *mehr von allem*: mehr denken, mehr fühlen, mehr wahrnehmen.«
Eine zweite Grundregel lautet: Reden, reden und nochmals reden. Viele Eltern berichten von langen abendlichen »Bettkantengesprächen über Gott und die Welt«.
Starke Gefühlsäußerungen wie Traurigkeit oder Zorn sollten selbstverständlich *ernst genommen, aber nicht überbewertet werden*. Wenn man das Kind in seinen intensiven Stimmungen begleitet, ohne selbst in Sorge zu geraten oder die Nerven zu verlieren, kann es am ehesten zu der Überzeugung gelangen, dass seine starken Emotionen nichts Bedrohliches oder Unnormales sind. Das nimmt manchen Krisen bereits etwas an Schärfe.
Im Hinblick auf heftige Wutanfälle empfiehlt es sich, mehr das *erwünschte* Verhalten (also Versuche des Kindes, die Wut unter Kontrolle zu bringen) zu fokussieren und positiv zu verstärken, als das *unerwünschte* Verhalten zu bestrafen. Hochbegabte Kinder müssen oft lernen, dass geduldiges Üben und die Fähigkeit, Misserfolge zu verarbeiten, bereits an sich eine *Stärke* sind und einen *Erfolg* darstellen.
Weiterhin ist es hilfreich, für Spannungsabbau zu sorgen, indem man das Kind geistig ausreichend fordert, ihm *sportliche Aktivitäten* (wobei hochbegabte Kinder Zweier-Sportarten wie Tischtennis, Fechten, Badminton oder Tennis Mannschaftssportarten gewöhnlich vorziehen), aber auch genügend *Ruhephasen* ermöglicht. Bei einschneidenden Veränderungen, wie zum Beispiel beim Eintritt in den Kindergarten, sollten Regelungen gefunden werden, die dem Bedürfnis des Kindes nach einer *langsamen, schrittweisen Eingewöhnung* entsprechen.
Nicht zuletzt fördert man mit der Selbsterkenntnis des hochbegabten Kindes auch seine Fähigkeit, sich selbst, und damit auch die Gefühlsausbrüche, die Ungeduld und die Neigung zum Dramatisieren, mit *Humor* zu betrachten.

Beziehungsgestaltung

Erwachsene neigen dazu, sich auf ein kindliches Gegenüber einzustellen, indem sie es besonders laut, fröhlich und ›kindgerecht‹ ansprechen. Sie verändern Stimme und Tonfall und versuchen mit

kleinen Scherzen eine lustige, lockere Atmosphäre zu schaffen. Bei sehr schüchternen und leisen Kindern verspürt man gar den Impuls, diese Bemühungen noch zu intensivieren, um sie zu einer Äußerung zu bewegen und ihnen zu zeigen, dass sie keine Scheu haben müssen.
Meine Erfahrung und die Berichte betroffener Eltern zeigen jedoch, dass Hochbegabte diese Verhaltensweisen als unnatürlich, aufdringlich und irritierend erleben.
»Bei der schulärztlichen Untersuchung sagte Jonas zunächst kein Wort. Die Ärztin ging nahe an ihn heran, berührte in an der Schulter und sagte etwas wie: ›Wollen wir mal ein lustiges Spiel spielen?‹ Jonas rückte ein Stück ab und verschränkte die Arme. Je lauter und eindringlicher ihn die Ärztin zum Mitmachen ermuntern wollte, umso mehr blockierte er. Dies war der wesentliche Grund, warum ihm anschließend soziale Unreife attestiert wurde. Jonas selbst erklärte uns, er sei schließlich zu einem Einschulungstest und nicht zu einer lustigen Spielstunde gekommen.«

Wenn Eltern mit ihrem Sohn oder ihrer Tochter zum Test kommen, versuche ich folgende Punkte zu beachten:

1. Verhält sich ein Kind im Wartezimmer sehr leise und ruhig, spricht es nur im Flüsterton oder liest still ein Buch, stelle ich mich schon im Vorfeld darauf ein, das Kind bei der Begrüßung vorsichtig und behutsam anzusprechen. Wenn es Blickkontakt vermeidet oder mir nicht die Hand geben möchte, akzeptiere ich das selbstverständlich. Im Übrigen begrüße ich immer zuerst das Kind und stelle mich vor; auch vermeide ich es nach Möglichkeit, mit den Eltern über das Kind zu sprechen, während es anwesend ist. Das Kind ist die Hauptperson, wenn es zum Test oder zur Therapie kommt. Und es hat das Recht, sich die Eingewöhnungszeit zu nehmen, die es braucht.
Andere Kinder verhalten sich schon im Wartezimmer lebhaft und neugierig, begrüßen mich fröhlich und stellen mir gleich zu Beginn viele Fragen. Sie wollen genau wissen, was sie erwartet, und ich kläre sie so gut es geht darüber auf.

2. Bei Kindern oder Jugendlichen, die sich scheuen, überhaupt zum Test zu kommen, weil sie Angst vor fremden Menschen und neuen Situationen haben, schlage ich den Eltern im Vorgespräch Folgendes vor: »Sie erklären Ihrer Tochter/Ihrem Sohn genau, was beim Test geschieht. Er ist aufgebaut wie eine Art Wissens-Quiz zu verschiedenen Gebieten. Die Aufgaben sind nach Schwierigkeitsgrad geordnet, das heißt, sie beginnen sehr leicht und enden sehr schwierig. So wird sichergestellt, dass kein Kind sich langweilt, aber auch keines überfordert wird. Man kann im Test nicht ›versagen‹, sondern es wird lediglich ermittelt, wo Ihre Tochter/Ihr Sohn Stärken, Schwächen und vielleicht besondere Begabungen hat. Ihr Kind kann erst einmal allein mit in den Behandlungsraum kommen, während Sie im Wartezimmer bleiben. Ich zeige ihm dann, welcher Art die Aufgaben sind und wie sie funktionieren. Oder wir machen (bei sehr jungen Kindern, die Angst haben alleine mitzukommen) in Ihrem Beisein zunächst einige Quiz-Aufgaben, die nicht aus dem Test stammen, bis es sich an die Situation gewöhnt hat. Das Kind sagt dann Bescheid, wenn die Eltern sich zurückziehen dürfen. Teilen Sie Ihrem Sohn/Ihrer Tochter mit, dass sie anschließend *selbst entscheiden* können, ob sie beim Test mitmachen wollen oder nicht.«
Viele besonders ängstliche Kinder lassen sich auf diese Regelung ein. Glücklicherweise sind fast alle hochbegabten Kinder nach kurzer Zeit so interessiert an den Testaufgaben, dass sie gerne dableiben. Wenn ein Kind sich dennoch weigert, sollte man es nicht zwingen, am Test teilzunehmen, und vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmals einen Versuch wagen.

3. Hochbegabte Kinder und Jugendliche sind nicht nur eine Herausforderung an den Intellekt eines Therapeuten, sondern auch an seine *Authentizität*. Viele hochbegabte Kinder reagieren mit Recht sehr sensibel auf falsche Töne, autoritäres Auftreten oder Manipulationsversuche. Ich selbst habe die feinen Antennen Hochbegabter sehr zu schätzen gelernt, da sie mir Gelegenheit geben, meine Aufrichtigkeit stets aufs Neue zu überprüfen.
Zu Beginn meiner therapeutischen Tätigkeit befürchtete ich unter anderem, dem geistigen Niveau und den vielen Fragen Hochbegabter nicht ausreichend gewachsen zu sein. Und tatsächlich gibt es nicht wenige hochbegabte Kinder, die auf manchen Gebieten über

ein deutlich größeres Wissen verfügen als ich selbst; die mir Fragen stellen, die ich nicht beantworten kann; die mit durchaus überdenkenswerten Vorschlägen für die Testgestaltung aufwarten (etwa: »Warum können wir nicht mit den *schwierigen* Aufgaben anfangen und *dann* zu den leichten gehen?«) oder mich auf Fehler aufmerksam machen, wenn ich anhand eines Modells etwas zu erklären versuche; die auf sehr einfache Fragen mit einer so komplizierten Antwort reagieren, dass ich selbst ins Grübeln komme, ob diese Antwort als richtig oder falsch einzustufen ist.

»Wie viele Tage hat eine Woche?« lautet eine der sehr einfachen Fragen eines Intelligenztests. Mein siebenjähriger Proband antwortet ohne nachzudenken: »168.« Da er sich (wie er anschließend erläuterte) nicht vorstellen konnte, dass eine Testfrage *so* leicht ist, nahm er selbstverständlich an, es werde nach der *Stunden*anzahl einer Woche gefragt. Ich selbst sah mich genötigt, die Aufgabe erst durchzurechnen, bevor ich sie als richtig bewerten konnte (das korrekte Errechnen der Stundenanzahl einer Woche setzt schließlich die Kenntnis der Anzahl der Wochentage voraus). Authentisch zu sein bedeutet in solch einem Moment, die eigene Unsicherheit nicht zu überspielen, sondern zu bekennen, dass der junge Proband im Kopfrechnen deutlich überlegen ist.

Der Therapeut sollte in der Lage sein, auch kritische oder schwierige Fragen mit Anerkennung zu bedenken – selbst wenn er sie zunächst nicht beantworten kann.

›Authentiziät‹ bedeutet weiterhin, dass ich mich auf die *individuelle Wesensart jedes einzelnen Kindes oder Jugendlichen* einstelle, statt nach vorgefassten Verhaltensmustern zu agieren.

Bei eher introvertierten Kindern, die den größeren Teil der Hochbegabten ausmachen, gehe ich innerlich und äußerlich gleichsam zurück. Ich halte Abstand, bestehe nicht auf Blickkontakt, spreche leiser und versuche zu erspüren, in welchem Tempo die Betreffenden auftauen und welche Atmosphäre sie dazu benötigen. Manche Kinder brauchen viel Lob und Ermutigung, andere haben einen feinen Sinn für Humor; wieder andere konzentrieren sich gern vollständig auf die Testaufgaben und äußern sich am liebsten sachlich und knapp.

Im Gespräch mit den Kindern halte ich mich zwar an einen gewissen Fragenkatalog, nehme mir dabei jedoch die Freiheit, Themen

zu vertiefen, welche die Kinder am meisten interessieren. So wird das Gespräch auch für den Therapeuten interessant, was sich wiederum dem Kind vermittelt. Routinemäßiges Abfragen wird auf diese Weise vermieden bzw. auf ein Minimum begrenzt. Zudem sind die Interessen der Kinder oft der beste Schlüssel, um einen guten Kontakt zu ihnen herzustellen.

Für die Beziehungsgestaltung mit Hochbegabten gilt also in besonderem Maße, was für alle Klienten gelten sollte: *Unvoreingenommenheit*, *Einfühlungsvermögen* und *Aufrichtigkeit* sind die wichtigsten Basiskomponenten für ein fruchtbares Vorgehen; der Therapeut muss kritikfähig sein und selbstbewusst genug, eigene Fehler und Schwächen einzuräumen. Und er muss sein Gegenüber, ganz gleich welcher Altersstufe, jederzeit ernst nehmen.

Therapeutisches Vorgehen

Anfangsphase

Hochbegabte Kinder haben oft erstaunlich früh eine Vorstellung davon, was ein Psychologe ist und was Psychotherapie bedeutet. Einige machen im Vorfeld Äußerungen wie: »Ich lasse mir von einem Fremden nicht in die Seele gucken«, »Ich will nicht über meine Probleme reden« oder »Mein Innerstes geht niemanden etwas an«.

Manche Eltern versuchen daher, die Kinder über den eigentlichen Sachverhalt im Unklaren zu lassen und ihnen etwa zu erklären: »Wir gehen jetzt zu einer Dame, die sich ein wenig mit dir unterhalten will und ein paar Spiele mit dir spielt.« Ich habe nicht selten erlebt, dass Kinder auf dem Praxisschild das Wort ›Psychotherapie‹ entzifferten und empört waren, dass man sie getäuscht hatte.

Auch hier gilt, dass man die Kinder so offen wie möglich über den Anlass ihres Kommens aufklären sollte und ihnen nach ein bis zwei Probestunden selbst die Entscheidung überlässt, ob sie wiederkommen möchten. Dadurch fühlen sie sich ernst genommen und in Entscheidungsprozesse mit eingebunden. Gleichzeitig kommt man ihrem Bedürfnis entgegen, genau zu erfahren was sie erwartet.

Die testpsychologische Untersuchung und die therapeutischen Sitzungen finden ohne die Eltern statt. In den ersten Stunden, insbe-

sondere wenn es sich um Probesitzungen handelt und die Kinder sehr unsicher sind, sollte man mit ›psychologischen‹ Fragen nach Gefühlen, Sorgen und Problemen des Kindes zurückhaltend bleiben. Wie wir gesehen haben, brauchen hochbegabte Kinder mehr Zeit, um sich an eine neue Situation zu gewöhnen und Vertrauen zu fassen. Dies gelingt am ehesten, wenn man sich zunächst auf die jeweiligen *Interessensgebiete* des Kindes konzentriert. Hier hat es sich als hilfreich erwiesen, sehr *konkrete* Fragen zu stellen. Auf eher allgemeine Fragen, wie z. B. »Was machst du denn gerne?«, folgt bei Hochbegabten typischerweise eine Gegenfrage: »Was meinen Sie? Was ich in der Schule gern mache, am Nachmittag, in den Ferien? Oder was ich *jetzt* gern machen würde?« Wenn sie besonders schüchtern oder aufgeregt sind, wehren sie eine solche Frage schnell mit »Ich weiß nicht« ab.
Bewährt haben sich Fragen wie: »Von deinen Eltern weiß ich, dass du dich für Astronomie interessierst. Liest du gerade ein Buch darüber? Wovon genau handelt das Buch? Welche Planeten kennst du? Weißt du schon, was du später einmal beruflich machen möchtest?«
Oder: »Ich habe gehört, dass du eine Geschichte schreibst. Worum geht es in der Geschichte?«
Oder: »Welches ist dein Lieblingsfach in der Schule? Beschäftigst du dich auch in der Freizeit damit? Welche Sendungen siehst du am liebsten im Fernsehen? Welches Buch liest du gerade?«

Entscheidend in den Anfangs-Sitzungen ist weniger, dass man direkt auf das jeweilige Problem zusteuert und hierüber möglichst viele Informationen erhält, sondern dass die Kinder *Spaß* an der Stunde haben und merken, dass man sich für sie *interessiert*.

Aufbauphase
Im nächsten Schritt kann man die ermittelten Interessen vertiefen, indem man sich gemeinsam eine Fragestellung zum jeweiligen Sachgebiet ausdenkt, über die Therapeut und Klient sich bis zur kommenden Stunde informieren. So entsteht bereits nach kurzer Zeit eine Atmosphäre, in der *miteinander* gearbeitet, geforscht und getüftelt wird. Dieses Vorgehen erfüllt mehrere Funktionen: Erstens ermöglicht man dem Hochbegabten eine seiner Lieblingsbe-

schäftigungen; zweitens fühlt er sich nicht ausgefragt und ›durchleuchtet‹; drittens respektiert man ihn als ›Experten‹ auf seinem Fachgebiet; viertens wird auf diese Weise zugleich spielerisch und ernsthaft ein guter Kontakt zum Klienten hergestellt; und fünftens dient das Vorgehen als Basis für erste therapeutische Interventionen.

Interventionsphase
Das gezielte therapeutische Vorgehen oder ›Intervenieren‹ hängt von der jeweiligen Problemkonstellation ab. Die drei wichtigsten Problemkreise in der Therapie mit hochbegabten Kindern und Jugendlichen sind: 1. Schulische Probleme und Lernschwierigkeiten, 2. Selbstunsicherheit und depressive Entwicklungen, 3. Schwierigkeiten in sozialen Kontakten. Selbstverständlich gibt es hier viele Überschneidungen und Wechselwirkungen.

Schulische Probleme und Lernschwierigkeiten

Wie ich bereits geschildert habe, bearbeiten die meisten hochbegabten Kinder die Aufgaben der Intelligenztests mit großer Freude. Manche, die zu Beginn lustlos oder sehr zurückhaltend wirken, laufen während des Tests richtiggehend zur Hochform auf; je schwieriger die Aufgaben sind und je konstanter die Kinder gefordert werden, umso eifriger und motivierter arbeiten sie mit. Viele Kinder fragen am Ende der Testung, ob sie wiederkommen dürfen. Eltern berichten im Nachgespräch häufig, dass ihre Kinder nach dem Test besonders fröhlich, lebhaft und ausgeglichen wirken. Dies rührt zum einen daher, dass die Kinder sich endlich einmal voll gefordert fühlen und ihre Potenziale ausdrücken können. Zum anderen kann man bereits die Testung selbst therapeutisch nutzen, indem man als Therapeut etwa sein Erstaunen zum Ausdruck bringt, was der/die Betreffende schon alles weiß, und ihm vermittelt, dass er bereits Aufgaben für deutlich ältere Kinder lösen kann.
In der Nachbesprechung ermuntere ich die Eltern, ihren Kindern die Testergebnisse und das Gutachten zu erläutern (s. Elternberatung).
Gerade bei Kindern, die infolge von Schulschwierigkeiten unter

Selbstzweifeln und Unsicherheit leiden, haben das beschriebene Vorgehen beim Test und die Erörterung der Testergebnisse schon eine stabilisierende Wirkung. Manche älteren Kinder wünschen sich, dass ich selbst ihnen die Ergebnisse erkläre und ihnen Fragen dazu beantworte. Hiermit und der gutachterlichen Empfehlung schulischer Fördermaßnahmen können bereits viele Fälle abgeschlossen werden.

Bei Lern- und Schulschwierigkeiten, die nicht allein auf Unterforderung zurückzuführen sind, müssen zunächst die Ursachen ermittelt werden. Im Zuge der oben geschilderten Aufbauphase können sich hier bereits erste Hinweise ergeben: Gelingt es einem Kind, sich zu konzentrieren und zielgerichtet eine Aufgabe zu verfolgen, wenn es auf einem *Gebiet seines Interesses* arbeitet? Oder neigt es dazu, sich zu verzetteln, abzuschweifen, sich im Detail zu verlieren? Unterschätzt es sich, wirkt es unsicher oder hat es Mühe, sich sprachlich auszudrücken? Macht es viele selbstkritische Äußerungen, gibt es leicht auf und kann es Misserfolge schwer verarbeiten? Arbeitet es auf lobende, anerkennende Äußerungen hin motivierter und selbstsicherer?

Bevor ich den Betreffenden gezielter nach schulischen Problemen frage, erkläre ich ihm anhand eines Modells, dass Hochbegabung in der Regel ›mehr von allem‹ bedeutet: mehr Denken, mehr Fühlen und mehr Wahrnehmen. Ich berichte von Beispielen anderer Kinder, die sich z. B. wenig zutrauen, sich im Klassenzimmer vom hohen Lärmpegel gestört fühlen oder sich bei einfachen Aufgaben zu viele Gedanken machen. Viele Kinder äußern dann bereits: »So ist es bei mir auch.« Andere frage ich, ob ihnen das eine oder andere schon bei sich selbst aufgefallen sei.

Im Hinblick auf ihr Gefühlsleben fällt es hochbegabten Kindern häufig noch schwerer, auf vage formulierte Fragen zu antworten als bei Sachthemen. Will ich etwa wissen: »Wie fühlst du dich dann?«, reagieren viele Kinder ratlos. Daher ist es sinnvoller, die Fragen an konkrete Fallbeispiele zu knüpfen: »Wenn Hochbegabte vor einer einfachen Aufgabe sitzen, geht in ihrem Kopf manchmal alles durcheinander. Ist das bei dir auch so?« Oder: »Manche Kinder sagen im Unterricht lieber gar nichts, als was Falsches zu sagen. Kennst du das von dir auch?«

Auf diese Weise erhalten die Kinder erstens eine Erklärung für

mögliche Schwierigkeiten und verstehen die Zusammenhänge zwischen Hochbegabung und hoher Sensibilität. Zweitens erfahren sie, dass es noch viele andere Kinder gibt, die Ähnliches erleben.

Christoph, acht Jahre, hat *Angst, sich im Unterricht zu melden*. Er ist ein zurückhaltender Junge, der zu einem sehr sachlich-rationalen Denkstil neigt. Er ist entsprechend empfänglich für logische Erklärungen. Wir machen eine kleine Zeichnung, auf der eine Figur am Schultisch sitzt und den Arm hochstreckt.
»Angenommen, dieser Junge bist du. Wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass du eine richtige Antwort gibst, wenn du dich meldest?«
»Vielleicht … sechzig Prozent.«
Christoph notiert die Zahl auf der Zeichnung.
»Gut. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, eine richtige Antwort zu geben, wenn du dich *nicht* meldest?«
Christoph überlegt, sachlich-rational: »Null Prozent.«
Er schreibt die Zahl auf die Zeichnung.
»Das bedeutet: Wenn du dich meldest, hast du ein Risiko von etwa vierzig Prozent, dass es schief geht. Wenn du dich nicht meldest, beträgt das Risiko hundert Prozent.«
Das leuchtet Christoph ein. Ich bitte ihn, den Zettel einzustecken und in den nächsten Schultagen gelegentlich anzusehen. Der sachliche Vergleich hilft ihm, zumindest einzelne Versuche zu wagen, sich im Unterricht zu äußern.

Juliane ist elf und hat *Angst vor Klassenarbeiten*. Ich mache wieder eine einfache Zeichnung, bei der ein Mädchen am Pult sitzt. Über ihr sind mehrere leere Gedankenblasen.
»Als du die letzte Klassenarbeit geschrieben hast, welche Gedanken gingen dir da durch den Kopf?«
»Mir war ganz komisch im Magen und meine Hände haben geschwitzt.«
»Du hattest Angst?«
»Ja, ich dachte, ich schaffe es wieder nicht.«
Ich bitte sie, den Satz in eine Gedankenblase einzutragen.
»Und dann konntest du dich nicht konzentrieren?«
»Nein.«

»Woran dachtest du, als du merktest, dass du dich nicht konzentrieren kannst?«
»Naja, dass ich die Arbeit verhaue.«
Juliane trägt den Satz »Ich werde die Arbeit verhauen« in eine weitere Blase ein.
»Und wenn du dir vorstellst, die Arbeit zu verhauen – woran denkst du dann?«
»Dass ich vielleicht die Klasse wiederholen muss, wenn es so weitergeht; und wenn ich das nicht schaffe, muss ich von der Schule abgehen und auf eine Realschule. Und dann finde ich später keinen Ausbildungsplatz.«
Juliane notiert auch diese Sätze auf den Zettel, bis alle Gedankenblasen ausgefüllt sind. Wir betrachten das Bild eine Weile.
»Du machst dir sehr viele Gedanken, stimmt's?«
»Ja. Ich glaube, *zu* viele.«
»Einerseits ist es gut, viel nachzudenken. Bei einer Klassenarbeit kann es einen aber zu sehr von der eigentlichen Aufgabe ablenken. Welche Gedanken könnten dem Mädchen auf dem Bild *helfen*, sich besser zu konzentrieren?«
Wir fertigen eine neue Strichzeichnung an und erarbeiten sog. *hilfreiche Kognitionen*, das heißt, Juliane trägt nun Sätze ein wie: »Ich mache es, so gut ich kann«, »Ich glaube, ich kann es schaffen« und »Ich bin gut vorbereitet«.
Auch sie steckt die Zeichnung ein und behält sie in den folgenden Wochen bei sich.

Helene, sieben Jahre, ist Perfektionistin und kann *Misserfolge schwer verarbeiten*. Obwohl ihre Eltern sie diesbezüglich in keiner Weise unter Druck setzen, möchte Helene am liebsten nur Einsen schreiben. Wenn sie eine Aufgabe nicht kann, will sie gleich alles hinwerfen und aufgeben. Dies gilt in der Schule ebenso wie zu Hause. Kürzlich fing sie bei einer Klassenarbeit an zu weinen, weil sie die erste von zehn Fragen nicht verstanden hatte. Bei den restlichen Aufgaben war sie so aufgebracht, dass sie mehrere Flüchtigkeitsfehler machte und »nur« eine Drei erhielt. Darüber war sie todunglücklich. Zu Hause bekommt Helene heftige Wutanfälle, wenn sie auf einen Fehler hingewiesen wird oder etwas nicht auf Anhieb kann.

Auch Helene erkläre ich zunächst, dass sie sich in ›guter Gesellschaft‹ befindet und viele andere Hochbegabte ebenfalls gern alles perfekt machen wollen. Ich betone, dass dies einerseits eine lobenswerte und sinnvolle Eigenschaft ist, wenn man hochgesteckte Ziele erreichen will. Andererseits kann ein *überhöhtes* Streben nach Perfektion genau das Gegenteil bewirken: die Leistungen bleiben hinter den eigentlichen Fähigkeiten zurück. Anhand einer kleinen Leistungskurve zeige ich Helene, dass ein ›mittleres Maß‹ an Perfektionismus bzw. Motivation gewöhnlich zu den besten Ergebnissen führt. Auch Helene ist für abstrakte Modelle und logische Erklärungen besonders empfänglich.
Im nächsten Schritt erarbeite ich zusammen mit Helene und ihren Eltern ein Belohnungssystem: Jedes Mal, wenn sie es schafft, einen Misserfolg gut auszuhalten, erhält sie ein Sternchen (Sticker, Steinchen etc.). Wenn sie zehn Sterne gesammelt hat, wird ihr ein Wunsch erfüllt, den sie vorher mit den Eltern besprochen hat, z. B. eine besondere gemeinsame Unternehmung wie ein Kinoabend mit dem Vater oder ein Besuch im Planetarium.
Es kann jedoch auch schon hilfreich sein, Helene immer dann zu loben, wenn sie es nach einem Misserfolg schafft, an einer Sache weiterzuarbeiten. So lernt sie, dass es bereits ein Erfolg ist, mit Misserfolgen gut umgehen zu können.
Grundsätzlich sollten also Therapeuten wie Eltern stets *das erwünschte Verhalten positiv verstärken, statt das unerwünschte Verhalten zu tadeln oder zu bestrafen*.

Julian, zwölf Jahre, braucht bei der *Bearbeitung von Aufgaben oft sehr viel Zeit* und hat manchmal *Denkblockaden*. Wir gehen gemeinsam eine Beispielaufgabe durch. Julian denkt lange nach, kommt aber zu keinem Ergebnis.
Ich frage ihn: »Ist es jetzt in deinem Kopf ganz leer oder ganz voll?«
»Eben war er noch ganz voll, jetzt ist gar nichts mehr drin.«
»Heißt das, es bildet sich zuerst eine Art Gedanken-Knäuel und dann weißt du nicht mehr weiter?«
»Ja, so ähnlich.«
Ich erkläre Julian, dass die meisten Hochbegabten dazu neigen, zu schnell und zu kompliziert zu denken.

»Ich glaube, ich denke auch zu schnell, denn ich hatte eben das Ergebnis schon kurz im Kopf, aber dann wusste ich nicht mehr, wie ich draufgekommen bin, und habe nochmal von vorne angefangen.«
»Das ist eine wichtige Beobachtung. Du könntest einmal probieren, dein Denken auf ›langsamer‹ zu stellen, so wie ein Tonband, das man zu langsam abspielt. Und dann gehst du die Aufgabe Schritt für Schritt durch. So als ob du sie einem jüngeren Kind erklärst. Bitte versuche die Aufgabe jetzt nochmal und denke dabei laut.«
Manche Kinder denken sich eine ›Parole‹ aus (Parole ›lahmer Gaul‹ oder ›Prinzip Schlaftablette‹), die sie im Alltag nutzen können.

Insgesamt achte ich stets darauf, dass die Kinder die Therapiestunden mitgestalten. Viele wünschen sich, dass wir nicht nur ›psychologische Gespräche‹ führen, sondern weiterhin Raum für Knobelaufgaben, Quizspiele oder Diskussionen über ihre Interessen und Sachthemen bleibt. Dies bereitet den Kindern nicht nur Freude, sondern dient auch dazu, ihr Selbstbewusstsein zu stabilisieren und bestimmte Fertigkeiten zu trainieren, z. B. im Hinblick auf Misserfolgsverarbeitung, Konzentration oder Arbeitstempo.

Introversion, Selbstunsicherheit und depressive Entwicklungen

Bei besonders schüchternen, unsicheren oder ängstlichen Kindern stellen die Elternberatung bzw. die Elterngespräche zunächst den wichtigsten Bestandteil der Therapie dar. Mit den dort beschriebenen Empfehlungen an die Eltern kann das Selbstvertrauen eines hochbegabten Kindes langfristig am besten stabilisiert und depressiven Entwicklungen vorgebeugt werden. Letztere sind meist eng mit Zweifeln an den eigenen Fähigkeiten und der eigenen Person verknüpft.
Entscheidend ist, dass sich auch das unsichere, zweifelnde Kind von seinen Eltern angenommen und *in seiner Wesensart respektiert* fühlt. In der Therapie unterstütze ich dies, indem ich mit dem Kind zuerst die *Vorzüge* seiner nachdenklichen und introvertierten Natur bespreche. Dies kann schon in der ersten Sitzung erfolgen,

wenn das Kind ängstlich und verschlossen wirkt: »Dies ist eine neue und ungewohnte Situation für dich. Ich finde es ganz normal, dass du erst mal auf Beobachterposten bleibst und dir in Ruhe einen Überblick verschaffst. Mir selbst geht es manchmal auch so: in einer fremden Umgebung mit neuen Leuten halte ich mich erst mal eine Weile zurück. Ich nehme an, du bist ein sehr guter Beobachter; dir fallen sicher viele Kleinigkeiten auf, die andere gar nicht bemerken. Dafür brauchst du natürlich etwas mehr Zeit.«
Gerade unsichere und schüchterne Kinder fühlen sich bei direkten Gesprächen zu Beginn eher unwohl. Auch bei ihnen kann man ihre Vorliebe für Rätsel- und Wissensspiele nutzen, um ihnen Zeit zu geben, sich an die Situation und den Therapeuten zu gewöhnen.
Im Folgenden erarbeite ich mit den Kindern anhand einer kleinen Zeichnung ein Selbstbild. Um eine Figur herum werden zunächst die Stärken des Kindes notiert. Diese liegen bei schüchternen und unsicheren Kindern zumeist in ihrer genauen Beobachtungsgabe, ihrer guten Wahrnehmung für Details, in vorsichtigem und besonnenem Vorgehen und einem ›gesunden Misstrauen‹ in neuen Situationen. Ebenso gehören Nachdenklichkeit, Sensibilität und Feingefühl, Fähigkeit zur Selbstkritik, Konzentrationsvermögen und Ausdauer sowie Beständigkeit in sozialen Kontakten zu ihren Vorzügen.
Das Selbstvertrauen schüchterner Menschen erwächst also weniger aus dem Erlernen selbstsicherer Verhaltensweisen oder dem Antrainieren sozialer Kompetenzen als vielmehr aus der Akzeptanz der ihnen eigenen Wesenszüge.
Daher bitte ich auch die Eltern, ihr Augenmerk mehr auf das zu richten, was ihr Kind *kann*, statt auf das, was es *nicht* kann. Daraus lassen sich, wie ich bereits gezeigt habe, konkrete Aktivitäten ableiten, die dem Wesen des Kindes und seinen Stärken gerecht werden.
Überdies ist nicht selten ein Elternteil selbst von Schüchternheit und Unsicherheit ›betroffen‹. Der Austausch hierüber mit dem Kind kann außerordentlich hilfreich sein: so kann beispielsweise ein Vater, der selbst unter bestimmten Ängsten oder Selbstzweifeln leidet, dem Kind erklären, wie er damit umzugehen versucht.
In der Kinder- und Jugendliteratur finden sich zudem zahlreiche Schilderungen von schüchternen und ängstlichen Kindern, die

ihren Weg finden und in der Therapie als ›Modelle‹ dienen können (z. B. in der »Unendlichen Geschichte« von M. Ende oder »Hannes Strohkopp« und »Franz mit dem verdammten Hut« von Janosch).

Es ist für Therapeuten oftmals nicht leicht zu entscheiden, wann ein Kind unter einem behandlungsbedürftigen Mangel an Selbstvertrauen oder unter den ›ganz normalen‹ Selbstzweifeln eines Hochbegabten leidet; wann die Schüchternheit, Zurückhaltung und Empfindsamkeit eines Kindes seinem für Hochbegabte typischen Naturell entsprechen und wann diese Merkmale Züge einer depressiven Entwicklung annehmen; ob die starken Gefühlsschwankungen Ausdruck eines seelischen Leidens oder nur Teil der ganz normalen hochbegabten Persönlichkeit sind. Es gilt daher folgende Fragen zu beachten: Von *wem* wird das Kind als depressiv, verhaltensauffällig oder selbstunsicher bezeichnet? Kommen die Eltern aufgrund einer ›Diagnose‹ von Erzieherinnen oder LehrerInnen? Oder sind es die Eltern selbst, die Mühe haben, mit der großen Sensibilität und den lebhaften Gefühlsäußerungen umzugehen? Erschien das Kind schon von klein auf besonders zartfühlend und zurückhaltend oder gab es einen Knick in der Entwicklung, ein auslösendes Ereignis? In welchen Situationen oder Phasen erscheint das Kind *nicht* bedrückt, sondern fröhlich und ausgeglichen? Möglicherweise können die Beantwortung dieser Fragen und eine eingehende Elternberatung schon eine Reihe von Perspektiven eröffnen.
Wirkt das betreffende Kind dennoch über einen längeren Zeitraum und in unterschiedlichen Situationen bedrückt, traurig, niedergeschlagen und antriebslos, ist der Beginn einer depressiven Entwicklung wahrscheinlich. Die Ursachen sind bei Hochbegabten häufig schulische Unterforderung, mangelnde Akzeptanz in der Familie oder Gefühle der Isolation und Schwierigkeiten in sozialen Kontakten.
Auch bei depressiven Störungen erkläre ich den Kindern den Zusammenhang zwischen hoher Intelligenz und hoher Sensibilität. Ich berichte von anderen Hochbegabten, die traurige Gefühle ebenfalls besonders intensiv erleben; gleichzeitig mache ich deutlich, dass starke Gefühle auch einen großen Gefühls*reichtum* be-

deuten, und führe bedeutende Künstler an, die aus diesem Reichtum Kraft für ihre kreativen Werke schöpften. Ich ermutige die Kinder, ihre starken Gefühle auszudrücken, indem sie malen, Geschichten schreiben, musizieren oder Theater spielen. Auf diese Weise werden ihre Stärken und Begabungen gefördert und Erfolgserlebnisse geschaffen.

Schwierigkeiten in sozialen Kontakten

Viele Ansätze zur Linderung sozialer Probleme und Schwierigkeiten ergeben sich bereits aus den vorangegangenen Schilderungen: Wenn ein hochbegabtes Kind sich kennt und anerkennt, wenn es über die Besonderheiten der Hochbegabung informiert wird, wenn man seine Begabungen fördert und ihm Kontakte zu ähnlich Begabten ermöglicht, kann es seine sozialen Fähigkeiten am besten entfalten. Auch hier stellt die Umsetzung der Empfehlungen zur Elternberatung den wichtigsten Teil der Therapie dar.

Zunächst gilt es sorgfältig zu unterscheiden, ob das *Kind* soziale Probleme mit seinem Umfeld oder das *Umfeld* Probleme mit dem Kind hat.

In den so genannten Kopfnoten von Schulzeugnissen wird zum Beispiel das Sozialverhalten der Schüler bewertet. Oftmals wird dabei jedoch das Verhalten des Kindes gegenüber dem Lehrer/der Lehrerin beurteilt. Stellt eine Schülerin etwa häufig unbequeme Fragen, hinterfragt sie Regeln, hält sich nicht an vorgegebene Arbeitsanweisungen und beharrt auf eigenen Vorstellungen, wirkt sich das gewöhnlich negativ auf die Bewertung ihres Sozialverhaltens aus. Mangelt es in diesem Fall der Schülerin oder der Lehrkraft an dem, was gemeinhin unter sozialer Kompetenz verstanden wird?

Verhält sich ein Schüler unangepasst, arbeitet er lieber alleine oder unterhält keine engeren Kontakte zu seinen Mitschülern, liegt dies nicht zwangsläufig an seinen unzureichenden sozialen Fähigkeiten; möglicherweise kann oder will er sie nur in einem bestimmten Umfeld nicht entfalten. Im Übrigen ist Anpassung nicht notwendigerweise ein Zeichen sozialer Kompetenz. Solche Überlegungen lassen sich durchaus auch mit den Kindern selbst erörtern.

Wenn Eltern mich wegen sozialer Schwierigkeiten ihres Kindes aufsuchen, frage ich zuerst nach Situationen, in welchen diese Schwie-

rigkeiten *nicht* auftauchen. Oft lauten die Antworten: »Wenn unser Sohn mit älteren Kindern zusammen ist oder sich mit Erwachsenen unterhält«; »wenn unsere Tochter mit ihren Geschwistern spielt«; »bei Aktivitäten mit anderen Hochbegabten«.
Auch in den Sitzungen mit dem betreffenden Kind kann ich oft keinerlei Hinweise auf Defizite im Sozialverhalten ausmachen, sodass ich davon ausgehen muss, dass diese nur unter *bestimmten Bedingungen* zum Ausdruck kommen. In solchen Fällen empfiehlt es sich also, das jeweilige Umfeld näher in Augenschein zu nehmen und nach Möglichkeit mehr von solchen Bedingungen zu schaffen, die dem Kind die Entfaltung seiner sozialen Begabungen ermöglichen. Dies kann durch das Überspringen einer Klasse, den Wechsel auf eine geeignete Schule, die Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften mit älteren SchülerInnen oder die Aufnahme von Kontakten zu anderen Hochbegabten erfolgen.

Wird ein hochbegabtes Kind massiv ausgegrenzt und ist von so genanntem »Mobbing« betroffen, ist eine Beratung oder Psychotherapie nicht ausreichend. Auch in diesem Fall ist es nicht allein das Kind, das behandelt, geändert oder gestärkt werden muss. Die eingehende Erörterung der spezifischen und komplexen Thematik des »Mobbing« würde daher den Rahmen des vorliegenden Bandes sprengen. Hier sind Eltern und vor allem Pädagogen gefordert, mit geeigneten Maßnahmen Abhilfe zu schaffen. Empfehlenswerte Ratgeber hierzu sind etwa von Alexander (1999), Dambach (1998), Jost (1999) oder Wittmann & Holling (2001) erschienen.

Bei Kindern, die bereits viele schlechte Erfahrungen in sozialen Kontakten machen mussten und sich daher auch in einer ›passenden‹ Umgebung unsicher und ängstlich fühlen, können Rollenspiele und Vorstellungsübungen hilfreich sein.

Florian ist zehn Jahre alt und hat *Angst vor Gruppensituationen* jeglicher Art. Er fürchtet, gehänselt, verspottet oder angegriffen zu werden. Ich frage ihn: »Was geht dir durch den Kopf, wenn jemand dich hänselt?«
»Es ist peinlich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe Angst.«
»Es ist ein schlimmes Gefühl.«

»Ja. Ich würde am liebsten davonlaufen.«
»Wovor genau hast du Angst, wenn jemand etwas Gemeines zu dir sagt?«
»Dass ich dumm dastehe.«
»Das ist schwer auszuhalten. Du hast Angst, die anderen könnten dich lächerlich finden?«
»Genau.«
»Kennst du noch andere Kinder, die gehänselt werden?«
»Ja, einige. Viele sogar.«
»Du bist also nicht der Einzige.«
»Nein, die machen das fast alle, sich gegenseitig hänseln.«
»Und kennst du jemanden, einen Jungen oder ein Mädchen, der es ganz gut aushalten kann, wenn er verspottet wird?«
Florian überlegt. »Ja, zum Beispiel der Tim. Dem macht es gar nichts aus.«
»Was meinst du, wie Tim es macht, es besser auszuhalten?«
»Der steckt es weg.«
»Was genau tut er?«
»Er sagt ein Schimpfwort oder ›halt die Klappe‹ und geht weg.«
»Also: Es ist schlimm, wenn man geärgert wird, aber es ist grundsätzlich möglich, es wegzustecken. Siehst du das auch so?«
»Ich glaub schon.«
»Wir denken uns jetzt in der Fantasie einen Jungen aus, der Ärger so gut wegstecken kann, wie du es gern würdest. Wie nennen wir den Jungen?«
Florian gibt dem Jungen einen Namen (Mick); er beschreibt mir, wie Mick sich in Streit- und Konfliktsituationen verhalten würde. Auf einer Tafel notieren wir die Gedanken und Sätze, die Florian in Konfliktmomenten durch den Kopf gehen, z. B. »ich muss hier weg«; »das halte ich nicht aus«; »ich stehe dumm da«; »alle haben was gegen mich«. Daneben listen wir die Gedanken und Sätze auf, mit denen Mick sich Mut macht, z. B. »ich stehe das durch«; »ich kann mich wehren«; »ich bin stark genug, es auszuhalten«; eine einfache Zeichnung von Mick und seinen ›Mutmach-Sätzen‹ nimmt Florian nach Hause mit. In den folgenden Sitzungen konstruieren wir in Vorstellungsübungen verschiedene schwierige Situationen; Florian beschreibt, wie Mick sich in diesen Situationen verhält und sie erfolgreich meistert. Mit Kindern, die gerne schreiben, kann

man eine fortlaufende Geschichte erfinden, an der sie zu Hause und in der Therapie arbeiten. Auf diese Weise mobilisieren sie ihre eigenen mutigen und starken Seiten.
Zudem erzähle ich Florian konkrete Fallbeispiele von anderen Kindern, die ihre Ängste überwinden konnten. Und ich stelle mich selbst als ›Modell‹ zur Verfügung, indem ich etwa eingestehe, dass ich immer etwas aufgeregt bin, wenn ich vor größeren Gruppen sprechen oder einen Vortrag halten muss. Besonders wirksam ist es, wenn Eltern ihren Kindern berichten, wie sie selbst mit Ängsten und Schwierigkeiten umgehen oder welche diesbezüglichen Erfahrungen sie in ihrer Kindheit und Jugend machten.

Andere Störungsbilder

Seit einiger Zeit häufen sich Fragen zu weiteren Störungsbildern, die möglicherweise im Zusammenhang mit Hochbegabung auftreten, so z. B. die Aufmerksamkeits-Defizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) oder Essstörungen wie Anorexia nervosa (Magersucht) und Bulimie.
Hallowell & Ratey (1999) weisen darauf hin, dass ADHS-Patienten häufig überdurchschnittlich intelligent und kreativ seien. Auch Rossi (2001) erwähnt, dass bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit ADHS oftmals eine überdurchschnittliche Intelligenz festgestellt wird. Es gibt jedoch bislang keine empirischen Studien, die untersuchen, wie häufig ADHS bei Personen mit einem IQ ab 130 vorkommt. Hyperaktives, ruheloses Verhalten von unterforderten Hochbegabten könne allerdings, so Rossi (2001), fälschlicherweise als Symptom einer ADHS-Störung diagnostiziert werden. Auch Scheidt (2004) merkt an, dass die geistige Unruhe und Sprunghaftigkeit vieler Hochbegabter zu ADHS-ähnlichen Symptomen führen kann.
In dem Buch »Ist mein Kind hochbegabt?« (Mähler & Hofmann, 1998) wird eine Checkliste vorgegeben, die vorab helfen kann, hochbegabte von hyperaktiven Kindern zu unterscheiden. In der Praxis und im Schulalltag stellt sich die Differenzierung zwischen Symptomen der Hyperaktivität und der Hochbegabung oftmals sehr schwierig dar und bedarf aufgrund vieler Ähnlichkeiten und Überschneidungen (Konzentrationsprobleme, motorische Unruhe,

Schwierigkeiten in sozialen Kontakten, vielseitige Interessen, Ungeduld, Impulsivität etc.) einer umfassenden und sorgfältigen psychologischen Diagnostik.
In einigen wenigen Fällen kommt es vor, dass ein Kind bzw. Jugendlicher tatsächlich zugleich hochbegabt ist *und* an einer Aufmerksamkeits-Defizit-Störung (ADHS) leidet. Wie häufig dies auftritt und welche besonderen Verhaltensmerkmale hochbegabte Kinder mit ADHS aufweisen, wird derzeit erforscht. Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass ADHS unter Hochbegabten etwa ebenso häufig vorkommt wie unter Normalbegabten (etwa 4 %). Dies deckt sich nicht gänzlich mit den Ergebnissen meiner testdiagnostischen Untersuchungen: Von rund 700 getesteten Kindern wurden bei nur sechs Kindern zugleich eine Hochbegabung und das Vorliegen einer Aufmerksamkeits-Defizit-Störung diagnostiziert. In solchen Fällen empfehle ich eine gezielte ADHS-Diagnostik und therapeutische Behandlung durch Kollegen, die auf diesem Gebiet spezialisiert sind. Geeignete Fördermaßnahmen im Hinblick auf die Hochbegabung greifen in der Regel erst im Verlauf einer erfolgreichen ADHS-Therapie.
Auch bei Patientinnen mit Essstörungen (Anorexia und Bulimia nervosa) gibt es vereinzelt Hinweise auf eine überdurchschnittlich hoch ausgeprägte Intelligenz: Walitza et al. (2001) zeigten in einer Studie, dass die Probandinnen IQ-Werte im überdurchschnittlichen Bereich (mittlerer Gesamt-IQ 117,6) erzielten. Empirische Belege für eine Häufung von Hochbegabten (ab IQ 130) bei essgestörten Patientinnen liegen meines Wissens derzeit jedoch nicht vor.
Zu diesen interessanten Fragestellungen stehen also weitere Forschungen noch aus.

Therapie mit hochbegabten Jugendlichen

Die therapeutische Arbeit mit hochbegabten Jugendlichen folgt im Wesentlichen den gleichen Grundprinzipien wie mit hochbegabten Kindern. Jugendliche haben jedoch häufig noch größere Vorbehalte, einen Therapeuten aufzusuchen. Wenn sie sich dennoch dazu bereit erklären, sind sie zu Beginn oft sehr verschlossen, unwillig und provozierend.
»Ich hoffe, Sie kommen mir jetzt nicht mit irgendwelchem Psycho-

Scheiß«, eröffnet der vierzehnjährige Thomas in der ersten Sitzung das Gespräch.
Ich muss lachen und antworte: »Davon hast du offensichtlich genug.«
»Kann man so sagen.«
»Ich werde mein Möglichstes tun. Hast du Erfahrungen mit Psychotherapie?«
»Nein, aber meine Mutter labert mich die ganze Zeit mit dem Mist voll.«
»Ist sie psychologisch ausgebildet?«
»Nein. Hobby-Psychologin.«
»Schweres Los. Trotzdem bist du hergekommen?«
»Hm.«
»Es war nicht deine Idee.«
»Richtig.«
»Deine Mutter hat dich gezwungen.«
»Mehr oder weniger.«
»Du bist fast erwachsen. Wie ist es ihr gelungen, dich dazu zu zwingen?«
»Sie hat dauernd auf mich eingeredet, und ich wollte, dass sie endlich Ruhe gibt.«
»Das heißt, du hast überhaupt kein psychisches Problem. Aber deine Mutter will dir das einreden?«
»Exakt.«
»Also hat deine Mutter ein Problem, nicht du.«
»Sie haben es erfasst.«
»Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten: Entweder du stehst auf und gehst wieder nach Hause. Dann wird deine Mutter weiter auf dich einreden. Oder du schilderst mir das Problem deiner Mutter aus deiner Sicht, und ich werde sehen, ob ich mit ihr sprechen kann.«
Thomas taxiert mich schweigend. Nach einer Weile fragt er:
»Ich könnte wieder gehen?«
»Selbstverständlich. Wozu sollen wir eine Therapie machen, wenn du kein Problem hast?«
»Ihr Therapeuten seid doch alle gleich. Sie wollen mich nur hinters Licht führen.«
»Du lässt dir nichts vormachen. Also gut, es stimmt: Natürlich

würde es mich interessieren, mehr von dir zu erfahren. Aber ich meine es ernst, die Entscheidung liegt bei dir.«
Thomas überlegt. »Wir reden über das Problem meiner Mutter?«
»Nur darüber.«
Thomas ist einverstanden. Ich halte mein Versprechen, und in den folgenden Sitzungen kommt ein zunehmend guter Kontakt zustande.

Beim Versuch zu beschreiben, welche ›Komponenten‹ ich in einem solchen Dialog beachte, befällt mich immer ein gewisses Unbehagen. Auch hier ist die *Haltung* entscheidend und nicht so sehr die *Methode*. Es soll nicht der Eindruck entstehen, als wolle ich bestimmte ›Tricks‹ anwenden oder ›Köder‹ benutzen, um einen jugendlichen Klienten in der Therapie zu halten. Andererseits will ich gerne gestehen, dass mir die Arbeit mit widerspenstigen Jugendlichen besonders viel Freude macht, weil sie mir seismographisch genau eigene Unzulänglichkeiten widerspiegeln: Erlaube ich mir die kleinste Unaufrichtigkeit oder gar Überheblichkeit, werde ich unmittelbar entlarvt; fühle ich mich persönlich angegriffen oder gekränkt, bricht der Klient den Kontakt möglicherweise schnell ab; lasse ich mich zu sehr von therapeutischem Ehrgeiz leiten oder gehe zu offensiv vor, zieht der Betreffende sich zurück.
Im oben beschriebenen Dialog habe ich also, mehr oder weniger intuitiv, folgende Punkte beachtet: Ich reagiere auf Thomas' angriffslustiges Verhalten mit Humor und Verständnis. Ich gehe ausschließlich auf das ein, was er sagt, und dränge ihn nicht zu anderen Stellungnahmen. Ich weise darauf hin, dass er beinahe erwachsen und selbst in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen. Ich gestehe ein, dass er meine Absichten durchschaut. Ich mache deutlich, dass ich an seiner Person interessiert bin. Und ich bin bereit, *seine* Vorgaben zu respektieren.

Manche hochbegabte Jugendliche weigern sich standhaft, *irgendeine* Form von Aktivität oder Kontakt aufzunehmen. Sie verschanzen sich hinter ihrem Computer, verbringen die meiste Zeit alleine und sind für jedweden Vorschlag von Erwachsenen unzugänglich. Daher sammle ich nach Möglichkeit E-Mail-Adressen von kontaktwilligen Hochbegabten und gebe sie (die Adressen) an andere

Jugendliche weiter; oder ich frage nach, ob sie einverstanden sind, wenn sich ein Jugendlicher in ähnlicher Situation per E-Mail bei ihm meldet. Diese zeitgemäße Form der Kontaktaufnahme hat bereits manchem sehr schüchternen und PC-begeisterten Jugendlichen geholfen, sich mit anderen austauschen zu können, *ohne* dass er sich dafür zunächst an einen anderen Ort bewegen muss.

Drei besondere Fälle

In den folgenden Fallbeispielen geht es nicht darum zu zeigen, mit welchen dramatischen Entwicklungen Eltern hochbegabter Kinder bzw. Jugendlicher zwangsläufig zu rechnen haben. Es sollen hier jedoch auch diejenigen Betroffenen angesprochen werden, die sich in scheinbar ausweglosen Situationen befinden. Zugleich sollen Therapeuten, die etwa mit Schul- oder sozialen Schwierigkeiten von Kindern und Jugendlichen konfrontiert werden, für die spezifische Problematik Hochbegabter sensibilisiert werden, sodass eine Begabungs-Diagnostik in bestimmten Fällen zumindest in Betracht gezogen wird.

Andreas ist fast fünfzehn Jahre alt und hat seit vier Jahren keine Schule mehr besucht. Seine Eltern stehen in Verhandlungen mit dem Schulamt und Jugendamt sowie mit Schulpsychologen und Psychiatern. Andreas' Einweisung in die Psychiatrie konnten die Eltern bislang verhindern, was für hiesige Verhältnisse ungewöhnlich ist. Andreas erhält von einem Hauslehrer Privatunterricht.
Mit Beginn des vierten Schuljahres weigerte sich Andreas zunehmend hartnäckig, in die Schule zu gehen. Er klagte morgens über Bauchschmerzen und Übelkeit und kam bedrückt und niedergeschlagen nach Hause. Gleichzeitig besuchte Andreas seit seinem fünften Lebensjahr aus eigenem Antrieb täglich einen nahe gelegenen Bauernhof, wo er sich mit dem Bauern anfreundete, ihm zur Hand ging, anspruchsvolle Pflichten übernahm, sich viele Kenntnisse über Tierhaltung und Landwirtschaftstechnik aneignete und sich schließlich für den Hof unentbehrlich machte.
Zur Mitte des vierten Schuljahres wehrte Andreas sich morgens so heftig und verzweifelt, in die Schule zu gehen, dass seine Eltern sich nicht anders zu helfen wussten, als ihn krankschreiben zu lassen. Er

lehnte es ab, mit seinen Eltern oder mit Psychologen über die Gründe für seine Schulverweigerung zu sprechen. Vermutlich wusste er sie selbst nicht oder konnte sie nicht benennen. Alle weiteren Versuche, Andreas zum Schulbesuch zu bewegen, schlugen fehl.
Nach einer langen Odyssee bei verschiedenen Ärzten, Psychiatern und Schulpsychologen schilderten mir die Eltern im Erstgespräch die Situation ihres Sohnes. Anschließend kam Andreas alleine zu mir. Er war freundlich, aufgeschlossen und hatte ein natürliches, ansprechendes Wesen. Sein sprachliches Ausdrucksvermögen und seine sozialen Fähigkeiten waren ungewöhnlich weit entwickelt. Zu schulischen Themen befragt, wirkte Andreas ablehnend und nahezu blockiert; auch mir gegenüber wollte oder konnte er sich nicht zu den Gründen für seine Schulverweigerung äußern. Ich respektierte seinen Wunsch und entschied, ihm von Kindern und Jugendlichen zu berichten, die sich in einer ähnlichen Situation befanden wie er. Andreas hörte mir lange und aufmerksam zu, als ich ihm erzählte, wie hochbegabte Kinder die Schule oft erleben und welche Erfahrungen sie dort machen: dass sie Sinneseindrücke meist besonders intensiv erleben und auf Auseinandersetzungen sehr sensibel reagieren; dass sie sich ›anders‹ als die anderen fühlen und sich im Unterricht manchmal so sehr langweilen, dass sie sich nicht mehr konzentrieren können; und dass einige schließlich das Gefühl haben, sie seien unfähig zu lernen oder überhaupt etwas zu leisten. Andreas hat diese Schilderungen nicht kommentiert. Er willigte jedoch ein, einen Intelligenztest zu machen. Dieser ergab in den Aufgaben zum mathematischen, technischen, räumlich-visuellen und konstruktiven Denken IQ-Werte über 140 Punkte (oberer Extrembereich). Die ›Verdachtsdiagnose Hochbegabung‹ hatte sich also bestätigt. In den stärker bildungsabhängigen Aufgaben erzielte Andreas niedrigere Werte, was nicht verwunderlich war angesichts der Tatsache, dass er seit Jahren nicht mehr zur Schule ging.
Die Vermittlung der Testergebnisse und der Informationen über die mit einer Hochbegabung einhergehenden Besonderheiten bewirkte sowohl bei Andreas als auch bei seinen Eltern eine deutliche Stabilisierung des Selbstbewusstseins.
Ein behutsamer Ausbau von Andreas' intellektuellen Fähigkeiten und sozialen Kompetenzen, die Ermittlung seiner Interessen und

Zukunftspläne sowie eingehende Beratungsgespräche mit den Eltern trugen schließlich dazu bei, dass Andreas den Mut aufbrachte, eine Fachschule für Landwirtschaft zu besuchen, die er in Kürze abschließen wird. Auch ist es ihm gelungen, einzelne Kontakte zu (deutlich älteren) Mitschülern aufzubauen.

Johannes war von klein auf ein besonders feinfühliger, schüchterner und ruhiger Junge. Seine Grundschulzeit durchlief er ohne Auffälligkeiten; er war ein stiller Schüler, der sich nur schwer mit anderen Kindern anfreundete und wenig sprach. Er beteiligte sich selten am Unterricht, erbrachte jedoch durchgehend sehr gute schriftliche Leistungen. Nach dem Wechsel aufs Gymnasium und mit Beginn seiner Pubertät zog Johannes sich immer mehr zurück, weigerte sich, zur Schule zu gehen, verbrachte Tage und Wochen im abgedunkelten Zimmer, hörte auf zu sprechen und nahm nur noch wenig Nahrung zu sich. Seine Eltern waren in größter Sorge und stimmten schließlich einer Einweisung in die Psychiatrie zu. Hier ergaben routinemäßig erhobene Befunde unter anderem einen Gesamt-Intelligenzquotienten von 141 Punkten. Weitere Beratungen und Hinweise zur Hochbegabten-Thematik oder die Empfehlung von Fördermaßnahmen erfolgten jedoch nicht. Insgesamt hatte Johannes über drei Jahre (außer gelegentlich mit seinen Eltern) mit fast niemandem mehr gesprochen. Auch mit mir wollte er nicht reden, war jedoch bereit mir zuzuhören. Es war, wenn ich mich recht entsinne, meine einzige therapeutische Behandlung, in der ausschließlich ich selbst sprach. Ich erklärte Johannes in mehreren Sitzungen alles, was er über Hochbegabung wissen musste, sowohl das Denken, das Fühlen und die Wahrnehmung betreffend als auch die möglichen schulischen und sozialen Probleme. Johannes sah mich die meiste Zeit nicht an, schien meinen Ausführungen aber aufmerksam zu folgen. Ich erzählte von anderen Jugendlichen, die sich in einer ähnlich verzweifelten Lage befinden, und von kritischen Phasen, die ich selbst während meiner Schulzeit erlebt hatte. Manchmal nickte er, wenn ich ihn fragte, ob er diese oder jene Erfahrung selbst kenne; während einiger Schilderungen sah er sehr traurig aus und kämpfte mit den Tränen. Er antwortete mir also auf seine Weise, und ich ging auf seine Reaktionen ein.
Nach der vierten Sitzung wollte Johannes nicht mehr wiederkom-

men, ohne sich zu den Gründen zu äußern. Die Eltern berichteten mir, dass eine erneute Einweisung in die Psychatrie in absehbarer Zeit unvermeidbar sei. Daher nahm ich Kontakt zu einer hochbegabten Musiktherapeutin auf, von der ich wusste, dass sie in ihrer Jugend eine ganz ähnliche Phase durchgemacht und viel Erfahrung mit autistischen Kindern und Jugendlichen hatte. Ich erzählte ihr von Johannes, und sie war sofort einverstanden, sich mit ihm in Verbindung zu setzen. Zunächst beschrieb sie ihm in einem Brief, was sie als junges Mädchen erlebt hatte und wie es zu ihrem Rückzug gekommen war; sie bekundete ihr Interesse, Johannes kennen zu lernen und sich mit ihm auszutauschen. Dazu erklärte er sich nach einem Briefwechsel und einigen Telefonaten bereit. Über diesen Kontakt gelang es Johannes allmählich, seine Isolation aufzubrechen und sein Selbstvertrauen wiederzufinden. Er hat heute einige wenige beständige Freundschaften und kürzlich eine Berufsausbildung abgeschlossen. Ein freundschaftlicher Kontakt zu der Musiktherapeutin besteht bis heute.
Im Fall von Johannes war es also notwendig, einen unkonventionellen Weg zu beschreiten; man sollte sich als Therapeut nicht scheuen, bei ungewöhnlichen Fällen ungewöhnliche Lösungen zu versuchen, statt die Therapie als gescheitert abzubrechen. Dieses Beispiel zeigt erneut, wie hilfreich und entscheidend der Kontakt zu anderen Hochbegabten sein kann, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben.

Lilo ist dreizehn, als ihre Eltern erstmals meine Praxis aufsuchen und mir Folgendes berichten: Lilo sei frühreif, ihre Pubertät habe bereits mit zehn Jahren eingesetzt und sie sei in jeder Hinsicht weit entwickelt. Mit Beginn der fünften Klasse des Gymnasiums hätten sich Lilos schulische Leistungen drastisch verschlechtert. Sie habe die Schule geschwänzt, sich im Unterricht demonstrativ gelangweilt und die Lehrer mit aufsässigem, provokativem Verhalten gegen sich aufgebracht. Lilo habe am Morgen nicht mehr aufstehen wollen, sei immer unzugänglicher geworden und habe keinerlei Vereinbarungen mehr eingehalten. Oft sei sie nach Mitternacht nach Hause gekommen, habe Alkohol und Marihuana konsumiert und sich einer Gruppe deutlich älterer Jugendlicher angeschlossen. Lilo habe die Rechte einer Sechzehnjährigen eingefordert, dies-

bezügliche Diskussionen oder Strafmaßnahmen hätten regelmäßig in heftigem Streit geendet. Aufgrund ihres Drogenkonsums und zahlreicher Regelverstöße sei Lilo innerhalb von drei Jahren von zwei Schulen verwiesen worden.

Lilo wuchs in einer angesehenen Arztfamilie auf und hatte zwei ältere Geschwister, die keine schulischen oder privaten Probleme hatten. Ein Bekannter hatte ihre Eltern darauf hingewiesen, dass Lilo möglicherweise hochbegabt sein könnte. Sie nahm bereitwillig an einem Intelligenztest teil, und das Ergebnis bestätigte die Vermutung. Darüber freute Lilo sich sehr. Im Gespräch mit Lilo zeigte sich, dass sie mit ihrer Lebenssituation selbst sehr unzufrieden war: »Ich nehme mir jeden Tag vor, mich jetzt endlich zu bessern, aber ich schaffe es einfach nicht. Es ist mir so zuwider, in die Schule zu gehen, dass ich mich oft einfach nicht überwinden kann. Ich weiß, dass ich mir meine Zukunft verbaue, wenn ich so weitermache. Mich ödet alles so sehr an, die Schule, die Lehrer, sogar meine Freunde und das Kiffen öden mich an. Am meisten öde ich mich selbst an; ich weiß nichts mit mir anzufangen, mir fehlt … der Antrieb, eine Aufgabe, etwas, das mich reizt. Ich bin total unzufrieden mit mir und frage mich dauernd, wie es weitergehen soll.«

Nach den Schilderungen ihrer Eltern hatte ich nicht erwartet, dass Lilo sich so offen und reflektiert über sich selbst äußern würde. Es hatte fast den Anschein, als hätte sie nur darauf gewartet, dass endlich eine Änderung in ihrem Leben eintritt. Nach der Erörterung der Testergebnisse beschloss sie mit ihren Eltern, ein Internat für Hochbegabte in Schottland zu besuchen. Dort änderten sich Lilos Einstellung zur Schule und ihr seelisches Befinden innerhalb kürzester Zeit: Sie gewann Abstand von ihrem ehemaligen Umfeld und fühlte sich von ihren Lehrern und Mitschülern gut aufgenommen; sie wurde aufgeschlossener, ausgeglichener und selbstbewusster. Zu unser aller Erstaunen war bei Lilo keine weitere Therapie notwendig. Ihre Eltern berichteten mir in größeren Abständen von Lilos durchweg positiver Entwicklung. Vor kurzem legte sie im Alter von siebzehn Jahren ihr Abitur ab und beginnt nun ihr Studium.

Nur wenige Familien können ihrem Kind den Besuch eines Hochbegabten-Internats im Ausland ermöglichen. Dennoch zeigt Lilos Fall, welch heilsame Auswirkungen eine geeignete Begabtenförderung haben kann.

2. Autistische Störungen

Der Paradoxie des Lebens ist keine Regel gewachsen. *C. G. Jung*

Zu Beginn dieses Kapitels stellte ich die Frage, ob es klinische Störungsbilder gibt, die erst dann gänzlich verstanden und adäquat behandelt werden können, wenn man den Aspekt der Hochbegabung und der damit verbundenen erhöhten geistigen, emotionalen und sensorischen Erregbarkeit mit in Betracht zieht.
Eine Vielzahl von Beobachtungen und Erhebungen während meiner Arbeit mit Hochbegabten veranlasste mich, folgenden Fragen nachzugehen: Könnten autistische Syndrome ein für Hochbegabte *spezifisches* Störungsbild sein? Und wäre ein *wesentliches gemeinsames Merkmal* die neuronale Übererregbarkeit, welche sich in *Überaktivität des Denkens*, *emotionaler Hypersensibilität* und *Überempfindlichkeit der sinnlichen Wahrnehmung* äußert?
Da autistische Störungen als besonders schwer behandelbar bzw. unheilbar gelten, möchte ich mich mit diesen Fragen ausführlich befassen. Möglicherweise bieten sich hierbei einige Erklärungsansätze oder Hypothesen zur weiteren Autismusforschung. Zudem verdienen die hoch interessanten autistischen Persönlichkeiten meines Erachtens besondere Aufmerksamkeit.
Es geht hier keineswegs darum, Hochbegabte mit schweren psychischen Störungen in Verbindung zu bringen, sondern ganz im Gegenteil *Menschen mit bestimmten psychischen Störungen unter dem Blickwinkel einer möglichen Hochbegabung zu betrachten*.
Es ist zu erwarten, dass meine Überlegungen bei vielen Fachkollegen auf Irritation und Widerspruch stoßen. Diesbezüglich hoffe ich auf einen fruchtbaren Austausch, der gegebenenfalls Anstoß zu weiterführenden empirischen Untersuchungen gibt.
Äußerte ich bislang in Gegenwart von Kollegen Überlegungen zu einem möglichen Zusammenhang zwischen autistischen Phänomenen und denen der Hochbegabung, reagierten viele in ablehnender, missbilligender oder gar empörter Weise. Es schien, als würde hier eine Art Tabu berührt. Die Kommentare der Kollegen lauteten übereinstimmend: »Autismus ist eine *schwer wiegende* Entwicklungsstörung und geistige *Behinderung*! Es mag Einzelne mit spe-

ziellen Begabungen geben, aber mit Hochbegabung lässt sich dies keinesfalls in Verbindung bringen.«
Ich kann diese Auffassung nicht widerlegen, aber ich möchte schildern, was mir in der Arbeit mit Hochbegabten und im Kontakt mit Autisten sowie dem eingehenden Studium der gegenwärtigen Fachliteratur zu autistischen Störungen aufgefallen ist.

Definition

Laut dem Handbuch zur Internationalen Klassifikation psychischer Störungen (ICD-10) handelt es sich bei Autismus um »eine tief greifende Entwicklungsstörung, charakterisiert durch eine gestörte Funktionsfähigkeit (…) der sozialen Interaktion und Kommunikation sowie durch eingeschränktes, repetitives Verhalten«. Diese Störungen zeigen sich in der Regel vor Vollendung des dritten Lebensjahres (1993, S. 282).

Die Hauptmerkmale einer autistischen Störung werden wie folgt beschrieben:

- unangemessene Einschätzung sozialer und emotionaler Signale; Fehlen sozialer und emotionaler Gegenseitigkeit
- Fehlen des Gebrauchs vorhandener sprachlicher Fertigkeiten
- sich wiederholende stereotype Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten; besondere Bindung an ungewöhnliche Objekte (z. B. Murmeln, Kästchen)
- Widerstand gegenüber Veränderungen, auch bzgl. Details im Tagesablauf oder der persönlichen Umgebung; auch: Befürchtungen, Phobien, Schlaf- und Essstörungen, Wutausbrüche, Aggressionen, Selbstverletzung
- Schwierigkeiten bei der Entscheidungsfindung (auch wenn die Aufgaben an sich bewältigt werden können); bei etwa 75 % deutliche Intelligenzminderung, bei 25 % kann jedes Intelligenzniveau vorkommen

Das ICD-10 unterscheidet zwischen ›schweren‹ (Kanner-Syndrom) und ›leichten‹ Formen des Autismus (Asperger-Syndrom).
Asperger (1952) beschrieb, beinahe zeitgleich mit Kanner, erstmals verhaltensauffällige Kinder, welche schon ab dem Säuglingsalter

wenig Reaktionen auf menschliche Zuwendung zeigten, sich in monotone Beschäftigungen vertieften und schwer ansprechbar waren. Die Mimik schien ausdruckslos, die Gestik hölzern und gespannt. Auf Veränderungen in der Umgebung reagierten sie mit heftiger Aversion. Ihre Vorliebe für Stereotypien und Rituale mutete bizarr an. Die Sprachentwicklung der Kinder war deutlich verzögert oder blieb gänzlich aus, auch wenn sie Sprache etwa ab dem dritten Lebensjahr verstehen konnten (s. auch folgende Seite).

Das Psychologische Wörterbuch (Dorsch, 1987) gibt folgende Definition: »Seltene Verhaltensstörung bei Kleinstkindern und im Kindesalter (…). Symptome: Ablehnung von Zuwendung bereits im Babyalter, sozialer Rückzug, isolierte Fertigkeiten (»idiot savant«), häufig keine Sprachentwicklung, Aufmerksamkeitsstörung, oft hoher IQ bei Familienangehörigen.«

Lelord & Rothenberger (2000) definieren Autismus als »angeborene Unfähigkeit, normale Beziehungen zu anderen Menschen und zu sozialen Situationen zu entwickeln«. (S. 13) Die Autoren schildern, dass die Misserfolge in der Kommunikation Autisten zum Rückzug und der Beschäftigung mit sich selbst führen. Die Betreffenden erscheinen oft isoliert, unglücklich, angespannt, ängstlich, aufgewühlt und neigen zu heftigen Gefühlsausbrüchen. Typisch sei auch, dass Autisten Sätze wiederholen, die andere gesprochen haben (Echolalie). Und es wird darauf hingewiesen, dass die Hirnfunktion bei der Verarbeitung eines einfachen optischen oder akustischen Reizes auffällig sei, was leider nicht näher erläutert wird.
Einige Falldarstellungen anderer Autoren und die schriftlichen Aufzeichnungen eines Betroffenen sollen mögliche Erscheinungsformen autistischer Phänomene zunächst weiter verdeutlichen.

Falldarstellungen verschiedener Autoren

Asperger (1952) war einer der ersten Forscher, der sich mit Autisten eingehend befasste. Er zeichnet ein verblüffend anderes Bild von autistischen Störungen, als dies heute üblich ist.

Der Autor beschreibt autistische Kinder »als gescheit und doch oft in der Schule versagend, von differenziertem Seelenleben, überscharfem Denk- und Beo-

bachtungsvermögen und doch disziplinär höchst schwierig, scheinbar gefühlsarm und doch auch feiner Gefühle fähig. (…)
Sehr typisch sind bei autistischen Kindern psychologische Fähigkeiten vom frühen Kindesalter an. Mit unbeirrbarer Sicherheit werden Lehrer und andere Leute beurteilt, werden vor allem ihre Schwächen erkannt und provoziert. (…)
Es ist ein scheinbarer Widerspruch, dass diese Kinder, die doch in ihrem sozialen Verhalten so unangepasst sind, über solche Fähigkeiten verfügen (…).
Autistische Kinder sind ›ganz anders‹, ständig fallen sie aus der Situation, der Gruppe heraus (…). In der fröhlichsten Schar stehen sie abseits, etwa in ein Buch vertieft, (…) unfähig, eine faire Rauferei zu bestehen (…).
Ähnlich gestört ist auch das Verhältnis zu den Autoritäten (…): was ein anderer kaum zu denken wagt, das sagt er dem Erwachsenen ungescheut ins Gesicht.
Weitere Schwierigkeiten ergeben sich daraus, dass das autistische Kind nicht imstande oder nicht willens ist, Alltagstechniken (…) geschickt nachzuahmen und sich anzueignen. Ohne dass man eine echte motorische Störung findet, ist es ungemein schwierig, ihm beizubringen, wie man sich anzieht und ordentlich hält, wie man eine Schleife bindet, wie man sich bei Tisch benimmt (…).
Wenn einige (…) Autoren meinen, Autismus sei ein kognitiver Defekt (…), so halten wir diese Erklärung für zu sehr an der Oberfläche. (…)
Wenn sie auch der Test als weit überdurchschnittlich gescheit erweist – sie sind dennoch keine guten Schüler! Was sie können, das haben sie aus eigenem Denken, eigenem Forschen. Aber sie *können nicht lernen*, sich nicht den von der Schule (…) geforderten Methoden fügen. Wir kennen Kinder mit einer ans Geniale grenzenden Einsicht in die Gesetze der Zahlen und ihrer Funktion, sie sind aber schlechte Rechner in der Schule, weil sie es sich zu kompliziert machen, sich in den eigenen Methoden verirren, vor allem aber den Lehrer dadurch beleidigen, dass sie es partout nicht so machen wollen, wie er es verlangt.« (Seite 293 ff.)

Bei Lelord und Rothenberger (2000) finden sich folgende Fallbeispiele (Auszüge):

»Herr G., 18, war ein Zeichentalent und zeichnete den ganzen Tag Statuen von großer Schönheit. Er hatte keinerlei Kontakt mit den anderen, die ihn zudem noch hänselten, sie nannten ihn den ›Künstler‹. Er war meist ruhig und zurückhaltend. Wenn er jedoch verärgert oder gekränkt war oder auch nur die kleinste Veränderung in seinem Zimmer vorgenommen wurde, führte das manchmal zu fürchterlichen Wutausbrüchen.«
»Der Protagonist im Film ›Rainman‹ war ein Rechenkünstler und verfügte über erstaunliche Einzelgedächtnisleistungen, war aber unfähig, die einfachsten Alltagsdinge für sich zu regeln.«
»Fabian ist klug und genügt sich selbst. Das habe er von seinem Großvater, ein Uhrmacher, der ein wenig sonderbar gewesen sei. Er habe immer allein in seinem Atelier gearbeitet und fühlte sich schnell irritiert, wenn nicht alle Dinge an ihrem üblichen Platz waren. Er hatte es zudem lieber ruhig.
Fabian mochte es schon als Säugling nicht, wenn man ihn anfasste. Später war

er nicht in der Lage, zwei Dinge gleichzeitig zu tun. Wenn er von dem Licht und seinem Würfel absorbiert war, hörte er nichts mehr und nahm seine Umgebung nicht mehr wahr. Er hörte nicht, wenn man ihn rief, und sprach auch nicht. Eine ärztliche Untersuchung bestätigte jedoch, dass Fabian sehr gut hören konnte, dass er sogar gegenüber bestimmten Geräuschen eine starke Überempfindlichkeit zeigte (z. B. Rascheln mit Papier). Seine Sprache war auf einige Lautäußerungen reduziert. Andererseits konnte er in kurzer Zeit ein kompliziertes Puzzle vollenden, das normalerweise nur älteren Kindern gelingt. Er aß nur ganz bestimmte Lebensmittel. Er zeigte viele Schreckreaktionen, z. B. wenn draußen ein Traktor vorbeifuhr oder ein Lüfter im Haus brummte. Er war sehr empfindlich gegenüber leisen Geräuschen. Er war nicht in der Lage, seinen Blick ausreichend zu fixieren; er konnte Botschaften aus seiner Umgebung nicht ausreichend aufnehmen und filtern. Ruhig, in einem spärlich möblierten Raum, schien sich das Kind sofort behaglich zu fühlen. Er ist intelligent.« (*nicht näher spezifiziert*)

»Jan konnte sich durch die Bilder eines Kaleidoskops so gefangen nehmen lassen, dass er wie taub wirkte. Er war sehr empfindsam für Musik. Er hatte Schwierigkeiten, seine fünf Sinne zu koordinieren, z. B. Ton und Licht gleichzeitig zu verarbeiten.«

»Amelie war intelligent und wirkte mit 12 Jahren schon wie eine Jugendliche. Sie reagierte sehr sensibel auf Missklänge in ihrer Umgebung, und man versuchte, sie davon abzuschirmen (ruhige Umgebung, jeweils nur ein Spielobjekt). Sie schien in einer eigenen Welt zu leben und stellte vor jeder neuen Situation angstvolle Fragen. Schon kleinste Veränderungen riefen in ihr massive Anspannung und Unruhe hervor.«

»Natalie konnte sich fasziniert von einer alten Kaminuhr einnehmen lassen und starrte minutenlang unbeweglich auf die Drehbewegungen. Oder sie versank im Anstarren von sich im Wind bewegenden Ästen eines Baumes. Selbst die vorsichtigste Kontaktaufnahme war nicht machbar, ihr Gesicht wirkte dann starr wie Eis. Das Spitzen eines Bleistiftes konnte sie so in Erregung bringen, dass sie in Schreckensschreie ausbrach und sich die Ohren zuhielt.«

Birger Sellin, ein autistischer junger Mann, veröffentlichte 1993 sein erstes Buch (s. Literatur). Die Authentizität der Texte wurde zunächst angezweifelt, konnte nach mehreren Überprüfungen vor Ort jedoch bestätigt werden. Man hielt es bis dahin für ausgeschlossen, dass Autisten wie Sellin in der Lage sind, sich sprachlich zu äußern. Dabei wurde offenkundig übersehen, dass andere Autisten zu diesem Zeitpunkt bereits Texte verfasst und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hatten (z. B. Donna Williams, 1991).

Aus Sellins zweitem Buch (1995) möchte ich einige Auszüge wiedergeben, die trotz ihrer eigenwilligen Sprache sehr eindrucksvoll und aufschlussreich erscheinen:

»eine große Hoffnung erwacht in mir, dass wir die auserwaehlten sprechenden überzeugen dass personen wie einsame autisten intelligent sind und nicht ausgestossen werden müssen«
»unsinn ist
ich koenne nicht einmal fühlen
eisig sind solche außerordentlich dummen behauptungen
eine empfindung geht bei mir tiefer als bei den meisten menschen«
»zu allen ueblichen vorurteilungen kommt die scheinbar doch schlimmste
wir haetten kein mitgefuehl
wir haben solche empfindungen aber wir können es nicht zeigen«

»einfach zu chaotisch wie sich die realität gebaerdet«
»wenn ich gesprochene Sprache höre
wirkt es auf mich eigentlich auch unangenehm
weil das reden sagenhaft laut
auch akustische leise besprechungen brausen ungestuem in mein ohr
wie meerestosen
ausser weitentferntes feines reden«
» (…) weil alle geraeusche wirklich sehr schwer zu ertragen sind
benötige ich anstrengende abwehrmechanismen
einfach um eisern alltagsgeraeusche auszuhalten
es werden alle laute in mir verzerrt«
»und viele orkanartige ueberlaute geraeusche kann ich kaum ertragen
ich werde verrückt wenn wirres durcheinander in einem raum entsteht
wenn alle gleichzeitig reden
fistelstimmen tenoere ertrage ich kaum
aber sehr tiefe stimmen sind mir angenehm
werde immer gut erreicht wo die stimme ruhende ausdrucksmöglichkeiten
lassen kann
kinderstimmen aber ertrage ich am besten
denn sie werden meistens auch nicht sehr scharf
richtig wohltuend aber ist orgelmusik
aergerlich ist ich kann nur so bruchstueckhaft meine eindruecke
schildern
denn es regt mich alles so auf
ich kann sicher sagen mir tun fast alle geraeusche weh«

»sprache wird sehr schnell und auch deutlich verstanden
probleme habe ich aber mit der astreinen lautstaerke«
»ohne mich zu erregen kann ich die fragen nicht beantworten
denn sie beruehren mich besonders
(…) innerlich aber rede ich sehr viel so aber wie alle erdlinge
(…) ohne uebertreibung alle stumm gelesenen texte verstehe ich sehr
schnell«
»(…) omnipluristisch ist mein gehirn«
»… aber ich weiß nicht wie ich sicher wirksam unterscheiden kann
zwischen normaler und (…) unnormaler wahrnehmung

ich sehe alle dinge (…) wie andere menschen aber ich denke manches sehe ich deutestaerker,
das heisst schaerfer und es arbeitet staerker in mir«

»sicher ist ich leide an einer desorientierung in allen sinnesbereichen«
»lesen und schreiben meistere ich sehr genau
aber sagenhaft anstrengend ist das akustische und visuelle wahrnehmen
ich erlebe alles sehr chaotisch«
»ich verkrafte schwer irgendwelche einschneidenden veraenderungen«
»es greift zu sehr in meine nervenketten
es arbeitet zu sehr
ich erlebe hinterher wie akustisches unwetter
eine welle von einhaemmernden geraeuschen
ich will aber lieber nur einfache musik ohne irren wechsel
wie die gregorianische musik«
»ganz ruhig bin ich nur einsam
doch ich halte einsamkeit auch meistens nicht aus«

»bei dummreicher wortwahl raste ich aus
weil woerter für mich kostbar sind
für euch aber sagenhaft unbedeutend«

Eigene Beobachtungen

In den Erstgesprächen mit Eltern, die ihr Kind zu einer Hochbegabungsdiagnostik bei mir vorstellen, erhebe ich Anamnesedaten zur geistigen, sozialen und seelischen Entwicklung des Kindes, also zu Beginn und Verlauf der Sprachentwicklung, der grob- und feinmotorischen Entwicklung, des Kontaktverhaltens, der Persönlichkeit und des Temperaments sowie Besonderheiten und Auffälligkeiten beim Kindergarten- und Schulbesuch. Selbstverständlich werden hierbei auch besondere Fähigkeiten (sprachliche, naturwissenschaftliche, technische, soziale, künstlerische etc.) erhoben, die Eltern, Erzieherinnen oder LehrerInnen im Verlauf der Entwicklung des Kindes aufgefallen sind.
Von etwa 15 % der Kinder, bei denen ich im Anschluss eine Hochbegabung diagnostizierte, berichteten die Eltern, dass sie selbst oder außenstehende Personen vermutet hätten, das Kind sei vielleicht ›autistisch‹. Da mir bekannt war, wie leichtfertig solche Diagnosen bisweilen von Laien, aber auch von Pädagogen vergeben werden, wies ich diese Vermutungen zunächst ohne näheres Nachfragen zurück. Im Laufe meiner diagnostischen Tätigkeit häuften

sich solche Äußerungen jedoch, und ich erkundigte mich eingehender nach den jeweiligen Auffälligkeiten und Verhaltensweisen, die Eltern oder Erzieher dazu veranlasst hatten, eine autistische Störung zu vermuten.

»Hannes war so ein eigenwilliges, besonderes Kind. Er schottete sich von der Außenwelt ab und nahm keinen Kontakt zu anderen Kindern auf. Er zog sich in sich zurück, blieb immer am Rande des Geschehens und beteiligte sich nicht an Gruppenaktivitäten. Er wirkte isoliert und reagierte brüsk und abweisend, wenn Erwachsene ihm zu nahe kamen und ihn zu laut ansprachen. Er beschäftigte sich am liebsten alleine und konnte manchmal Stunden mit einer einzigen Tätigkeit verbringen. Hannes wirkt oft geradezu kühl und distanziert, er mag es nicht, wenn man ihn anfasst. Er ist auffallend schüchtern und hat vor neuen Situationen große Angst.«

»Marlene war zwar schon immer ein besonders sensibles Kind, aber ihre Entwicklung schien zunächst normal zu verlaufen. Mit zwei Jahren sprach sie plötzlich immer weniger. Beim Besuch des Kindergartens stellte sie das Sprechen vorübergehend ganz ein und zog sich völlig in sich zurück. Sie scheint in ihrer eigenen Welt zu leben und ist sehr verträumt. Dann wieder kann sie heftige Wutausbrüche bekommen, selbst beim geringsten Anlass. Oft wissen wir erst gar nicht, was es war. Als Kleinkind brüllte sie fürchterlich und hielt sich die Ohren zu, wenn ich den Mixer oder den Staubsauger anstellte.«

In den Anamnesegesprächen mit Eltern hochbegabter Kinder achtete ich nun sorgfältiger auf ›autistische Symptome‹; sowohl deren überzufällige Häufung als auch die qualitativen Übereinstimmungen der spezifischen Merkmale veranlassten mich zu einer eingehenderen Beschäftigung mit der Thematik.

Intelligenzmessung bei Hochbegabten mit autistischen Zügen

In der Untersuchungssituation ging ich besonders behutsam mit diesen Kindern um. Ich ließ ihnen Zeit, sich einzugewöhnen,

sprach leise und ruhig und hielt die Distanz, die sie offenbar wünschten, ein.
In den Ergebnisprofilen dieser Kinder fiel mir auf, dass sie in Aufgaben, die 1. mehrdeutig sind, 2. Kommunikation erfordern, 3. unter Zeitdruck auszuführen sind und 4. die Berücksichtigung vieler Aspekte gleichzeitig erfordern, eher durchschnittlich abschnitten. Werte im oberen Extrembereich (IQ über 140) erzielten sie hingegen in Aufgaben, die 1. eindeutig waren, 2. keine Kommunikation erforderten, 3. ohne Zeitdruck auszuführen sind und 4. die Konzentration auf einen oder einige wenige Aspekte erlauben.
Mittlerweile gelingt es mir, bei hochbegabten Kindern mit autistischen Zügen mit relativ großer Treffsicherheit vorherzusagen, in welchen Aufgaben sie hohe Ergebnisse erreichen werden und in welchen die Ergebnisse im Durchschnittsbereich liegen.
In Intelligenztest-Aufgaben, die das Erfassen komplexer sozialer und praktischer Handlungsabläufe messen (die Kinder müssen hier Bildergeschichten in eine richtige Reihenfolge bringen), fiel mir auf, dass besonders introvertierte hochbegabte und autistische Kinder hier oftmals nur durchschnittlich abschneiden. Bei näherer Betrachtung zeigte sich, dass die Kinder dabei auf *zu viele Details* achten: z. B. schlossen sie aus einem leichten Unterschied in der Gesichtsröte der dargestellten Person, dass diese sich schämen müsse, sodass ein gänzlich anderer Zusammenhang in der Geschichte entstand, der von den Herstellern nicht intendiert war. Oder: ein und dieselbe Tür hatte in den Bildern etwas unterschiedliche Farben, sodass die Kinder vermuteten, es handle sich um verschiedene Türen. Auch daraus ergab sich ein anderer Sinn der Geschichte. Normal begabten Kindern waren diese feinen Unterschiede gar nicht aufgefallen, sodass sie die Aufgaben bisweilen besser und schneller lösten als ihre hochbegabten Altersgenossen. Autistische Kinder schneiden bei Testreihen wie dem ›Bilderordnen‹ meist besonders schlecht ab. Auch hier kann die Differenziertheit der Wahrnehmung also sowohl positive als auch negative Auswirkungen haben.

Diese Beobachtungen decken sich mit vielen Befunden der Autismusforschung: Poustka et al. (2004) sprechen von einem relativ stabilen Leistungsprofil autistischer Menschen in Intelligenztests: Die

Autoren benennen gute Leistungen in den Subskalen zur Messung visuell-räumlicher Fähigkeiten und mechanischer Gedächtnisfunktionen sowie unterdurchschnittliche Leistungen in Subtests zur sozialen Kognition.

Zahlreiche neuere und sorgfältige Studien, etwa von Baird et al. (2000) und Chakrabarti & Fombonne (2001), kommen zu dem Ergebnis, dass die *Komorbidität zwischen Autismus und Intelligenzminderung weitaus niedriger* ist als z. B. im ICD-10 angegeben (75 %). Die Autoren sprechen von nur 25 bis 50 %.
Poustka (2004) führt aus, dass 20 % aller Autisten nicht »testbar« seien, »in der Regel diejenigen, die allem Anschein nach mittelgradig oder schwer geistig behindert, sehr impulsiv oder rastlos sind«. (S. 1)
Autistische Menschen, die sich am Intelligenztest nicht beteiligen können oder wollen, werden somit ›dem Anschein nach‹ als geistig behindert eingestuft. Ob eine solche Schlussfolgerung zulässig ist, stellte schon Asperger (1952) in Frage: »Kinder, die weder sinnvoll spielen noch sich sprachlich äußern und auf die Bemühungen der Erwachsenen nicht reagieren, werden *regelmäßig als schwachsinnig angesehen*, und auch in Intelligenztests arbeiten sie nicht mit.« (S. 289)

Wir erinnern uns an schulärztliche Untersuchungen, bei denen sehr introvertierte hochbegabte Kinder als ›sozial unreif‹ eingestuft werden, weil sie die Mitarbeit verweigern, wenn man sie etwa auf laute und unnatürliche Weise anspricht. Auch bei autistischen Kindern erhebt sich die Frage, unter *welchen Bedingungen* sie in der Lage sind, ihre sozialen und geistigen Fähigkeiten zum Ausdruck zu bringen.
Poustka et al. (2004) schlagen in ihrem Leitfaden für autistische Störungen vor: »Ganz zentral ist es, mit dem Kind nur zu interagieren, wenn man zuvor durch Ansprache (Nennung des Namens) oder *Berührung* (z. B. *Kitzeln*) seine Aufmerksamkeit gewonnen hat. Das Kind muss mit *Blickkontakt* (…) oder einer anderen Form der Reaktion zum Ausdruck bringen, dass es den Untersucher wahrgenommen hat.« (S. 70; Herv. v. Verf.)
Jeder, der sich mit autistischen Menschen näher beschäftigt, weiß,

dass sie auf plötzliche Berührungen und erzwungenen Blickkontakt außerordentlich empfindlich reagieren.
An anderer Stelle räumen die Autoren wiederum ein: »Einige Kinder mit AS *(autistischen Störungen)* zeigen bei Testungen deutlich bessere Leistungen, als dies aufgrund des klinischen Verhaltens zu erwarten wäre, da sie wahrscheinlich von der Strukturierung und den eindeutigen Vorgaben der Verfahren profitieren. Besonders geeignet sind z. B. computergestützte Verfahren, die ein *Minimum an Kommunikation und sozialer Interaktion erfordern*. (Poustka et al., 2004, S. 77) (Herv. v. Verf.)

Aus genau diesem Grund achte ich bei sehr introvertierten hochbegabten oder autistischen Kindern darauf, die Kommunikation und Interaktion auf ein Minimum zu reduzieren. Der sechsjährige Viktor wollte zu Beginn der Untersuchung nicht sprechen. Also zog ich alle Aufgaben vor, die zu den *nonverbalen* Testreihen gehören, und sprach selbst nur das Nötigste. So konnte Viktor zu Beginn viele Erfolgserlebnisse verzeichnen und sich langsam an die Situation gewöhnen. Erst nach über einer Stunde versuchte ich eine verbale Aufgabe, auf die Viktor überraschend mit einer geflüsterten Antwort reagierte. Den Rest der Sitzung hielten wir beide im Flüsterton ab. Am Ende wollte ich Viktor zum Abschied die Hand geben. Er weigerte sich zwar, drückte aber durch seine Körperhaltung aus, mir eigentlich gerne die Hand geben zu wollen. Also drehte ich mich um und hielt ihm meine Hand hinter dem Rücken hin; da Viktor auf diese Weise nur *einen* Sinneseindruck verarbeiten musste, konnte er meine Hand jetzt nehmen und kurz drücken. Darüber schien er stolz und erfreut.

Poustka et al. (2004) merken an, dass geeignete und spezifische Intelligenztestverfahren für autistische Menschen fehlen. Die Autoren schildern ein Fallbeispiel eines 19-jährigen autistischen Mannes, der im IQ-Test einen Gesamtwert von 79 Punkten (unterer Bereich der Lernschwäche) erreicht; aus nicht nachvollziehbaren Gründen wurde der HAWIK-R für Kinder angewandt. Auch hier hatte sich das für Autisten typische Leistungsprofil ergeben. Das freie Interview mit dem jungen Mann wird wie folgt beschrieben: »Im Gespräch nahm er nur sehr sporadisch Blickkontakt auf, wirk-

te unspontan, zurückhaltend und abwesend. Angesprochen auf seine Spezialinteressen (Wale, Astronomie), wurde er jedoch wacher und zugänglicher, begann flüssig zu sprechen, zu lächeln und Blickkontakt aufzunehmen.« (S. 158)
Wie erklärt man, dass sich die klinischen Auffälligkeiten des Betroffenen weitgehend zurückbilden, wenn er über seine Spezialinteressen sprechen kann? Und wie ist es möglich, dass eine Person, die über umfassende Kenntnisse in Astronomie verfügt, lediglich einen Intelligenzquotienten von 79 erreicht? Die letzte und schwerste Aufgabe des HAWIE-Tests für *Erwachsene* lautet etwa: ›Wie viele Planeten hat unser Sonnensystem?‹ Diese Frage hätte der junge Mann mit großer Wahrscheinlichkeit beantworten können. Autisten haben ebenso wie Hochbegabte oft Schwierigkeiten, *einfache* Fragen zu beantworten. In allen IQ-Testverfahren beginnt man mit der leichtesten Frage und geht dann zu den schwierigeren. Kann ein Proband vier bis fünf Fragen nacheinander nicht beantworten, soll die Testreihe abgebrochen werden (Abbruchkriterium). Diese Regel wende ich bei der Testung Hochbegabter *grundsätzlich nicht* an. Denn ich erlebe häufig, dass ein hochbegabtes Kind etwa noch nicht alle Monate kennt (einfache Aufgabe), jedoch die chemische Zusammensetzung von Wasser (schwere Aufgabe) benennen kann. Ich hatte bereits geschildert, dass einige Hochbegabte mich sogar darum bitten, mit den schwierigen Aufgaben zu beginnen.

Diese Aspekte müssen meiner Auffassung nach bei der Testung von hochbegabten Kindern mit autistischen Zügen unbedingt berücksichtigt werden. Damit sie ihre Begabungen umsetzen können, müssen die Testreihen hier gegebenenfalls variabel gestaltet und ein angemessenes Arbeitsklima geschaffen werden.

Zur Beziehungsgestaltung mit autistischen Kindern

Der Untersucher sollte sich, wie bereits erwähnt, auf die Zurückhaltung des Kindes einstellen und die Kommunikation äußerst behutsam beginnen. In manchen Fällen ist es sinnvoll, einen Intelligenztest erst nach mehreren Sitzungen durchzuführen, wenn Behandler und Kind sich gegenseitig besser kennen gelernt haben.

Ich hatte schon darauf hingewiesen, dass Hochbegabte auf sehr allgemein gehaltene Fragen verwirrt oder ratlos reagieren. Poustka et al. (2004) schlagen für das Gespräch mit Autisten einen Fragenkatalog vor, der etwa folgende Items enthält: »Wie geht es dir? Wie fühlst du dich, wenn du glücklich bist? Wie ist es mit Dingen, vor denen du dich fürchtest? Wie ist das mit Dingen, bei denen du etwas machst, was andere Menschen nervt oder stört? Wie ist es mit Ärger?« etc. (S. 75) Autisten ist es (verständlicherweise wie ich finde) oftmals unmöglich, auf solche Fragen zu antworten. Besser sind sehr konkrete Fragen, wie ich sie für hochbegabte Kinder beschrieben habe.

Bei der Lektüre der Empfehlungen Aspergers (1952) zum Umgang mit autistischen Kindern fragt man sich erneut, warum seine Schriften in den letzten Jahrzehnten weitgehend ignoriert werden:

»Was der Erzieher ganz allgemein tun sollte, ist: ein Kind respektieren eben so, wie es ist – das erscheint gerade bei einem autistischen Kind erforderlich und wirksam. Man soll ihm nicht unbedingt aufzwingen wollen, was ihm nicht gemäß ist, sondern anerkennen, was er Besonderes leistet (…). (Man sollte) ihm Bücher bieten, die ihn auf seinem Spezialgebiet fördern, mit ihm darüber diskutieren; dabei muss man konzedieren, dass sich das Gespräch durchaus auf gleicher Ebene abspielt, nicht etwa, dass der Lehrer oder Arzt Autorität verlangen darf, sondern sich der kritischen Auseinandersetzung mit dem Autisten stellt. Auf dieser hoch intellektuellen Ebene kann es nun tatsächlich zu guter Kommunikation mit autistischen Kindern kommen.« (S. 297)

Autisten mit besonderen Begabungen

In der Forschungsliteratur über Autismus sowie in Biographien werden häufig ungewöhnliche Begabungen bei Autisten geschildert. Mit ungewöhnlich meine ich nicht nur besondere, sondern nahezu ›übermenschliche‹ Begabungen, für die es keine nachvollziehbare Erklärung gibt.

Im Zusammenhang mit Autismus ist in der Fachwelt das Phänomen des »idiot savant« bekannt, heute spricht man von ›Inselbegabungen‹. Die Rede ist dabei von Menschen, die auf einem einzigen Gebiet (z. B. Mathematik, Musik, Malerei) äußerst ungewöhnliche

Leistungen vollbringen, während sie auf fast allen anderen Gebieten als ›zurückgeblieben‹ und ›behindert‹ gelten (vgl. Treffert & Wallace, 2002; Winner, 1998).
Es gibt einige Autisten, die in der Lage sind, jede Melodie, die sie ein Mal gehört haben, jedes Klavierstück und sogar ganze Klavierkonzerte sofort auswendig spielen zu können, ohne je auch nur eine Note gelernt zu haben. Eine Fernsehdokumentation berichtet über einen neunjährigen Autisten, der jedes Gebäude, jede Skulptur nur einmal anzusehen braucht, um sie dann in allen Details aus dem Kopf nachzeichnen zu können, und zudem auf hohem künstlerischen Niveau.
Birger Sellin hat angeblich bereits im Alter von fünf Jahren Bücher und Texte hoher Komplexität gelesen (während die Eltern dachten, er blättere die Bücher aus ihrer Bibliothek lediglich durch) und die meisten Inhalte behalten. Ein Großteil autistischer Kinder ist schon früh hoch empfänglich für klassische Musik. Andere Autisten sind in der Lage, in kürzester Zeit ganze Telefonbücher auswendig zu lernen, komplizierteste Mathematikaufgaben zu lösen oder Kalendertage über Jahrzehnte zurück zu berechnen. Typisch scheint dabei zu sein, dass sie beim Lösen sehr einfacher Aufgaben scheitern (wie etwa ›Rainman‹, der zwar binnen Sekunden die Wurzel aus einer fünfstelligen Zahl ziehen, aber 50 und 50 nicht addieren kann). Auch fiel mir bei der Lektüre von Autobiographien auf, dass viele autistische Kinder ein frühes Interesse an Astronomie, Technik und Naturwissenschaften zeigen.
Ich frage mich unter anderem, wie man z. B. im Zusammenhang mit überragenden musikalischen Leistungen von ›Insel‹-Begabungen sprechen kann. Musikwissenschaftler und Hirnphysiologen sind sich einig, dass zum Musizieren hoch komplexe Vorgänge und Fähigkeiten erforderlich sind (Gehör, Gedächtnis, visu-motorische Koordination etc.). Ähnliches gilt für zeichnerische oder mathematische Begabungen. Dass eine Person in vielen Bereichen ›geistig behindert‹ und in anderen geistig herausragend sein sollte, erscheint mir nicht schlüssig. Die ›Behinderung‹ muss zumindest bei Menschen mit Inselbegabungen, aber auch bei anderen Autisten, einen anderen Bereich als den geistigen bzw. intellektuellen betreffen.
Temple Grandin (1997) weist darauf hin, dass berühmte Persön-

lichkeiten wie Albert Einstein, Ludwig Wittgenstein und Vincent van Gogh als Kleinkinder Entwicklungsanomalien zeigten:
»Einstein wies als Kind zahlreiche autistische Eigenschaften auf. Er lernte erst mit drei Jahren sprechen. Bernard Patten berichtet im ›Journal of Learning Disabilities‹, dass Einstein noch mit sieben Jahren Worte leise wiederholte und keinen Anschluss an seine Schulkameraden fand. (…) Wie viele Kinder mit autismusartigen Wesenszügen war er sehr begabt für Puzzles und verbrachte Stunden mit dem Bau von Kartenhäusern. (…)« (Einstein) erzählte dem befreundeten Psychologen Max Wertheimer: »Die Gedanken kamen nicht in einer verbalen Ordnung. Ich denke kaum einmal in Worten. Es kommt mir ein Gedanke, und im Nachhinein versuche ich, ihn mit Worten auszudrücken.«
Weiter berichtet Grandin: »Oliver Sacks hat die Vermutung geäußert, der Philosoph Ludwig Wittgenstein sei wahrscheinlich ein hoch funktionsfähiger Autist gewesen. Er sprach erst im Alter von vier Jahren. Seine Sprache war (später) förmlich und pedantisch. Eine übertrieben förmliche Sprache ist unter Autisten weit verbreitet.«
»Vincent van Goghs künstlerische Arbeit enthüllt große Emotion und Brillanz, aber als Kind und junger Mann wies er einige autistische Merkmale auf. (…) Seine Biographen beschrieben ihn als Außenseiter und als seltsames Kind. Er hatte häufig Wutanfälle und wanderte am liebsten allein durch die Felder. (…) Bevor er seine künstlerische Laufbahn als Maler begann, wies er zahlreiche Charakteristika einer Person mit Asperger-Syndrom auf.«
Grandin (1997) stellt fest, dass Menschen mit Asperger-Syndrom in hoch spezialisierten akademischen Berufen erfolgreich sind, und schlussfolgert: »Unser Erziehungssystem siebt diese Leute aus, anstatt Weltklasse-Wissenschaftler aus ihnen zu machen.« (S. 236)

Gewagte Hypothesen

Dass in der Forschung ein möglicher Zusammenhang zwischen autistischen Phänomenen und denen der Hochbegabung bislang nicht, oder nur sehr vereinzelt, in Betracht gezogen wurde, liegt meines Erachtens daran, dass es so schwer fällt, die Begriffe ›Begabung‹ und ›Behinderung‹ zusammenzudenken; also sich vorzu-

stellen, dass ein Mensch gleichzeitig besonders begabt und besonders beeinträchtigt sein kann. Im Normalfall scheint das eine das andere auszuschließen.
Geht man jedoch vom Modell der neuronalen Übererregbarkeit (geistige Überaktivität, emotionale Hypersensibilität und sensorische Überempfindlichkeit) sowohl bei Hochbegabten als auch bei Autisten aus, bietet sich möglicherweise ein Erklärungsansatz für den oben beschriebenen Widerspruch.
Voraussetzung für hohe Intelligenz ist eine hohe Auffassungsgabe, d. h. die Fähigkeit, viele Reize gleichzeitig wahrzunehmen und komplex zu verarbeiten. Ist das Auffassungsvermögen »*zu* hoch«, strömen in alle Sinneskanäle gleichzeitig Reize mit ungehinderter Intensität ein. Dies kann zu Reizüberflutungen, Denkblockaden und schließlich zu Entscheidungs- und Handlungsunfähigkeit führen. Eine Möglichkeit, diesen Reizüberflutungen zu entkommen, besteht im Rückzug sowie in der Beschäftigung mit monotonen (und damit beruhigenden) Aktivitäten, wie z. B. Schaukeln, Zählen, Wiederholen von Bewegungen, oder der Vertiefung in Details.

Wenn also die intellektuelle Begabung, und damit die hohe Sensibilität und Auffassungsgabe, ein bestimmtes Maß nicht überschreitet, können Hochbegabte in vielen Bereichen besondere Leistungen erbringen.
Denkt man Intellekt, Sensibiliät und Auffassungsgabe auf einem Kontinuum gleichsam nach ›oben‹ fort, wird man bei Phänomenen ankommen, die der autistischen Störung entsprechen. *Autismus wäre demnach eine extrem ausgeprägte Form von geistiger, emotionaler und sensorischer Übererregbarkeit*.
Dies würde die *überragenden Leistungen* auf einzelnen Gebieten einerseits und die vielfältigen *Beeinträchtigungen* (der Kommunikation, der Sinneswahrnehmung, der Koordination) andererseits erklären.

Dieser Ansatz wirft eine Fülle von Fragen auf, insbesondere zu bestimmten Verhaltensauffälligkeiten bei autistischen Menschen. Einige dieser Besonderheiten sollen im Folgenden kurz beleuchtet werden:

Die Echolalie: Warum haben Autisten die Angewohnheit, selbst wenn sie über einen relativ großen (passiven) Wortschatz verfügen, Sätze oder Satzteile, die sie soeben gehört haben, mehrfach zu wiederholen?
Eine junge Autistin erklärte mir Folgendes: »Die Echolalie ist ungeheuer praktisch: Wenn jemand etwas sagt oder fragt, kann man Zeit gewinnen, indem man das Gesagte oder Gefragte wiederholt. Man kann versuchen, wenigstens ein bisschen Ordnung im Kopf zu schaffen, während man überlegt: Wer hat gesprochen? Welche genaue Bedeutung hat seine Frage? Wie viele Interpretationsmöglichkeiten gibt es? Was bedeutet die jeweilige Interpretation konkret? Was muss ich antworten? Welche möglichen Konsequenzen ergeben sich aus meinen möglichen Antworten? Könnte ich diese Frage, wieder einmal, falsch auffassen – und wenn ja, wie?«
Die Echolalie kann also als Versuch verstanden werden, in Kontakt zu bleiben, nicht den Faden zu verlieren und das ›Tosen im Kopf‹ zu übertönen. Autisten leiden nicht unter zu wenig, sondern unter ›zu viel‹ Verstand.
Ein anderes Beispiel: Befindet sich ein Mensch in einer Extremsituation, wie z. B. bei einem schweren Unfall, im Krieg, bei der Nachricht vom Tod einer nahe stehenden Person oder einer massiven Bedrohung, beobachtet man nicht selten, dass der Betroffene an ihn gerichtete Äußerungen oder Aufforderungen leise murmelnd wiederholt. Auch hier handelt es sich um eine Überlastung des seelischen Organismus und des Nervensystems. Das Wiederholen von Gehörtem erfüllt zum einen eine beruhigende Funktion, zum anderen ist es der Versuch, sich das Geschehen allmählich begreiflich zu machen.

Die monotonen Beschäftigungen: Einen ganz ähnlichen Zweck wie die Echolalie erfüllen die monotonen Beschäftigungen und das repetitive Verhalten (Wiederholung von Bewegungen oder Tätigkeiten), wie z. B. das Zählen oder Aufreihen von Gegenständen, das Öffnen und Schließen von Türen, das Bedienen von Lichtschaltern, aber auch das Hin- und Herwiegen des Kopfes oder Körpers. Birger Sellin berichtet, dass die unablässigen Wiederholungen ihm halfen, das Chaos seiner Gefühle, das ›Inferno von Sinneseindrücken‹ auszuhalten und den ›Sturm seiner Nerven‹ zu beruhigen. Was auf

Außenstehende wie ein stupides und absurdes Verhalten wirkt, ist für Autisten eine sinnvolle Methode, die Fülle und Intensität an Sinneseindrücken, Empfindungen und sich überschlagenden Gedanken wenigstens zeitweilig unter Kontrolle zu bringen.

Die Angst vor Veränderungen: Wenn man die Welt als unüberschaubaren, vielschichtigen, bedrohlichen Ort mit ungeheuer vielen Aspekten und unzählbaren Eindrücken erlebt, ist jede Form von Ordnung und Struktur überlebenswichtig, um sich orientieren und Halt finden zu können. Wenn jeder kleinste akustische, optische oder emotionale Reiz ein Feuerwerk an Nervenreaktionen, Gedanken und Gefühlen auslöst, braucht es ungeheure Kraft, sich auf neue Situationen einzustellen.

Das Verweigern von Sprache: Forschungen über autistische Störungen ergeben immer wieder, dass Autisten oft über einen weit größeren Wortschatz verfügen, als sie sprachlich zum Ausdruck bringen können (Frith, 1992; Lelord & Rothenberger, 2000). Die Sprachentwicklung vieler Autisten verläuft in den ersten beiden Lebensjahren relativ normal. Erst im dritten Jahr kann es zu Rückschritten und schließlich zur völligen Verweigerung des Sprechens kommen. Manche Autisten drücken sich dann nur noch mit Lauten aus, insbesondere dann, wenn sie Angst haben oder Unmut bekunden.
Sprache ist ein sehr komplexes System mit einer Vielzahl an möglichen Bedeutungen. Es scheint, dass Autisten instinktiv eine ursprünglichere Form des Ausdrucks vorziehen und sich darin oft auf das absolut Wesentliche beschränken. Die ›normale‹ Gesellschaft hat sich auf ein Regelwerk an Sprachmustern und Formulierungen verständigt, die oft nicht im Entferntesten die wahren Gefühlsregungen und Gedanken wiedergeben und die Autisten nicht verfügbar zu sein scheinen. Während ein ›normaler‹ Mensch den Satz formulieren kann: »Ich habe Angst«, wird der Autist von seiner Angst überwältigt. Er drückt sie direkt aus, die Intensität seiner Gefühle lässt keine Filterung durch Sprache zu. Dies wird auch in von Autisten verfassten Texten deutlich: ihre Sprache ist oft von großer, unmittelbarer emotionaler Kraft.
Wenn ein ›normaler‹ Mensch von Gefühlen überwältigt wird, sei es

Freude, Zorn, Rührung oder Zuneigung, fehlen ihm nicht selten die Worte. Er kann vielleicht nur seufzen, still und andächtig sein, stammeln oder nach Luft ringen.
In diesem Zustand (des Überwältigtseins) befindet sich der Autist dauernd; die Gefühle und Eindrücke sind zu stark, das Denken ist bisweilen zu komplex, um Worte und Sätze formulieren zu können.
Zudem berichten viele Autisten, dass sie weniger in Worten als in Bildern und Symbolen denken und ihnen die ›Übersetzung‹ in gesprochene Sprache häufig nicht gelingt. Wenn Autisten sich jedoch sprachlich äußern, tun sie dies oftmals bruchstückhaft und wirken dabei hölzern und ausdruckslos. Ursache hierfür können hohe Konzentration und Anspannung beim ›Übersetzen‹, aber auch beim Abwehren und Sortieren anderer Eindrücke sein. Als Hilfsmittel dient ihnen der Versuch, sich Sprache und soziale Kommunikation logisch zu erschließen (daher nehmen sie Gesagtes meist strikt wörtlich) oder die Verhaltens- und Sprechgewohnheiten anderer nachzuahmen.
Bemerkenswert ist, dass Autisten ebenso wie Hochbegabte über einen ausgeprägten Sinn für Authentizität verfügen und äußerst sensibel auf unechtes, übertriebenes oder affektiertes Verhalten reagieren.

Die Vorliebe für Gegenstände: Es scheint, als würden die meisten Autisten sich mehr zu Gegenständen als zu Menschen hingezogen fühlen. Autistische Personen können oft viele Stunden mit der Betrachtung ihrer Murmeln, dem Schließmechanismus eines Kästchens oder anderer scheinbar unwichtiger Details (Teppichfransen, feine Muster und Strukturen, Äste eines Baumes, Regentropfen) verbringen.
Auch hierbei scheint es sich um einen Versuch zu handeln, Ordnung im Inneren zu schaffen, indem man seine Konzentration auf kleine, überschaubare Einzelheiten richtet. Dies schafft Sicherheit und Halt, die der Autist in Kontakten mit anderen nicht findet, da hier eine Fülle an sozialen Regeln, Feinheiten in der Interpretation und möglichen Reaktionen berücksichtigt werden müssen. Lebt man sozusagen in einem Dauersturm von Sinneseindrücken, Gefühlen und Gedanken, schafft die Beschäftigung mit kleinen Gegen-

ständen oder Details ein Gegengewicht, das für Autisten oft die einzige Zuflucht bietet.
Auch dies ist vergleichbar mit Extremsituationen: Wer einmal Menschen nach einem seelischen Schock oder einer dramatischen Notsituation beobachtet hat, macht die bisweilen befremdliche Feststellung, dass der Betroffene sich mit gänzlich alltäglichen Kleinigkeiten befasst oder sich auf ein Detail konzentriert, das in der akuten Situation scheinbar keinerlei Bedeutung hat.

Die Wutausbrüche und Selbstverletzungen: Die Wut des Autisten ist oft eine verzweifelte oder panische Wut. Auch dieses Gefühl wird extrem erlebt, und Autisten selbst leiden häufig ebenso sehr darunter wie ihre Umgebung. Zudem ist der Wutausbruch oft das einzige Ventil für die massive innere Anspannung und die Verzweiflung darüber, sich nicht mitteilen zu können. Ebenso wie Zorn werden auch Gefühle von Freude, Verzückung oder Hingabe von Autisten meist sehr intensiv und direkt ausgedrückt. Es kann jedoch vorkommen, dass selbst Glücksgefühle so stark erlebt werden, dass der Autist fürchtet, von ihnen überflutet zu werden; dann kann er äußerlich starr, unbeteiligt oder ängstlich wirken.
Die Wutanfälle von Autisten gehen vielfach mit selbstverletzendem Verhalten einher. Selbstverletzungen können Ausdruck von Zorn, Selbsthass und Verzweiflung sein oder die einzige Möglichkeit darstellen, die starken inneren Spannungszustände kurzfristig zu lindern.

Schlussfolgerungen

Die bisherigen Schilderungen über Hochbegabte und Autisten dürften bereits deutlich gemacht haben, dass beide Personengruppen eine Fülle übereinstimmender Merkmale aufweisen.
Einer der ersten Wissenschaftler, der auf diese Gemeinsamkeiten hingewiesen hat, war der Autismus-Forscher Hans Asperger, den ich bereits in Kapitel IV ausführlich zitiert habe. Asperger & Wurst (1982) weisen in den Ausführungen über die Schwierigkeiten hochbegabter Kinder darauf hin, dass »sich in unserer Beschreibung vieles mit dem deckt, was (…) über den kindlichen Autismus geschildert wurde. Und tatsächlich gibt es da Beziehungen. Die starke

Spontaneität im Denken und Handeln, die guten Abstraktionsleistungen, die eigenständige Sprache; auch die Art der Konflikte (…) finden wir bei unseren Autisten. (…) Wir haben schon gesagt, dass Hochbegabte deutliche Berührungspunkte mit autistischen Kindern haben oder *zweifelsfrei zu dieser interessanten Gruppe von Charakteren gehören*.« (Hervorh. v. Verf.) (S. 58 ff.)
Grandin (1997) merkt an, dass Hans Asperger diese ›höheren‹ Erscheinungsformen des Autismus bereits im Jahr 1944 beschrieb, aber seine Abhandlung vierzig Jahre lang praktisch ignoriert wurde.

Die Auszüge aus den Texten von Birger Sellin (S. 142) ließ ich zunächst unkommentiert, da sie zum einen für sich sprechen und zum anderen vor einer Analyse des Textes die vorangehenden Ausführungen notwendig waren.
Vergleicht man Sellins Beschreibungen seiner Gefühle, seines Denkens und seiner Wahrnehmung mit jenen von Hochbegabten, ergibt sich ein ganz ähnliches Bild. Dies betrifft

- die emotionale Hypersensibilität (»die Empfindungen gehen tiefer als bei den meisten«; »alles regt mich so auf«)
- die akustische Überempfindlichkeit (»alle Geräusche schmerzen«)
- »Abwehrmechanismen, um Alltagsgeräusche auszuhalten«
- die Schärfe und Intensität der visuellen und sozialen Wahrnehmung (»manches sehe ich deutestärker, das heißt schärfer, und es arbeitet stärker in mir«)
- die neuronale Übererregbarkeit (»es greift zu sehr in meine Nervenketten«)
- die Vorliebe für klassische Musik
- die »Desorientierung in allen Sinnesbereichen«, was gleichbedeutend mit sensorischer Überempfindlichkeit sein kann
- die Angst vor Veränderungen
- die Schwierigkeit, sich mit vielen Menschen gleichzeitig in einem Raum aufzuhalten (»wenn wirres Durcheinander in einem Raum entsteht und alle auf einmal reden«)
- die Sehnsucht nach Kontakten und die Angst davor
- die überhöhte Vielfältigkeit und Komplexität im Denken (diesem Übermaß scheint nur eine neue Wortschöpfung, nämlich »omnipluristisch«, gerecht werden zu können)
- und nicht zuletzt der Ärger über »dummreiche Wortwahl«.

Kurz gesagt: Auffallend viele Hochbegabte weisen autismusähnliche Verhaltens- und Erlebensweisen auf, und viele Autisten verfügen über herausragende Begabungen.

Bleibt man bei der Vorstellung des *Kontinuums, auf dem die Phänomene der Hochbegabung ins Extrem weiter fortgedacht werden*, ergibt sich folgendes Bild:

- Wo der Hochbegabte eine sehr gewählte Ausdrucksweise verwendet, benutzt der Autist eine übertrieben förmliche Sprache.
- Verfolgt der Hochbegabte unbeirrbar ein Ziel, beharrt der Autist zornig und verzweifelt auf der Durchsetzung seiner Absichten.
- Zeigt der Hochbegabte im Vergleich mit anderen hervorragende Leistungen auf einem oder mehreren Gebieten, zeigt der Autist Extrem-Begabungen oft auf einem einzelnen Gebiet.
- Wo der Hochbegabte mit einem Wutausbruch reagiert, bekommt der Autist einen ausufernden Tobsuchtsanfall.
- Wirkt der Hochbegabte sozial ein wenig unbeholfen, ist der Autist ohne Unterstützung manchmal kaum fähig, überhaupt Kontakt mit der Außenwelt aufzunehmen.
- Kann der Hochbegabte nur mit Mühe einfache Aufgaben lösen, ist der Autist oftmals außerstande, einfache Aufgaben oder Alltagsprobleme zu bewältigen.
- Empfindet der Hochbegabte Emotionen wie Angst, Trauer oder Freude besonders intensiv, wird der Autist von seinen Gefühlen regelrecht überflutet.
- Wo der Hochbegabte keinen Wert auf Äußerlichkeiten und Konventionen legt, verzichtet der Autist gänzlich auf die Einhaltung gesellschaftlicher Regeln und Normen.
- Erlebt der Hochbegabte Veränderungen als unangenehm oder beängstigend, reagiert der Autist mit Panik und Verzweiflung.
- Kann der Hochbegabte sich stundenlang auf eine Beschäftigung konzentrieren, gelingt es dem Autisten, sich über Tage vollkommen und detailversessen in eine Tätigkeit zu vertiefen.
- Wo der Hochbegabte unverblümt seine Meinung sagt, erschreckt der Autist seine Mitmenschen mit dem unmittelbaren, direkten Ausdruck von Gefühlen und Gedanken.
- Wo der Hochbegabte eine ruhige, strukturierte Umgebung vor-

zieht, braucht der Autist absolut klare, wiederkehrende Regeln und starre Rituale.
- Fühlt sich der Hochbegabte in Menschenansammlungen unbehaglich, erzeugen diese für Autisten unerträgliche Anspannung.
- Verfügt der Hochbegabte über eine überempfindliche Sinneswahrnehmung, erfährt der Autist überwältigende Empfindungen von Geruch, Klang und Berührung.

Autisten wären demzufolge ›extrem hochbegabte‹ Menschen, also Persönlichkeiten mit einer extrem ausgeprägten geistigen Aktivität, emotionalen Hypersensibilität und sensorischen Übererregbarkeit.

Zu diesen Hypothesen passen zahlreiche Forschungsergebnisse über den *Zusammenhang zwischen Introversion, Reizsensibilität und Intelligenz*. Auch die Introvertiertheit kann man auf einem Kontinuum annehmen, an dessen Ende als Extremform der Autismus steht.
Myers (1987) weist darauf hin, dass Kinder mit extrem hohem IQ extrem hohe Werte bei der Introversion erzielen. Silverman (1993b) beobachtete ebenfalls, dass der Grad der Introvertiertheit mit steigendem IQ zunimmt. Auch Eysenck (1993) beschreibt den Zusammenhang zwischen hohem IQ und hoher Introversion. Weitere Studien zur Korrelation zwischen hoher Intelligenz und starker Introversion finden sich bei Albert (1978), Janos & Robinson (1985) und Gallagher (1990).
Winner (1998) schreibt: »Eine außergewöhnlich starke sensorische Reaktion auf die Umwelt ist möglicherweise kennzeichnend für viele Menschen mit besonderen Befähigungen gleich welcher Art. Das würde zu der Tatsache passen, dass solche Menschen introvertiert sind: Introversion (…) geht oft Hand in Hand mit intensiven sensorischen Reaktionen.« (S. 206) Weitere Belege für den Zusammenhang zwischen hoher Reizsensibilität und Introversion liefern Greenacre (1956), Dabrowski (1964), Eysenck (1993) und Kagan (1994).
Zusammengefasst ließe sich also festhalten: Je höher der Intelligenzquotient einer Person ist, umso introvertierter ist sie; und je introvertierter sie ist, umso sensibler reagiert sie auf Umweltreize.

Da der autistische Mensch, noch weniger als der hochbegabte, Erklärungen für seine besonderen Wahrnehmungen, Empfindungen und Denkweisen hat, zieht er sich hilflos zurück und versucht, sich zu schützen. Dazu braucht er, wie Birger Sellin es beschreibt, vielfältige und anstrengende Abwehrmechanismen. Dieses Schutzverhalten wird von Außenstehenden als absurd, gestört und ›defekt‹ wahrgenommen, ebenso wie der Ausdruck von Wut und Verzweiflung autistischer Personen. Insofern stellen diese eine große Herausforderung für Heilpädagogen und Psychologen dar: Um sich einem Autisten zu nähern und Zugang zu ihm zu bekommen, braucht es eine stille, ablenkungsarme Umgebung, leises Sprechen und ruhige Bewegungen. Berührungen und Blickkontakt sollten vermieden werden. Und es braucht die absolute Authentizität eines Therapeuten, der sich in das Erleben eines Autisten einfühlen, ihm behutsam beim Sortieren und Fokussieren helfen und ihm Erklärungen für seine Verhaltensweisen geben kann. Dabei sollte nicht nur auf die vielen Defizite als vielmehr auf die Potenziale und Fähigkeiten, die in Autisten schlummern, hingewiesen werden.

Autismus gilt bislang als unheilbare Störung. Es gibt eine Vielzahl von ›leichten‹ Autismusformen, bei denen es Betroffenen möglich ist, ein annähernd normales Leben zu führen, eine Schule zu besuchen und einen Beruf auszuüben. Einigen Autisten gelingt es sogar, Bücher zu veröffentlichen, in welchen sie über ihr Leben und ihre Wahrnehmungen sehr reflektiert und differenziert berichten. Vielleicht handelt es sich hier tatsächlich um leichter ausgeprägte Formen des Autismus im Sinne des Asperger-Syndroms. Es ist aber auch denkbar, dass dieser Personenkreis in der Lage ist, seinen Alltag mit einer Fülle von geeigneten Strategien zu bewältigen, die er sich unter großen Mühen und mit geduldiger Unterstützung von anderen angeeignet hat.
Die moderne Hirnforschung unternimmt beträchtliche Anstrengungen, autistische Störungen mit hirnorganischen und neurophysiologischen Prozessen zu erklären. Hierzu ist grundsätzlich anzumerken, dass sich zu ausnahmslos jeder menschlichen Regung ein hirnphysiologisches Korrelat finden lässt. Die Frage, ob Zusammenhänge damit *kausal erklärt* oder lediglich *beschrieben* werden, wird in den kommenden Jahren noch zu beantworten sein.

Eine weitaus wichtigere Frage ist, welche konkreten Schlussfolgerungen sich aus den Erkenntnissen der Hirnforschung für Autisten ergeben (ganz zu schweigen von möglicherweise resultierenden gentechnischen Perspektiven). Fände sich etwa ein Medikament, das autistische Symptome frühzeitig heilt oder beseitigt, blieben uns einige geniale Persönlichkeiten wie zum Beispiel Albert Einstein, Glenn Gould, Ludwig Wittgenstein, Clara Schumann, Vincent van Gogh, Stephen Hawking oder Bill Gates als auch die Beschäftigung mit weniger bekannten Vertretern dieser interessanten Charakteren ›erspart‹.
Ich persönlich erlebe den Umgang mit autistischen Menschen stets als bereichernd, inspirierend, lehrreich und angenehm verwirrend. Ihre Ursprünglichkeit, ihr assoziatives Denken, ihre Empfindungsfähigkeit, ihre Sturheit und Originalität, aber auch ihr Verzicht auf Höflichkeitsfloskeln und überflüssige Redewendungen, die Reinheit ihres Ausdrucks und die Konzentration auf das absolut Wesentliche sind als Anregungen für meine persönliche und berufliche Weiterentwicklung unverzichtbar geworden.

3. Psychotherapie mit hochbegabten Erwachsenen

Abgesehen von Termans Langzeitstudie (ab 1925) über die Entwicklung Hochbegabter bis ins Erwachsenenalter gibt es bislang keine systematischen Forschungen und theoretischen Ansätze zur Psychotherapie mit hochbegabten Erwachsenen. Scheidt (2004) hält fest: »Leider existiert das Thema ›Hochbegabung‹ in der psychoanalytischen Literatur und Diskussion nahezu nicht; (…) Die Frage erhebt sich also, ob solchen Menschen dann adäquat geholfen wird. Schon wenn man sie nicht mehr als ›Neurotiker‹ bezeichnen würde, wäre viel gewonnen. (…)« (S. 21) Scheidts Aussage gilt nicht nur für die psychoanalytische, sondern für die gesamte psychologische Literatur. Da ich mit den folgenden Ausführungen also ›Neuland‹ betrete, sind sie als Erfahrungsberichte und erste Anregungen für die Therapiegestaltung mit Hochbegabten zu verstehen.

Hierzu möchte ich zunächst meine zu Beginn des Kapitels formulierten Fragestellungen weiter vertiefen.

In der psychotherapeutischen Behandlung erwachsener Hochbegabter fällt mir Folgendes auf:

1. Eine größere Anzahl Hochbegabter, die zur Behandlung einer seelischen Störung zu mir kommt, hat bereits einen oder mehrere *erfolglose Therapieversuche* hinter sich.
2. Zudem weisen der Verlauf und die *Gestaltung der therapeutischen Beziehung* systematisch charakteristische Merkmale auf.
3. Bei sehr vielen Hochbegabten zeigt sich, dass sie sich allein aufgrund der *Besonderheiten im Denken, Empfinden und der sozialen Wahrnehmung* als ›gestört‹ erleben.

Diese Beobachtungen veranlassten mich sowohl aufgrund ihrer Häufigkeit als auch ihrer spezifischen Ausprägungen zu folgenden Überlegungen:

1. Kann man, wie es bislang üblich ist, bei der psychotherapeutischen Behandlung eines seelisch erkrankten Hochbegabten seine *intellektuellen Fähigkeiten und die damit verbundenen Besonderheiten im Denken und Erleben außer Acht lassen*? Kann eine unerkannte Hochbegabung Heilungserfolge erschweren oder verhindern?
2. Ist es denkbar, dass die beschriebenen *Phänomene der Hochbegabung sowohl von Fachleuten als auch von den Betroffenen selbst fälschlicherweise als gestörtes Verhalten interpretiert* werden? Verleiten das ›Anderssein‹ und etwaige Schwierigkeiten im therapeutischen Kontakt manche Psychologen und Psychiater gar dazu, Hochbegabte mit Diagnosen klinischer Störungen zu stigmatisieren?
3. Gibt es *klinische Störungen, die erst dann gänzlich verstanden und adäquat behandelt* werden können, wenn man den Aspekt der Hochbegabung und der damit verbundenen erhöhten geistigen, emotionalen und sensorischen Erregbarkeit mit in Betracht zieht?
4. Neigen hochbegabte Personen dazu, unter bestimmten Voraussetzungen (wie z. B. belastende oder traumatische Erfahrungen) *spezifische* Störungen zu entwickeln?

Vorkenntnisse des Therapeuten

Wie ich bereits erwähnte, zeigte sich in meinen Behandlungen häufig, dass das Erkennen und Verstehen der mit einer Hochbegabung verbundenen Besonderheiten im Denken, Erleben und Wahrnehmen auffallend günstige Auswirkungen auf den Heilungsprozess der Klienten hatte. Wie ist dieser Effekt zu erklären?
Sich *›anders als alle anderen‹* zu fühlen, kann zur Entstehung und Aufrechterhaltung einer psychischen Erkrankung offenkundig mit beitragen; sich zumindest einer Minderheit zugehörig zu fühlen, scheint hingegen einen bedeutsamen Einfluss auf die Linderung psychischer Beschwerden zu haben.
Zweitens fördert die *Selbsterkenntnis das Selbstbewusstsein*. Übermäßig stark empfundene Emotionen oder Sinneswahrnehmungen werden nicht als Krankheitssymptome, sondern als typische Merkmale einer Hochbegabung erkannt. Gefühle der Isolation oder sozialen Inkompetenz relativieren sich, wenn ein hochbegabter Klient die Gründe hierfür versteht und die Aussicht erhält, Kontakte zu Gleichgesinnten aufnehmen zu können.
Drittens wird der Klient sich seiner *Potenziale* bewusst, statt ausschließlich auf seine Beschwerden und Defizite zu fokussieren. Mehr noch: Was bislang als Last oder Defizit wahrgenommen wurde, z. B. ein überreiches Gefühlsleben, kann zugleich als innerer Reichtum begriffen werden.

Daher sind nach meiner Auffassung der *Erwerb und die Vermittlung von Kenntnissen der mit einer Hochbegabung verbundenen Phänomene* in der Therapie mit Hochbegabten unverzichtbar.

Beziehungsgestaltung

Das Vorgehen beim Aufbau einer tragfähigen Arbeitsbeziehung mit hochbegabten Klienten möchte ich anhand zweier exemplarischer Therapieverläufe verdeutlichen.

Herr L. ist neunzehn, als er wegen Prüfungsängsten erstmals meine Praxis aufsucht. Zwei vorangegangene Therapieversuche waren nach wenigen Sitzungen gescheitert. Herr L.'s erste Äußerung, als

er mir zur Begrüßung die Hand gibt, lautet: »Oh, gar keine Couch für Gewohnheitsneurotiker?« Wir müssen beide lachen. Herr L. wirkt sehr erwachsen und macht einen äußerst kontrollierten und korrekten Eindruck; er drückt sich sprachlich sehr gewählt aus und klärt mich bereits in der ersten Sitzung über seine umfassenden psychologischen Fachkenntnisse auf. Er ist mit den meisten gängigen Therapieverfahren (Psychoanalyse, Gestalttherapie, Verhaltenstherapie) theoretisch vertraut und teilt mir explizit seine Erwartungen an mein methodisches Vorgehen mit. Er betont sein Misstrauen gegenüber Psychotherapeuten und führt dafür zahlreiche Begründungen an. Gleichzeitig wirkt er sehr unsicher und angespannt und scheint dies hinter seinen sachlich-rationalen Ausführungen zu verbergen. Ich zeige mich von seinem Fachwissen aufrichtig beeindruckt.

Im Verlauf der folgenden Sitzungen scheint Herr L. sein negatives Bild von Psychotherapeuten allmählich zu revidieren, fasst zunehmend Vertrauen und tut sogar zeitweilig seine Begeisterung über die Therapiegespräche kund. Als ich jedoch seinen Wünschen nach einer erhöhten Sitzungsfrequenz und Doppelstunden nicht nachkomme, gerät Herr L. in heftige Wut: Er erklärt alle Psychologen für »Scharlatane, die lediglich an Geld interessiert« seien, erkundigt sich aufgebracht nach meinem Stundenhonorar und droht mit Abbruch der Therapie. Gegen alle Versuche, die eigentlichen Ursachen seines Zorns zu ergründen, setzt er sich heftig zur Wehr.

Nach der Anfangsphase des Misstrauens und einer kurzen Phase der Idealisierung folgte nun also eine Phase der Abwertung. Dieses Muster wiederholte sich in der Folgezeit, jedoch in geringeren Ausschlägen und größeren Intervallen, bis die Phase einer stabilen und vertrauensvollen Arbeitsbeziehung erreicht werden konnte.

Frau B., 41, kommt wegen depressiver Verstimmungen zu mir. Sie wirkt ausgesprochen zurückhaltend, unsicher und angespannt. Es fällt ihr sichtlich schwer, Blickkontakt zu halten und auf meine Fragen spontan zu antworten. Oft nimmt sie Aussagen zurück, beendet begonnene Sätze nicht, schweigt lange und kann sich schwer konzentrieren. Es gelingt mir kaum, mit Frau B. in Kontakt zu kommen. Manchmal scheint sie den Impuls zu unterdrücken, die Sitzung abzubrechen und zu gehen. Die Verhaltensbeobachtung

würde folgende klinische Befunde nahe legen: Konzentrationsstörungen, Antriebsminderung bis zur psychomotorischen Hemmung, unzureichende Fähigkeit zur Introspektion und zum Ausdruck von Emotionen, verlangsamtes Denken, Verdacht auf mittelgradige depressive Episode.

Die ersten Gespräche gestalten sich mühsam und zäh, und es deutet zunächst nichts darauf hin, dass Frau B. hochbegabt sein könnte. In kleinen Schritten gelingt es Frau B. jedoch zu beschreiben, weshalb sie so große Mühe hat, mit mir ins Gespräch zu kommen. Ich äußere:

»Es fällt Ihnen schwer, mich anzusehen.«

»Ja.«

»Es ist Ihnen unangenehm.«

»Nein, nicht direkt. Aber ich kann mich nicht auf das konzentrieren, was Sie sagen, wenn ich Sie gleichzeitig ansehe.«

»Wissen Sie, woran das liegen könnte?«

»Es sind vielleicht zu viele Eindrücke auf einmal.«

»Wie wäre es, wenn Sie die Augen schließen?«

»Das möchte ich nicht. Wenn ich so vor Ihnen sitze und Sie mich ansehen, fühle ich mich unwohl.«

»Das verstehe ich. Wie würden Sie sich wohler fühlen?«

»Weiß nicht.«

»Probieren Sie einmal, sich mit dem Sessel umzudrehen, sodass Sie mit dem Rücken zu mir sitzen.«

Frau B. lächelt verlegen. Ich ermuntere sie, es zu versuchen, und sie dreht sich um.

»Wie ist es jetzt?«

»Komisch. Aber besser.«

»Gut. Wenn Sie wollen, bleiben Sie so sitzen.«

Zu unser beider Erstaunen verlaufen die Gespräche nun bedeutend flüssiger.

»Was geht in Ihrem Kopf vor, wenn ich Ihnen eine Frage stelle?«

»Tausend Gedanken auf einmal.«

»Und Sie können sich nicht entscheiden, welchen davon Sie äußern sollen.«

»Nein. Immer, wenn ich mich für eine Antwort entscheide, denke ich, es könnte auch ganz anders sein.«

»Sie wollen es hunderprozentig richtig ausdrücken.«

»So könnte man es auch sagen.«
»Und da Sie das nicht können, sagen Sie lieber gar nichts.«
Frau B. nickt.
»Wie wäre es, wenn Sie ab jetzt versuchen, ins ›Unreine‹ zu sprechen, also an einer beliebigen Stelle zu beginnen, vielleicht etwas Falsches zu sagen und sich dann langsam an das vorzutasten, was Sie eigentlich sagen wollen?«
Dieser Vorschlag hilft Frau B., sich offener und spontaner zu äußern. In den folgenden Sitzungen berichtet sie, als Erwachsene erfahren zu haben, dass bei ihr im Kindesalter eine autistische Störung diagnostiziert worden sei. Sie habe später in Autobiographien von Autisten gelesen, wie schwer es ihnen falle, mehrere Reize gleichzeitig zu verarbeiten, also etwa in einem Gespräch die Mimik, Gestik, Stimme des Gegenübers *und* den Inhalt des Gesprochenen aufzunehmen. »Ich glaube, ich habe unbewusst viele Strategien für mich entwickelt, um damit einigermaßen normal leben zu können. Ich konnte als Kind zum Beispiel nie Zwieback und Kekse essen. Das Geräusch, das sie beim Kauen verursachten, war so laut, dass ich es nicht ertragen konnte. Ich muss es daher bis heute vermeiden, ›laute‹ Dinge zu essen. Auch fiel mir irgendwann auf, dass ich am Telefon viel besser mit Leuten sprechen kann: Wenn ich sie nicht *sehe*, also ihren Gesichtsausdruck nicht sehe, kann ich mich viel besser auf das Gespräch konzentrieren. Bei Feiern oder Restaurantbesuchen fühlte ich mich meist grässlich. Ich war vollkommen überfordert, so viele Dinge gleichzeitig zu tun: das Essen aussuchen, die Bestellung aufgeben, mich mit den Anwesenden unterhalten, die Speisen essen, die vielen Geräusche ausblenden; heute beschränke ich mich darauf, einzelne Personen nach Hause einzuladen oder sie zu besuchen. Ich habe mit Mühe gelernt, mich in Unterhaltungen auf ein oder zwei Aspekte zu konzentrieren; aber es fällt mir immer noch schwer, vor allem in neuen Situationen mit fremden Personen. In meinem Kopf herrscht oft eine große Unordnung; außerdem kommen mir alle meine Gefühle immer so stark vor, dass ich sehr viel Kraft brauche, um sie auszuhalten.«

In beiden Fallbeispielen werden charakteristische Schwierigkeiten deutlich, die den Aufbau einer tragfähigen therapeutischen Beziehung mit hochbegabten Klienten beeinträchtigen können.

Bevor *Herr L.* mich aufsuchte, hatte er eine Vielzahl belastender und frustrierender Erfahrungen sowohl mit Gleichaltrigen und Lehrern als auch mit Therapeuten gemacht. Er ist trotz seines jungen Alters vielen Behandlern geistig ebenbürtig und kann diesen auf den ersten Blick altklug und überheblich erscheinen; bei der Kontaktaufnahme geht Herr L. offensiv und fordernd vor. Seine extreme Entwicklungsbeschleunigung, seine gewählte Ausdrucksweise, seine verblüffenden Fachkenntnisse, sein Sarkasmus und seine überkritischen Anmerkungen erzeugten auch bei mir zunächst einiges Befremden. Da ich in Herrn L. jedoch ohne Mühe einen Hoch- bzw. Höchstbegabten erkannte, konnte ich mir schnell ein Bild von den Ursachen für seine misstrauische und feindselige Haltung machen. Dies verhinderte, dass ich mich etwa persönlich angegriffen fühlte, Regungen von Antipathie verspürte oder mich in intellektuelle Machtspiele verwickeln ließ. Ich erkannte die Verunsicherung und die Angst vor Enttäuschung, die hinter Herrn L.'s Misstrauen steckten. Dies sprach ich zunächst nur indirekt an, indem ich etwa sagte: »Erwachsene reagieren bestimmt oft irritiert oder ablehnend auf Sie« oder »Es gibt sicher kaum einen Gleichaltrigen, mit dem Sie sich austauschen können«. Hier können die Vorkenntnisse des Therapeuten über Hochbegabung also sehr wertvoll sein.

Frau B. ist extrem zurückhaltend, scheu, unsicher und angespannt. Ihr Mangel an Ausdrucksfähigkeit kann fälschlicherweise als Mangel an Emotionen, ihre stockende Rede als verlangsamtes Denken interpretiert werden. Bei dieser Klientin ist jedoch, wie bei vielen Hochbegabten, das Gegenteil der Fall: Ein *Zuviel* an Gefühlen, Gedanken und Reflektionen kann Sprechhemmungen und Blockaden bewirken. Hier sei nochmals an den Zusammenhang zwischen hoher Introversion, hoher Intelligenz und starker Sensibilität erinnert (z. B. Myers, 1987; Silverman, 1993). Der beschriebene zähe und mühsame Gesprächsverlauf kann beim Therapeuten Gefühle der Hilflosigkeit, Frustration oder Ungeduld hervorrufen. Gelingt es ihm jedoch, die inneren Vorgänge der Klientin zu antizipieren und von sich aus zu formulieren, wird ihm dies leichteren Zugang zu sehr introvertierten Persönlichkeiten verschaffen.
Weiterhin ist der Therapeut hier gefordert, sich maximal auf die

Wesensart der Klientin einzustellen (sog. *pacing*) und Bedingungen zu schaffen, die ihren Bedürfnissen gerecht werden. Der Therapeut sollte sich zurücknehmen, gegebenenfalls leiser sprechen und den Blickkontakt zu Beginn von sich aus reduzieren. Vorschläge und Anregungen für ungewöhnliche Settings, wie z. B. das Umdrehen des Sessels, sollten dabei nicht gescheut werden.

Die Persönlichkeit des Therapeuten

Zunächst erhebt sich die Frage, ob ein Therapeut selbst hochbegabt sein sollte, um hochbegabte Klienten adäquat behandeln zu können. Dies wäre sicher von Vorteil, ist jedoch nicht unbedingt notwendig, wenn der Behandler über die einzelnen Phänomene der Hochbegabung informiert ist und über ausreichend Selbstbewusstsein verfügt, es mit einem geistig überlegenen Klienten aufzunehmen. Dass überdurchschnittliche Intelligenz allein nicht ausreicht und Eigenschaften wie Kreativität, Herzensbildung und Einfühlungsvermögen mindestens ebenso wichtig sind, versteht sich von selbst.

In den Fallbeschreibungen von Herrn L. und Frau B. habe ich bereits einige Aspekte angesprochen, die dem Therapeuten den Aufbau eines guten Kontaktes zu hochbegabten Klienten erschweren können:

Bei kritischen Klienten, die etwa fortwährend therapeutische Methoden und Interventionen hinterfragen, besteht die Gefahr, sich *persönlich angegriffen und kritisiert zu fühlen*, mit *Befremden und Antipathie* zu reagieren oder sich in *intellektuelle Machtspiele* verwickeln zu lassen. Mancher mag gar den Impuls verspüren, seine *therapeutische Autoriät* zu untermauern, indem er das Verhalten und die Äußerungen des Klienten *pathologisiert*, also mit klinischen Störungsbegriffen versieht (wie z. B. Beziehungsstörung, Borderlinestörung, schizoide oder narzisstische Störung etc.).

Der hochbegabte Klient verlangt der Persönlichkeit des Therapeuten also neben seinen fachlichen auch zahlreiche menschliche Qualitäten ab:

Ehrlichkeit und Authentizität: Ein ehrlicher Therapeut weiß nicht auf alle Fragen eine Antwort, kennt nicht jede neue Fachpubli-

kation zu jedem Störungsbild und ist nicht jedem hochbegabten Klienten in allen Belangen gewachsen. Er wird sich einem hoch intelligenten, sehr eloquenten und wachsamen Klienten gegenüber manchmal unbehaglich oder sogar unsicher fühlen. Wenn der Therapeut selbst oder seine Methoden kritisch hinterfragt werden und er auf Widersprüche hingewiesen wird, fehlen ihm vielleicht manchmal die Worte; wenn ein Klient in hohem Tempo komplexe Sachverhalte schildert, wird der Therapeut nicht immer folgen können; wenn der Klient über für ihn wichtige anspruchsvolle Themen wie z. B. Philosophie, Astronomie, Theologie oder Quantenphysik spricht, wird nicht jeder Therapeut mitreden können.
Diesbezügliche Unsicherheiten überspielen zu wollen, ist für den Therapeuten anstrengend und für den Klienten in der Regel irritierend. Weitaus fruchtbarer ist es, die eigenen Unzulänglichkeiten genauso zu bekennen, wie der Therapeut sie wahrnimmt:
»Das ist eine knifflige Frage; darüber muss ich mir erst einmal in Ruhe Gedanken machen.«
»Sie kennen sich in der psychologischen Fachliteratur erstaunlich gut aus. Ich würde den von Ihnen zitierten Artikel gerne noch einmal nachlesen.«
»Ihr logisches Denkvermögen ist beachtlich. Dieser Widerspruch war mir bisher nicht aufgefallen.«
»Ich muss gestehen, dass mir im Augenblick die Worte fehlen. So viel Schlagfertigkeit erlebe ich selten.«

Auf diese Weise erhält der Klient *Respekt und Anerkennung*: Er sieht sich in seinen besonderen Fähigkeiten bestätigt und erfährt in der Therapie vielleicht erstmals keine Ablehnung oder Missbilligung seiner kritischen Verhaltensweisen. Die Befürchtung, dass man als Therapeut an Autorität verliert, wenn man an mancher Stelle die Überlegenheit des Klienten einräumt, ist nach meiner Erfahrung unbegründet. Zumeist tritt ein gegenteiliger Effekt ein: Die Atmosphäre wird offener und entspannter, der Klient fühlt sich sicherer, respektiert den Therapeuten mehr und stellt ihn seltener auf die Probe.

Gemeinsames Arbeiten: Viele hochbegabte Klienten haben vor Beginn einer Therapie schon selbst einige Überlegungen zu ihrer Stö-

rung angestellt und sich psychologische Kenntnisse angeeignet. Indem ich anerkenne, es mit einem geistig ebenbürtigen Gegenüber zu tun zu haben, entsteht eine Atmosphäre des *gemeinsamen* Arbeitens, Nachdenkens und Analysierens. Der Behandler muss die Bereitschaft zeigen, sich Diskussionen zu stellen und eigene Positionen gegebenenfalls zu hinterfragen.

Selbstkritik und Humor: Die Fähigkeit zur Selbstkritik und Selbstironie gehört vielleicht zu den wichtigsten persönlichen Eigenschaften eines Therapeuten, der mit Hochbegabten arbeitet.
Gewöhnlich wird von Therapeuten erwartet, aus überlegener fachlicher Perspektive zu handeln und zu urteilen. Er ist somit bemüht, den Anschein einer stabilen, stets ausgeglichenen und selbstsicheren Persönlichkeit zu erwecken, die keine seelischen Krisen, Selbstzweifel oder sonstigen Anfechtungen kennt. Diesbezügliche Stellungnahmen werden jedoch von manchen Hochbegabten hartnäckig eingefordert. Der Therapeut wird glaubwürdiger, wenn er an geeigneter Stelle erwähnt, wie er selbst mit bestimmten Schwierigkeiten umgeht, statt auf absoluter Neutralität zu bestehen. Selbstbekenntnisse sollten natürlich wohl dosiert erfolgen und immer in Bezug zu den Problemen des Klienten stehen (zur Wirksamkeit von Selbstoffenbarungen des Therapeuten vgl. Knox, 2003). Ein Therapeut, der sich überdies kritisch und humorvoll betrachten kann, ist ein gutes ›Modell‹ für hochbegabte Klienten, die häufig überhöhte Perfektionsansprüche an sich selbst und ihre Umgebung stellen.

Ich hatte es bereits an anderer Stelle angemerkt: Von der therapeutischen Haltung, die ich im Umgang mit Hochbegabten gelernt habe, profitiert mittlerweile auch meine Arbeit mit allen anderen Klienten.

Intelligenzdiagnostik bei hochbegabten Erwachsenen

Die meisten erwachsenen Hochbegabten wissen nichts von ihrer Hochbegabung. Manche haben bereits irgendwann einen Intelligenztest gemacht, messen dem weit überdurchschnittlichen Ergebnis jedoch keine besondere Bedeutung zu.

Wenn der Therapeut den Eindruck hat, einen hochbegabten Klienten vor sich zu haben, kann er folgende Anzeichen genauer beobachten oder gezielt erfragen:

1. Hohes Denk- und Sprechtempo; ggf. sprunghaftes, assoziatives Denken
2. Gutes sprachliches Ausdrucksvermögen; ggf. gewählte Ausdrucksweise
3. Ausgiebiges Reflektieren; ggf. Schwierigkeiten bei der Entscheidungsfindung
4. Gutes Abstraktionsvermögen und logisches Denken
5. Freude an kontroversen Diskussionen; kritisches Hinterfragen therapeutischer Methoden
6. Vorliebe für absurden Humor
7. Individualismus und Nonkonformismus; ungewöhnliche Anschauungen
8. Beschäftigung mit anspruchsvollen Themen
9. Gefühle des Andersseins; ggf. Schwierigkeiten in sozialen Kontakten
10. Ggf. Vermeiden von Großveranstaltungen aller Art
11. Besonderheiten in der Sinneswahrnehmung (Licht/Lärmempfindlichkeit)
12. Überhöhte Selbstansprüche, Perfektionismus, Selbstzweifel
13. Erhöhte emotionale Sensibilität

Trifft ein Großteil dieser Merkmale auf einen Klienten zu, empfiehlt es sich, den Verdacht auf eine Hochbegabung zunächst sehr behutsam anzusprechen; erwachsene Hochbegabte reagieren oftmals irritiert, ablehnend oder sogar aufgebracht, wenn man ihnen besondere Begabungen ›unterstellt‹. Viele befürchten, dass sie von anderen überschätzt werden und mit einem Intelligenztest die Wahrheit ans Licht käme, sie also ›nur‹ durchschnittlich oder unterdurchschnittlich abschneiden. Manche äußern, dass sie sich von dem Wissen um ihre Hochbegabung überfordert fühlen könnten: »Den Ansprüchen, die ich selbst oder andere dann an mich stellen, kann ich wahrscheinlich gar nicht gerecht werden.«
Man sollte unsichere und skeptische Klienten selbst entscheiden lassen, ob und wann sie einen Intelligenztest machen möchten. Es kann vorerst ausreichend sein, den Klienten über Anzeichen und

Besonderheiten von Hochbegabung aufzuklären und ihm geeignete Literatur oder Kontaktadressen zu empfehlen.

Depressionen, Angsterkrankungen und Leistungsstörungen

Depressive Störungen und Angsterkrankungen gehören in der klinischen Psychologie zu den am häufigsten diagnostizierten seelischen Erkrankungen; da dies nach meiner Erfahrung Hochbegabte ebenso betrifft wie Normalbegabte, werde ich auf diese Störungsbilder näher eingehen.

Zur psychotherapeutischen Behandlung von hochbegabten Erwachsenen gibt es bis heute keine Theorien und systematischen Forschungen. Der Aspekt der Hochbegabung wurde in der psychologischen Fachliteratur und im therapeutischen Geschehen bislang nicht berücksichtigt.
Hypothesen über die Häufigkeit seelischer Störungen bei hochbegabten Erwachsenen sind sehr umstritten, diesbezügliche Daten sehr widersprüchlich. Scheidt (2004) schätzt, dass etwa ein Drittel aller Hochbegabten, die sog. *Talente*, ihre Fähigkeiten erfolgreich umsetzt. Ein weiteres Drittel bezeichnet der Autor als *Latente*, die zwar im Leben gut zurechtkommen, ihre Potenziale jedoch nicht verwirklichen. Das letzte Drittel seien die eigentlichen *Underachiever*, die ihre Begabungen in keiner Weise umsetzen können oder wollen. Scheidts Schätzungen stützen sich auf eine Vielzahl stark differierender Forschungsergebnisse: Der Anteil angenommener Underachiever unter den Hochbegabten reicht von 15 % (z. B. Rost, 2000) bis 50 % (z. B. Winner, 1998).
Scheidts Vermutung, dass so definierte Underachiever »in höchstem Maße gefährdet (sind) durch Depressionen, Drogensucht und sogar Suizid« (S. 62), liegt zwar nahe, ist meines Wissens jedoch noch nicht empirisch untersucht und belegt. Hier besteht noch großer Forschungs- und Handlungsbedarf.
Auf die Tatsache, dass in Termans Langzeitstudie (ab 1925) problematische Hochbegabte und Underachiever nicht berücksichtigt wurden und sie somit im Hinblick auf seelische Störungen bei Hochbegabten nur bedingt aussagekräftig ist, hatte ich bereits hingewiesen. Schon Goertzel (1965) erwähnte, dass hochbegabte Er-

wachsene als Kinder oftmals nicht als frühbegabt identifiziert oder gar aus Förderprogrammen ausgeschlossen wurden, weil sie persönliche Probleme hatten (S. 151).
Den größten Anteil psychischer Erkrankungen bei Hochbegabten stellen in meinen Behandlungen *depressive Entwicklungen*, *Leistungsstörungen und Prüfungsängste* sowie *Kontaktprobleme* und *soziale Phobien*. Auch autistische Symptome (s. Kap. VI. 2) und Borderline-ähnliche Züge wurden von mir häufig festgestellt. Den so genannten Borderline-Persönlichkeiten möchte ich im Anschluss ein eigenes Kapitel widmen.

Fallbeispiel: Depressionsbehandlung

Frau M. ist 53 und sucht meine Praxis wegen wiederkehrender depressiver Verstimmungen auf. Sie ist eine gepflegte, eher konservative Erscheinung und schildert ihre Probleme in sehr gewählter, sachlicher Sprache. Ihr beinahe einschüchterndes Auftreten und ihre präzise Ausdrucksweise erinnern an eine kompetente und erfahrene Studienrätin. Frau M. macht einen freundlichen, selbstsicheren und kontrollierten Eindruck und richtet viele fachliche Fragen an mich. Als Therapeut ist man zunächst versucht, ein Fachgespräch auf hohem Niveau zu führen, statt sich eingehend nach dem Gefühlsleben der Klientin zu erkundigen. Mein Eindruck, dass Frau M. möglicherweise hochbegabt (und damit hoch sensibel) sein könnte, hilft mir jedoch, immer wieder auf ihre Gefühle und Probleme zu fokussieren. Zu Beginn reagiert Frau M. hierauf mit rationalisierenden, knappen Äußerungen und einem auffallend ›strengen‹ Gesichtsausdruck – den ich erst nach einiger Zeit als Zeichen extremer Anspannung identifiziere. Frau M. berichtet, unter Selbstzweifeln, Stimmungsschwankungen, Niedergeschlagenheit, Albträumen und Gefühlen der Orientierungslosigkeit zu leiden. Dies steht in auffallendem Widerspruch zu ihrem selbstbewussten Auftreten, was ich nach einigen Sitzungen anspreche:
»Es ist bemerkenswert, wie selbstsicher und souverän Sie auftreten, obwohl Sie sich innerlich so unsicher fühlen. Ist das auch anderen Personen schon aufgefallen?«
»Es ist mir nicht bewusst, dass ich so souverän wirke. Aber an der

Reaktion anderer merke ich oft, dass sie mich für sehr selbstbewusst und stark halten müssen.«
»Welche Reaktionen sind das?«
»Ich habe den Eindruck, dass man mich härter anfasst als andere, dass man mir mehr zumutet und zutraut. Viele scheinen gar nicht glauben zu können, dass auch ich Gefühle habe.«
»Ist meine Vermutung richtig, dass Sie sogar besonders sensibel sind?«
»Ich bin absolut überempfindlich! Es ist unnormal. Ich reagiere auf die kleinste Kleinigkeit mit extremer Anspannung, sogar mit Angst. Ich nehme mir alles viel zu sehr zu Herzen und brauche zum Beispiel nach einem Streit Stunden, um mich wieder zu beruhigen.«
»Das heißt: Sie sind überempfindlich und werden von anderen auch noch besonders hart angefasst. Das stelle ich mir sehr schwer vor.«
»Ja. Wenn ich denke, dass ich etwas ganz Normales sage, werde ich von anderen angegriffen.«
»Können Sie ein Beispiel nennen?«
»Letzte Woche fasste ich auf einem Elternabend nach längerer Diskussion die wichtigsten Punkte zusammen und machte einen Vorschlag, wie man sich einigen könnte. Sofort reagierten der Klassenlehrer und einige Eltern darauf mit sehr aggressiven Äußerungen. Auch im Privatleben mache ich solche Erfahrungen häufig.«
»Haben Sie dafür eine Erklärung?«
»Nein, ich verstehe es absolut nicht.«
»Kommen wir nochmal auf meinen ersten Eindruck von Ihnen zurück: Sie wirken auf mich sehr kompetent, gebildet und selbstsicher. Ihre Empfindsamkeit und Unsicherheit merkt man Ihnen zunächst überhaupt nicht an. Wenn wir über Ihre Gefühle sprechen, erscheinen Sie sogar besonders streng und kritisch.«
»Tatsächlich? Das fällt mir gar nicht auf. Was soll ich Ihrer Meinung nach denn tun?« Frau M. wirkt an dieser Stelle erneut angespannt und nahezu gereizt.
»Verletzt es Sie, wenn ich so etwas sage?«
»Nicht direkt, wieso sollte es mich verletzen? Sie sind schließlich Therapeutin und werden gute Gründe haben, sich so zu äußern.«
»Selbst dann könnte es Sie verletzen.«
»Ich bin … nein, es macht mich natürlich nicht gerade froh, wenn selbst meine Therapeutin mich für ›streng‹ und selbstsicher hält.«

»Das verstehe ich. Was empfinden Sie jetzt?«
Frau M. beginnt unvermittelt zu weinen: »Ich *weiß* ja, wie überempfindlich ich bin! Ja, es verletzt mich, es macht mich ganz hilflos und unglücklich, wenn ich auf andere so anders wirke, als ich bin.«
»Sie möchten anderen Ihre Empfindsamkeit so zeigen, wie Sie sie jetzt im Augenblick mir zeigen können.«
»Nein, das nicht. Man würde mich für hysterisch halten und ich mache mich *noch* verletzlicher.«
»Wenn Sie andere merken lassen, dass Sie eine gefühlvolle, sensible Frau sind, würde man Sie für hysterisch halten?«
»Sicher.«
»Deshalb tun Sie alles, um Ihre starken Gefühle zu verbergen.«
»Genau.«
»Könnte es sein, dass Sie gerade deshalb so kontrolliert wirken?«
»Das ist gut möglich.«
»Wenn andere nicht bemerken, dass Sie sehr sensibel sind, und Sie im Gegenteil für besonders robust halten, werden Sie auch nicht zartfühlend behandelt.«

Die äußere Angespanntheit und Kontrolliertheit ist für viele Hochbegabte typisch. Auch ihre Intellektualität trägt dazu bei, dass sie überlegen und selbstsicher wirken; zeitweilig nutzen sie diese auch, um ihr intensives Gefühlsleben zu verbergen. Frau M. erkennt im Laufe der Therapie, dass sie sowohl souverän als auch feinfühlig sein kann. Gerade hochbegabte Frauen beschreiben sich oft als sehr stark und sehr verletzlich zugleich.
Frau M. ist ausgesprochen überrascht, als ich meine Vermutung äußere, sie sei eventuell hochbegabt.
»Wie kommen Sie denn auf diese Idee? Nein, ich bin alles andere als hochbegabt. Aber ich habe festgestellt, dass ich andere gut täuschen kann. Ich wirke intelligenter, als ich bin.«
»Das heißt, Sie täuschen Ihre Intelligenz nur vor?«
»Ja. Das habe ich vermutlich deshalb perfektioniert, damit andere nicht merken, wie wenig ich weiß und kann.«
»Muss jemand, der Intelligenz so gut vortäuschen kann, nicht ziemlich clever sein?«
»In gewisser Weise schon …«
»Es gelingt Ihnen sogar, mir als Expertin etwas vorzumachen.«

Viele Hochbegabte halten sich für ›Blender‹ und fürchten stets, dass man ihnen eines Tages auf die Schliche kommen wird. Deshalb bemühen sie sich umso mehr, keine Fehler zu machen oder Schwächen erkennen zu lassen. Dies ist ein weiterer Grund, warum Hochbegabte nach außen hin oft sehr sicher oder ›perfekt‹ wirken. Sie meinen, sie müssten sich *besonders* viel Wissen aneignen, besonders schlüssig argumentieren und besonders viel leisten, damit ihre Unzulänglichkeiten nicht aufgedeckt werden. Aufgrund ihres ›weiten Horizontes‹ können sie einschätzen, wie viel sie noch *nicht* wissen. Wenn sie den überhöhten Ansprüchen an sich selbst nicht genügen können, zweifeln sie oft mehr als andere an ihren Fähigkeiten und unterschätzen sich. *Die Furcht, ›entlarvt‹ zu werden, ist also meist der eigentliche Grund für den Perfektionismus von Hochbegabten.*

Selbst nachdem das Testergebnis Frau M.'s Hochbegabung bestätigt hatte, braucht sie noch lange, um diese Tatsache zu akzeptieren. Einerseits ist sie erleichtert, andererseits schockiert.
Ich habe mich oft gefragt, warum das Erkennen der eigenen Begabungen so häufig Angstgefühle auslöst. Dass hohe Begabung möglicherweise als hohe Verpflichtung wahrgenommen wird, scheint mir als Erklärung nicht auszureichen. Diese Frage wird mich und meine Klienten also noch weiterhin beschäftigen.
Frau M. gelingt es, im Verlauf der Therapie ihre *besonderen Fähigkeiten anzuerkennen* und ihre *erhöhte Sensibilität nicht nur als Last, sondern auch als Potenzial* zu begreifen; dies setzt sie unter anderem in *künstlerische Aktivitäten* um, die ihr viel Freude bereiten. Frau M. lässt ihr *intensives Gefühlsleben vermehrt nach außen hin sichtbar* werden, was in sozialen Kontakten auf sehr positive Resonanz stößt; auch fühlen sich nun Personen von ihr angezogen, die über einen ähnlichen Gefühlsreichtum verfügen. Da Frau M. ihre Stärken und Fähigkeiten besser einschätzen kann, betrachtet sie auch ihre *Schwächen mit mehr Nachsicht*. Angesichts dieser Entwicklungen münden Krisen und Belastungssituationen bei Frau M. nicht mehr in depressiven Episoden – nicht zuletzt deshalb, weil sie traurige Phasen durch ihr Wissen um die besondere Empfindsamkeit Hochbegabter nun anders bewertet.

Fallbeispiel: Behandlung von Arbeitsstörungen und Prüfungsangst

Als *Herr F.*, 27, mich wegen Arbeitsstörungen und Prüfungsängsten aufsucht, studiert er im vierzehnten Semester Biologie; er hat die Zwischenprüfung zwei Mal nicht bestanden und plant nun seinen dritten und letzten Anlauf. Zwar macht er sich wenig Hoffnungen auf Erfolg, möchte sich aber sagen können, »wenigstens alles versucht« zu haben. Das Studium sei für ihn, obwohl ihn das Fach sehr interessiere, bislang »eine einzige Quälerei« gewesen. Bei Herrn F. war bereits im Vorfeld eine Hochbegabung diagnostiziert worden. Nach eigenen Aussagen habe er mit diesem Ergebnis jedoch »nicht viel anfangen« können:

»Intelligenztests können irren; viele Verfahren gelten ja ohnehin als fragwürdig. Außerdem, was nützt es mir, hochbegabt zu sein, wenn ich beim Lernen die einfachsten Zusammenhänge nicht verstehe? Manchmal muss ich einen Absatz zehn Mal lesen, bevor ich begreife, um was es geht.«

»Was die Testverfahren angeht, mögen Sie in gewisser Weise Recht haben. Es gibt viele Faktoren, die ein Ergebnis nach *›unten‹* hin verfälschen können, jedoch nur sehr wenige, die es nach *›oben‹* hin verfälschen; es sei denn, jemand hätte vorher ganz viele Testreihen geübt. Aber vielleicht könnte man es so ausdrücken: Ein hohes Ergebnis im Intelligenztest garantiert noch nicht, dass man gut lernen und Prüfungen gut bewältigen kann.«

»Sehr richtig.«

»Heißt das umgekehrt: Jemand, der in Prüfungen versagt, kann nicht besonders intelligent sein?«

»Das heißt es natürlich nicht.«

»Also gut. Nehmen wir einmal an, der Intelligenztest hat Recht und Sie sind hochbegabt. Welche Ursachen kämen dann für Ihre Lernschwierigkeiten in Betracht?«

»Weiß nicht. Schlechtes Konzentrationsvermögen.«

»Was geht Ihnen zum Beispiel durch den Kopf, wenn Sie den Inhalt eines Abschnittes nicht gleich verstehen?«

»Ich werde nervös. Die Zeit wird immer knapper und ich *muss* es schaffen, es ist meine letzte Chance. Aber wieso sollte ich es jetzt schaffen, wenn ich schon die beiden Male davor versagt habe?«

»Woran denken Sie noch?«
»Ich überlege, ob das Fach vielleicht doch zu schwer für mich ist. Eigentlich ist es genau das, was mich am meisten interessiert. Aber möglicherweise bin ich zu blöd oder nicht dafür geeignet; vielleicht sollte ich mir doch was anderes suchen. Aber dafür ist es wiederum zu spät; was soll ich nach sieben Jahren Studium noch für eine Ausbildung anfangen? Es nimmt mich doch keiner mehr. Und selbst wenn ich bestehe: Wie soll ich später erklären, warum ich so lange für mein Studium gebraucht habe?«
»Es kommt Ihnen ausweglos vor.«
»Es *ist* ausweglos.«
»Trotzdem sind Sie zur Therapie gekommen, um es noch einmal zu versuchen. Obwohl es sinnlos ist. So gesehen hätten Sie eigentlich nichts zu verlieren.«
»So gesehen schon.«
»Ich schlage vor, wir probieren es einfach, und wenn es nicht klappt, überlegen wir gemeinsam, wie es weitergehen kann.«
»Wenn Sie meinen …«
»Also: Sie sagten, Sie können sich schwer konzentrieren. Das ist nicht verwunderlich, wenn Sie sich beim Lernen so viele beunruhigende Fragen stellen. Das geht übrigens vielen Hochbegabten so: Sie denken stets weit voraus, stellen vieles in Frage und machen sich Gedanken über alle möglichen künftigen Konsequenzen. Die Angst, dass ihre Befürchtungen eintreffen, hindert sie schließlich daran, sich selbst auf einfache Inhalte zu konzentrieren.«
»Das könnte auch auf mich zutreffen.«
»Die Gedanken, die Sie sich machen, sind im Prinzip sinnvoll, aber nicht zu jeder Zeit. Vielleicht gelingt es Ihnen, sich zu sagen, dass Sie diese Gedanken verschieben werden, zum Beispiel auf unseren Sitzungstermin. Hier können wir uns ausführlich damit befassen.«
»Gut, ich kann es versuchen.«
»Wie genau gehen Sie beim Lernen vor?«
»Ich nehme mir zum jeweiligen Thema einen Stapel Bücher und fange an zu lesen.«
»Wie lange etwa?«
»So lange, bis ich nicht mehr kann. Manchmal eine Stunde, manchmal neun.«
»Jeden Tag?«

»Ja. Aber an vielen Tagen drücke ich mich dauernd um den Schreibtisch herum. Ich lese ein paar Seiten, mache wieder etwas anderes, lerne wieder eine Weile … so bin ich den ganzen Tag mit Lernen beschäftigt, aber es kommt nichts dabei heraus.«
»Auf diese Weise lernen Sie weder richtig, noch erholen Sie sich richtig. Deshalb empfehle ich Folgendes: Am kommenden Wochenende spannen Sie aus und tun etwas, das Ihnen Freude macht. So gehen Sie gestärkt in die nächste Arbeitsphase. In der nächsten Woche halten Sie sich an einen strikten Lernplan: drei Stunden vormittags, jeweils mit zehnminütigen Pausen, und drei Stunden am späten Nachmittag.«
»Am Wochenende nichts lernen? Und ab Montag nur fünf bis sechs Stunden am Tag? Das ist viel zu wenig, das kann ich mir nicht erlauben!«
»Ihre bisherige Strategie ist, zwischen einer und neun Stunden zu lernen. Im Schnitt kommen dabei fünf Stunden am Tag heraus, die, wie Sie sagen, wenig effektiv sind. Also könnten Sie es riskieren, eine andere Strategie zu versuchen.«

Herr F. lässt sich auf meinen Vorschlag ein, obwohl er sehr misstrauisch ist. Er stellt fest, dass er sich nach dem erholsamen Wochenende deutlich leistungsfähiger fühlt. Die festgelegten Arbeits- und Pausenzeiten geben Herrn F. eine klare Struktur, die für viele Hochbegabte hilfreich ist. Zudem erarbeitet er sich nun einzelne Arbeitseinheiten in kleinen Schritten; das Erreichen kleinerer, überschaubarer Teilziele wirkt sich positiv auf Herrn F.'s Lernmotivation aus. Auch bei ihm löst eine Aufgabe oft eine Vielzahl von Denkvorgängen aus; er verliert sich im Detail, zieht zu viele Aspekte und Überlegungen in Betracht und liest eher zu viel als zu wenig Prüfungsliteratur. Der Blick für das Wesentliche kommt ihm dabei leicht abhanden; daraus resultierende Misserfolgserlebnisse frustrieren ihn und lassen ihn an seinen Fähigkeiten zweifeln. Diese Zweifel münden schnell in Grundsatzüberlegungen, ob er überhaupt intelligent genug sei oder die richtige Studienwahl getroffen habe. Herr F. wird angehalten, beim Bearbeiten von Lernstoff ›stur nach Schema F‹ vorzugehen, sich den Inhalt in kleinen Schritten zu erarbeiten und die jeweils zentrale Aussage des Textes in wenigen Stichworten in ein Heft zu notieren. In der letzten Prüfungsphase ar-

beitet er nicht mehr mit Büchern, sondern nur noch mit seinen Notizen. Auch diese Struktur-Vorgabe hilft Herrn F., in dem Wust von Literatur den Überblick zu behalten.
Parallel werden mit Herrn F. ein objektiveres Selbstbild der eigenen Fähigkeiten und hilfreiche Selbstinstruktionen erarbeitet sowie Prüfungssituationen simuliert. Seine Prüfung hat er mit gerade noch ausreichendem Erfolg bestanden, womit er jedoch sehr zufrieden war.

Die Ursachen von Lern- und Arbeitsstörungen bei Hochbegabten sind also meist, dass sie *zu schnell und zu komplex denken*, *zu viel lernen* und *zu hohe Ansprüche* an sich stellen. Auch ihre Neigung zum Perfektionismus und zu Selbstzweifeln sowie entsprechende Schwierigkeiten bei der Misserfolgsverarbeitung müssen beachtet werden. Häufig ist es eher ihre *Übermotiviertheit*, die zu schlechten Lernergebnissen führt, als ein Mangel an Motivation. Daher sind für erfolgreiches Lernen die *Verlangsamung des Denkens*, die *Konzentration auf das Wesentliche*, ein *hoher Strukturiertheitsgrad* von Lernplänen und der *Abbau von überhöhtem Perfektionsstreben* notwendig. Hochbegabte sind übrigens meist sehr empfänglich für eine *logische Argumentation* im Therapiegespräch, sodass kognitive Methoden schnell greifen.

Fallbeispiel: Behandlung von Sprechangst und sozialer Phobie

Frau G. ist 26, Jurastudentin und kommt wegen Sprechängsten und einer sozialen Phobie in meine Behandlung. Sie äußert sich leise und zurückhaltend, ihre Haltung und Mimik erscheinen steif und unbeweglich. Frau G. stellt mir sehr präzise Fragen und erwartet ebenso präzise Antworten. In den ersten Sitzungen scheint sie mich sehr genau zu beobachten; an ihrem Gesichtsausdruck sind keinerlei Gefühlsregungen ablesbar. Frau G. scheint kein Detail zu entgehen und man fühlt sich als Therapeutin kritisch unter die Lupe genommen. Die Klientin korrigiert mich häufig, wenn ich eine Äußerung von ihr nicht korrekt wiedergebe oder eine ähnliche Frage zwei Mal stelle. Sie hat ein außerordentlich gutes Gedächtnis und kann auch nach vielen Sitzungen Sätze von mir Wort für Wort

wiedergeben. Frau M. erscheint sehr misstrauisch und zweifelt schnell, ob man sie wirklich ernst nimmt und ihr genau zuhört. Ich muss ein wenig Acht geben, dass ihre vorsichtige, übergenaue Haltung sich nicht auf mich überträgt und ich mich von ihren kritischen Anmerkungen nicht nervös machen lasse.
Das Interaktionsgeschehen in der Therapie können wir gut nutzen, um zu analysieren, was in anderen sozialen Kontakten vor sich geht. Es stellt sich mit der Zeit heraus, dass Frau G.'s kritisches Misstrauen nicht auf Überheblichkeit zurückzuführen ist, sondern auf ihre Angst in sozialen Situationen. Eigentlich ist es sie selbst, die kritische Betrachtung und negative Bewertung fürchtet; um mögliche Angriffe oder Verletzungen zu verhindern, nimmt sie ihr Gegenüber mit höchstmöglicher Aufmerksamkeit in Augenschein.
»Haben Sie eine Vermutung, wie es auf andere wirkt, wenn Sie sie so genau beobachten?«
»Hm. Sie fühlen sich … beobachtet?« Frau G. lächelt.
»Sehr wahrscheinlich. Mir selbst ging es zu Beginn der Therapie mit Ihnen auch so. Ich hatte den Eindruck, als würden Sie mich recht kritisch beäugen und als müsste ich meine Worte Ihnen gegenüber sehr sorgfältig wählen.«
»Tatsächlich? Das lag überhaupt nicht in meiner Absicht.«
»Das weiß ich jetzt, nachdem ich Sie besser kennen gelernt habe. Aber meine spontane Reaktion auf Sie ist vielleicht ein wichtiger Hinweis darauf, warum andere manchmal, wie Sie sagen, merkwürdig auf Sie reagieren.«
»Sie meinen, andere fühlen sich von mir vielleicht ebenso kritisch von mir betrachtet wie umgekehrt?«
»Ich bin mir nicht sicher, aber es könnte sein. Ich möchte Sie bitten, das einmal in konkreten Situationen zu überprüfen. Enge Freunde oder ihren Partner können Sie direkt danach fragen. Bei Studienkollegen sehen Sie sich deren Reaktionen auf Sie einmal genauer an; versuchsweise unter dem Blickwinkel, den Sie eben genannt haben: Welche Anzeichen deuten darauf hin, dass die anderen sich unter meiner genauen Beobachtung unbehaglich fühlen?«

Frau G.'s Leistungen im Studium sind sehr gut; darüber ist sie jedoch immer wieder überrascht. Bei jeder Klausur oder Hausarbeit rechnet sie mit einem schlechten Ergebnis. Meist hat sie das Gefühl,

sie habe »Glück gehabt« oder es sei »gerade nochmal gutgegangen«.
Vor Seminaren, Repetitorien und Referaten hat Frau G. große Angst.
»Ich bin jedes Mal so aufgeregt, dass mir fast schlecht wird. In der Nacht davor kann ich kaum schlafen. Wenn ich vor anderen sprechen oder etwas vortragen muss, klopft mein Herz so heftig, dass ich glaube, alle müssten es sehen. Ich bekomme kaum Luft und meine Stimme versagt. Mein Kopf ist dann ganz leer und ich kann keinen klaren Gedanken fassen. Meine Knie zittern, mir bricht der Schweiß aus und ich möchte am liebsten davonlaufen.«
»Sie geraten regelrecht in Panik.«
»Ja. Obwohl ich *weiß*, dass ich den Stoff beherrsche.«
»Es ist für Sie jedes Mal eine Qual.«
»Das hört sich übertrieben an, aber ja, es ist eine Qual.«
»Was könnte in so einer Situation schlimmstenfalls passieren?«
»Dass mir die Stimme versagt und ich nicht weiterreden kann.«
»Was würden Sie in diesem Fall tun?«
»Hinauslaufen natürlich. Aber das wäre für mich das Schlimmste… die Scham, mich so bloßgestellt zu haben.«
»Ja, das wäre wirklich sehr unangenehm. Was befürchten Sie, könnte passieren, wenn Sie sich bloßgestellt haben?«
»Ich weiß nicht, man würde über mich lachen, mich vielleicht ausgrenzen …«
»Haben Sie etwas Ähnliches schon einmal erlebt?«
»Naja, ich kenne es aus meiner Schulzeit. Wenn ich vor der Klasse etwas sagte, reagierten die anderen immer komisch. Entweder sie guckten mich verständnislos an oder sie lachten; manchmal überging man meine Äußerungen einfach, manchmal ging sofort ein Sturm der Empörung los.«
»Sie haben also sehr viele schlechte Erfahrungen gemacht. Deshalb haben Sie gute Gründe, misstrauisch und ängstlich zu sein, wenn Sie vor anderen sprechen.«

Wir analysierten gemeinsam, dass die Entwicklung der sozialen Phobie von Frau G. durch mehrere Faktoren begünstigt wurde: Als Hochbegabte war sie in ihrer Schulzeit *Außenseiterin und vielfach Anfeindungen ausgesetzt*. Diese erlebte sie, auch aufgrund ihrer

hohen emotionalen Sensibilität, als extrem belastend, sodass sie das Sprechen vor Gruppen bis heute mit Angst verknüpft.
Die Mehrzahl *aller* Menschen empfindet ein gewisses Maß an Aufregung, wenn sie vor einer größeren Gruppe etwas vortragen. Durch ihre hohe *Reizsensibilität bzw. erhöhte neuronale Erregbarkeit* erleben Hochbegabte, besonders wenn sie eher introvertiert sind, diese Aufregung als übermäßig stark. In Verbindung mit phobischen Komponenten kann das Sprechen vor Gruppen dann zur unüberwindbaren Hürde werden.
Ein dritter Faktor sind auch hier das *hohe Perfektionsstreben* und die damit einhergehenden *Versagensängste* vieler Hochbegabter. Oft leiden nämlich genau die Menschen, welche über große Redegewandtheit und sprachliches Talent verfügen, unter Sprechangst. Hier zeigt sich erneut das bereits angesprochene Phänomen, dass mancher Hochbegabte *gerade auf dem Gebiet seiner größten Begabung scheitert*, weil seine Selbstansprüche unerfüllbar hoch angesiedelt sind und seine Selbstkritik übermäßig streng ausfällt. Es gibt viele Beispiele von Schriftstellern, die aus diesem Grund über Jahre keine Zeile zu Papier bringen, oder Musikern, die jahrelang nicht konzertieren können.
Ein vierter Gesichtspunkt bei der Entstehung sozialer Phobien bei Hochbegabten ist ihre feine soziale und emotionale Wahrnehmungsfähigkeit. Diese ist einerseits eine besondere Gabe, andererseits werden *soziale Signale bisweilen überinterpretiert*. Frau M. wertet kleinste mimische, stimmliche oder gestische Veränderungen ihres Gegenübers aus und kommt dabei aufgrund ihrer schlechten Vorerfahrungen häufig zu falschen Schlüssen.
Auf der Grundlage dieser Erläuterungen, die sich für Frau G. als hilfreich und entlastend erwiesen, fruchteten die im Anschluss angewandten kognitiv-verhaltenstherapeutischen Methoden (Korrektur irrationaler Grundüberzeugungen, Konfrontationsübungen) schnell und nachhaltig. Frau G. erklärte zum Ende der Therapie: »Ich habe immer noch Angst, wenn ich ein Referat halte, aber sie ist nicht mehr so unerträglich stark. Und ich lasse mich von der Angst nicht abhalten, etwas zu tun, das mir wichtig ist. Außerdem habe ich festgestellt, dass ich selbst dann noch ganz gute Leistungen bringen kann, wenn ich unter Hochspannung stehe.«

Brauchen Hochbegabte eine besondere Behandlung?

Wenngleich die bisher beschriebenen Klienten unter einem starken Leidensdruck standen, wiesen sie doch vergleichsweise gut behandelbare Störungen mit guten Heilungschancen auf. Allerdings muss man sich die Frage stellen, wie das Leiden der Betreffenden sich entwickelt hätte, wenn sie auf einen Therapeuten getroffen wären, der die spezifischen Aspekte der Hochbegabung in der Behandlung nicht berücksichtigt hätte.
Scheidt (2004) konstatiert: »Eine Berufsgruppe scheint gar nicht wahrzunehmen, dass Hochbegabung ein Phänomen ganz eigener Art ist, dem man mindestens so viel Bedeutung zumessen muss wie der Triebdynamik: die Psychoanalytiker (…).« (S. 128) Dies betrifft meines Erachtens nicht nur Psychoanalytiker, sondern Psychotherapeuten aller Schulen.

Bei Nichtkenntnis der mit einer Hochbegabung verbundenen Phänomene kann es erstens zu folgenreichen *Fehldiagnosen* kommen. Der Therapeut mag den Klienten als hochmütig, stark von sich eingenommen und unangepasst wahrnehmen und etwa die Diagnose einer ›narzisstischen Störung‹ stellen. Bei hoch intellektuellen, sehr introvertierten und äußerlich angespannten, hölzern wirkenden Klienten könnte eine ›schizoide Persönlichkeitsstörung‹ vermutet werden. Klienten, die hoch empfindlich sind und starken Stimmungsschwankungen unterliegen, erhalten möglicherweise die Diagnose einer ›manisch-depressiven Erkrankung‹ oder einer ›histrionischen Persönlichkeitsstörung‹ (früher als ›Hysterie‹ bekannt). Der ausgeprägte Perfektionismus vieler Hochbegabter mag fälschlicherweise als Zeichen einer ›Zwangsstörung‹ interpretiert werden.
Natürlich können solche Störungsbilder auch bei Hochbegabten vorkommen, aber wenn die Hochbegabung selbst dabei nicht erkannt wird, sind solche Diagnosen äußerst fragwürdig und stellen eine vorschnelle Stigmatisierung des Klienten dar. Auch wenn eine Diagnose nicht explizit geäußert wird (was viele Hochbegabte jedoch mit Recht verlangen), vermittelt sich dem Klienten doch auf indirekte Weise, dass er eine ›schwerwiegende Störung‹ hat; dies ist meines Erachtens einem erfolgreichen Heilungsprozess eher hinderlich als zuträglich.

Zweitens können die oben beschriebenen charakteristischen *Schwierigkeiten in der Interaktion* die Haltung des Therapeuten und damit den Behandlungsverlauf ungünstig beeinflussen. Hochbegabte stellen hohe fachliche und menschliche Erwartungen an den Therapeuten; sie äußern sich auf hohem intellektuellen Niveau, stellen kritische Fragen, decken Widersprüche auf, weisen den Therapeuten auf Unzulänglichkeiten hin. Sie bilden eigene Hypothesen über ihre Erkrankung, verwickeln den Therapeuten in Diskussionen, fordern authentische Stellungnahmen und reagieren hoch empfindlich auf unechtes Verhalten. Sie verlangen hohe Aufmerksamkeit vom Therapeuten, wollen nicht mit Standard-Methoden behandelt werden und besitzen oft ihrerseits psychologische Fähigkeiten. Welcher Therapeut käme hier nicht zuweilen an seine Grenzen?
Eine nicht geringe Anzahl Hochbegabter berichtete mir, dass Therapeuten, die sich zeitweilig offenbar unterlegen fühlten, mit abwehrendem, gereiztem Verhalten, Verweisen auf die eigene Reputation oder gar Herabsetzung und Stigmatisierung des Klienten reagierten. Andere Therapeuten hätten unsicher und angespannt gewirkt, seien Fragen ausgewichen und hätten wiederholt auf ihre fachlichen Kompetenzen hingewiesen. Wieder andere hätten jedwede kritische Äußerung des Klienten als Ausdruck seines ›pathologischen Beziehungsverhaltens‹ gedeutet.
Solche Reaktionen können nach meiner Auffassung dazu beitragen, den Leidensdruck eines Klienten zu verstärken und seine Störung bzw. sein ›Störungsgefühl‹ zu verfestigen. Wenn das Verhalten des Klienten zunehmend pathologisiert wird, entwickelt sich im ungünstigsten Fall eine ursprünglich leichte Erkrankung mit der Zeit zu einer schwer wiegenden Beeinträchtigung. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein Hochbegabter die Therapie abbricht, einen neuen Therapeuten aufsucht und dort ähnliche Erfahrungen macht. Der Klient wird sich schließlich in seiner Überzeugung bestätigt fühlen, von niemandem verstanden zu werden, mit niemandem auszukommen und schwer gestört zu sein.

Drittens kann es selbst bei gutem therapeutischen Kontakt möglich sein, dass *konventionelle therapeutische Methoden nicht greifen*, wenn die Hochbegabung des Klienten nicht erkannt und berücksichtigt wird. Nicht nur, weil Hochbegabte auf ein sehr didakti-

sches oder schematisches Vorgehen mit Skepsis oder Ablehnung reagieren, sondern weil Standard-Methoden ihren besonderen Eigenschaften und Bedürfnissen nicht ausreichend gerecht werden. Mit einem Hochbegabten, der Probleme in sozialen Kontakten hat oder sich isoliert und von seiner Umgebung unverstanden fühlt, kann man noch so viele Sozialkompetenz-Trainings durchführen – wenn er keine Kontakte zu Gleichgesinnten, das heißt Gleichbegabten, findet, werden zwischenmenschliche Beziehungen vielleicht immer unbefriedigend für ihn verlaufen. Für einen Hochbegabten, der mit seiner übermäßigen Empfindsamkeit hadert, reichen gewöhnliche Maßnahmen zur ›kognitiven Umstrukturierung‹ nicht aus.

Nicht zuletzt ist das Begabungspotenzial eines Klienten eine, wenn nicht *die* entscheidende Ressource, die man in keinem Fall ungenutzt lassen sollte. In fast allen Fällen ist das *Erkennen und Umsetzen der eigenen Begabung das wirksamste Therapeutikum* überhaupt.

Schwer wiegende seelische Erkrankungen bei Hochbegabten

Was aber geschieht nun mit Hochbegabten, die unter schwer wiegenden seelischen Problemen leiden und vielleicht überdies mehrere erfolglose Therapieversuche hinter sich gebracht haben? Wo findet man die beträchtliche Anzahl der von Scheidt (2004) genannten Underachiever, die »in höchstem Maße gefährdet sind durch Depressionen, Drogensucht und Suizid«? Wie genau äußern sich solche tief greifenden Störungen bei Hochbegabten? Reagieren sie auf Traumatisierungen und schwere Belastungen in derselben Weise wie alle anderen, oder gibt es Unterschiede? Welche Störungsbilder sind möglicherweise spezifisch für Hochbegabte?

Scheidt ist einer der wenigen Psychologen, der diese Frage überhaupt berührt, jedoch leider nur in einer sehr knappen Form:

»(…) Traumatisierungen können zu extremen Reaktionen und Entwicklungen führen. Solche belastenden Erfahrungen (zum Beispiel Vergewaltigung, Krieg, Unfall, Tod eines Elternteils) können auch bei Normalbegabten psychische und psychosomatische Störungen und Krankheiten auslösen. Aber kreative Hochbegabte haben – zu ihrem Glück oder Unglück – die Fähigkeit, solche Erlebnisse zu

einem sehr stabilen inneren Weltmodell auszugestalten. Bei Schriftstellern wirkt sich diese Fähigkeit meist positiv auf ihre Produktion aus – aber sie kann auch im Gegenteil zu Blockaden führen (…). (Scheidt, 2004, S. 197)

Es gibt zwei Störungsbilder, die der Psychologie bis heute viele Rätsel aufgeben. Eines davon habe ich bereits eingehend behandelt: die autistischen Störungen. Ein zweites Syndrom, das nach meiner Auffassung nur gänzlich verstanden und adäquat behandelt werden kann, wenn man die Phänomene der Hochbegabung mit in Betracht zieht, sind die so genannten Borderline-Störungen.

Bevor ich der Frage nachgehe, ob *Borderline-Störungen eine für Hochbegabte spezifische Form sind, auf starke seelische Belastungen und Traumatisierungen zu reagieren*, möchte ich das Borderline-Syndrom näher charakterisieren.

4. Borderline-Persönlichkeiten

Ich liebe die, welche nicht zu leben wissen.
F. Nietzsche

Definition

Die Definitionen und Theorien von so genannten Borderline-Störungen sind so zahlreich und vielfältig, dass ich hier nur insoweit darauf eingehen kann, als sie für meine Überlegungen zum Zusammenhang mit seelischen Störungen bei Hochbegabten relevant sind. Weiterführende Literatur zu diesem Störungsbild findet sich im Anhang (z. B. Kreisman & Strauß, 1992; Gneist, 1995; Rhode-Dachser, 2000).

Als wesentliche Symptome einer Borderline-Störung werden beschrieben:

1. Starke Stimmungsschwankungen, extrem intensiv erlebte Gefühle; geringe Frustrationstoleranz und häufige Zornausbrüche;

2. Impulsivität bei potenziell selbstschädigendem Verhalten, z. B. Drogen und Alkoholmissbrauch, sexuelle Exzesse; ›Kamikaze‹-Persönlichkeiten: lieber exzessiv als langweilig leben;
3. Chronische Gefühle von Einsamkeit, Isolation, Langeweile und innerer Leere; Gefühl der Heimat- und Haltlosigkeit;
4. Selbstverletzungen; Selbstmorddrohungen oder -versuche
5. Fehlen eines klaren Identitätsgefühls; Wechsel von Gefühlen der Grandiosität und Minderwertigkeit; sich »anders« als die anderen fühlen; das Gefühl, in einer »Festung« zu leben, nicht am Leben teilzuhaben;
6. Unbeständige und unangemessen intensive zwischenmenschliche Beziehungen; Angst vor Nähe in Beziehungen *und* Angst vor Einsamkeit; häufiger Wechsel von Idealisierung und Abwertung der Partner; andere werden oft angegriffen und kritisiert; alles wird ständig in Frage gestellt; Machtkämpfe mit anderen; großes Misstrauen, Angst vor Enttäuschung und Verlassenwerden;
7. Wechselndes Realitätsgefühl, Wahrnehmungsstörungen
8. Depressionen und Angstzustände; ggf. Essstörungen
9. Oft erfolgreich im Beruf; künstlerische und kreative Fähigkeiten

(Siehe auch: Beck & Freeman et al., 1995; Kernberg et al., 2000; Kreisman & Straus, 1992)

In einer Informationsbroschüre der *»Borderliners Anonymous«* findet man folgende Checkliste (Auszüge), die über die Zugehörigkeit zu dieser Personengruppe Aufschluss geben soll:

- Hast du das Gefühl »Ich bin anders, mit mir stimmt etwas nicht, ich gehöre nicht dazu«?
- Grübelst du wieder und wieder über dich nach, suchst Erklärungen für dein Verhalten, deine Gefühle, dein Denken und verstehst dich nicht?
- Erlebst du Schmerz oder Leid anderer Menschen, z. B. in Gesprächen, Filmen, Nachrichten, so, als wäre es dein eigenes?
- Fühlst du dich inmitten von Menschen unbehaglich oder gerätst in Panik?
- Erlebst du abrupt extreme Gefühlsänderungen ohne erkennbare Ursache?

- Lebst du oft im Gefühl großer Einsamkeit und Leere, auch wenn du unter Menschen bist und viel unternimmst?
- Verlaufen deine Partnerschaften/Beziehungen chaotisch und enden abrupt?
- Hast du eine große Sehnsucht nach Partnerschaft und Nähe, erlebst jedoch auch schnell Panik davor?
- Verletzt du dich selber durch Brennen, Schneiden, Zerkratzen der Haut, Kopf-gegen-die-Wand-Schlagen oder Ähnliches?
- Bist du von manchen Menschen anfangs ganz begeistert und ziehst dich dann von ihnen zurück, weil sie dich sehr enttäuscht haben?

Borderline-Persönlichkeiten (im Folgenden ›Borderliner‹) gehören in der klinischen Psychologie zu den schwierigsten Patienten, da sie als besonders anstrengend, unberechenbar und wechselhaft gelten. Typische Merkmale seien, dass der Therapeut eingehend ›getestet‹ werde, das heißt, es werden dessen Kompetenz und Einfühlungsvermögen in Frage gestellt, die Klienten reagieren unvermittelt feindselig und aggressiv oder sind besonders anhänglich und fordernd. Sie haben heftige Gefühlsausbrüche oder brechen die Therapie nach kurzer Zeit ab. Viele Borderliner betreiben ›Therapeuten-Hopping‹, was bedeutet, dass sie oft drei, vier oder mehrere Therapeuten verschleißen, weil sie sich nicht verstanden oder falsch behandelt fühlen. Oder weil die Stimmungen und der Lebenswandel der Betroffenen zu unbeständig sind, um Vereinbarungen zuverlässig einhalten zu können. Beck & Freeman et al. (1995) führen weitere Merkmale an, die im Therapiegeschehen auf eine Borderline-Störung hinweisen: eine verschiedenartige Mischung aus Problemen und Symptomen; ungewöhnliche Symptome; starke emotionale Reaktionen; häufige Krisen und das Ersuchen um spezielle Behandlung (z. B. zusätzliche Termine); häufige Fehlinterpretationen der Aussagen und Absichten des Therapeuten; ungewöhnlich heftige Reaktionen auf Veränderungen (z. B. bzgl. Zimmergestaltung, Terminänderungen); geringe Toleranz von direktem Blickkontakt, Körperkontakt oder Nähe; ungewöhnlich hohe Ambivalenz in Bezug auf zahlreiche Themen (S. 159).

Die meisten Forscher gehen davon aus, dass etwa 90 % aller Borderliner in ihrer Kindheit oder Jugend extreme seelische Belastun-

gen bzw. Traumata erfahren haben; dazu gehören sexueller Missbrauch und körperliche Gewalt, emotionale Grausamkeit und Vernachlässigung oder extrem instabile Familienverhältnisse (vgl. z. B. Herman, 1994; Kreisman & Straus, 1992; Rhode-Dachser, 2000).

Forschungsstand und eigene Beobachtungen

Warum bestimmte Menschen nach traumatischen Erfahrungen eine Borderline-Störung entwickeln, andere hingegen schwere Depressionen, aggressive und dissoziale Verhaltensstörungen oder multiple Persönlichkeitsstörungen, ist meines Wissens bislang nicht eindeutig geklärt.
Ich habe im Laufe meiner therapeutischen Tätigkeit rund dreißig Borderliner behandelt. Diese hatten in Kindheit und Jugend alle die beschriebenen Traumata erlebt. Aufmerken ließ mich die Tatsache, dass die Betroffenen *ohne Ausnahme zu den Hochbegabten* zählten, d. h., alle hatten, zumindest in mehreren Teilbereichen, einen IQ über 130.

Zu Beginn meiner therapeutischen Laufbahn bestand meine Klientel etwa zu drei Vierteln aus Patienten aller Begabungsgruppen und zu einem Viertel aus Hochbegabten. Dieses Verhältnis hat sich erst im Laufe der letzten Jahre zugunsten der Hochbegabten verschoben. Das heißt: Die von mir identifizierten Borderline-Persönlichkeiten kamen zufällig in meine Praxis, ohne über meine Arbeit mit Hochbegabten, geschweige denn über die eigene Zugehörigkeit zu dieser Gruppe, informiert zu sein. Die Annahme, dass nur die Hochbegabten unter den Borderline-Patienten zu mir kamen, kann also mit großer Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.
Umgekehrt wird dem geneigten Fachkollegen bei der bisherigen Lektüre nicht entgangen sein, dass viele hochbegabte Klienten Verhaltensweisen und Merkmale zeigen, die Borderline-Symptomen stark ähneln; hierauf werde ich im Anschluss explizit eingehen.
Diesbezügliche Hinweise finden sich auch bei anderen Autoren, so etwa in der Veröffentlichung von Hollenbach (1998): Er schildert die Geschichte eines 17-jährigen Mädchens, das nach langem Leidensweg in der Christopherus-Schule in Braunschweig im Zweig

für Hochbegabte aufgenommen wurde. Als es nach einiger Zeit einer Schulkameradin dort ihre Verletzungen am Arm zeigte, die sich das Mädchen selbst beigebracht hatte, krempelte die Freundin den Ärmel hoch und zeigte ihrerseits ihre Narben. In der Folgezeit kamen noch drei weitere hochbegabte Mädchen hinzu, die sich zu ihren Selbstverletzungen bekannten (selbstverständlich ist dies nur eines von vielen Symptomen des Borderline-Syndroms).

Kreisman & Straus (1992) erwähnen: »Borderline-Persönlichkeiten sind oft sehr intelligent und zeigen eindrucksvolle künstlerische Fähigkeiten. Weil sie leicht Zugang zu starken Emotionen haben, können sie kreativ und erfolgreich sein.« (S. 32) Die Angabe »oft« wird, ebenso wie die Höhe des Intelligenzniveaus, leider nicht näher spezifiziert. Der Kausalzusammenhang zwischen starken Emotionen und beruflichem Erfolg scheint mir überdies sehr fragwürdig oder doch zumindest sehr verkürzt dargestellt.
Reinert (2004) spricht von »beträchtlichen kreativen Potenzialen« bei Borderlinern, einer »in ungeheurem Maße geschulten Sensitivität« und »geradezu unglaublichen Fähigkeiten« in Bezug auf ihr Gedächtnis, ihre Wahrnehmung und ihre Auffassungsgabe (S. 143 ff.). Von der Schlussfolgerung des Autors, diese Fähigkeiten seien lediglich Mittel zur Manipulation anderer, wird später noch die Rede sein.
Gneist (1995) bescheinigt Borderlinern unter anderem »eine scharfe Beobachtungsgabe, Sprachgewandtheit, Witz und Kreativität« (S. 26 ff.).
Beck & Freeman et al. (1995) halten fest: »Empirische Studien stützen auch die Hypothese, dass Borderline-Klienten meist gut bei strukturierten Tests wie der Wechsler-Adult-Intelligence-Scale (WAIS) abschneiden (…)« (S. 158). Auch hier finden sich keinerlei Hinweise auf die Höhe der Intelligenztest-Ergebnisse.
Im »Handbuch der Borderlinestörungen« (Kernberg et al., 2000), das viele hundert Seiten umfasst und alle gegenwärtigen Forschungsergebnisse zu diesem Thema zusammenträgt, suchte ich ebenfalls nach Hinweisen auf besondere intellektuelle Begabungen bei Borderlinern. Tatsächlich fand sich ein sehr kurzer Abschnitt, in dem Folgendes steht (Auszug): *»Intelligenzmessungen sind bei Borderline-Patienten normalerweise nicht notwendig (…). Meist*

entsteht der Eindruck, dass die Patienten besonders intelligent sind. Dafür gibt es jedoch keinen empirischen Anhalt.«
Hiermit scheint der Sachverhalt in einem der aktuellsten und umfassendsten Grundlagenwerke zu Borderline-Störungen nach Auffassung der Autoren offenbar hinreichend geklärt.
Warum sind Intelligenzmessungen bei Borderlinern nicht notwendig? Bei vielen anderen Störungen gehört die Intelligenzdiagnostik zur Routine, um ein differenziertes Gesamtbild der Persönlichkeit (zu der die intellektuellen Fähigkeiten nun einmal dazugehören) zu erhalten und mögliche Stärken und Schwächen der Person zu identifizieren. Und wie soll man ausreichende »empirische Anhaltspunkte« für etwas erhalten, das man »normalerweise« gar nicht erst untersucht?
Im Falle der Borderline-Patienten scheint die Untersuchung der geistigen Leistungsfähigkeit geradezu ausgeklammert zu werden, *obwohl* der Eindruck vorherrscht, dass die Betroffenen »besonders intelligent« sind. Gerade von den empirischen Wissenschaften sollte man erwarten, dass sie sich nicht auf »Eindrücke« verlassen, und ein Begriff wie »*besonders* intelligent« spezifiziert, objektiviert und anhand von Messdaten konkretisiert wird.
Als ich in einer Fortbildung einen Professor und Klinikchef, Spezialist für Borderline-Störungen, vorsichtig darauf ansprach, ob seine Patienten auch Intelligenztests unterzogen würden, erklärte er mir knapp: »Das ist bei diesen Patienten vollkommen unnötig und nebensächlich. Die haben so viele schwere Störungen und Defizite, da spielt die Intelligenz kaum eine Rolle.«

Mir ist bekannt, dass es einzelne unveröffentlichte Studien psychiatrischer Abteilungen von Universitätskliniken zum Intelligenzniveau bei Borderlinern gibt, die keinen Zusammenhang zwischen Boderline-Störungen und hoher Intelligenz nahe legen. Es stellt sich jedoch die Frage nach dem genauen Vorgehen bei der Erhebung und Auswertung der Messdaten. Hier seien nur einige mögliche Einflussgrößen genannt, die bei der Intelligenzmessung im Allgemeinen und bei Borderlinern im Besonderen die Zuverlässigkeit und Messgenauigkeit von Daten verändern können: 1. In Intelligenztestverfahren ist es üblich, lediglich einen Gesamt-Intelligenzquotienten zu ermitteln. Eine Hochbegabung auf sprachli-

chem Gebiet bliebe zum Beispiel unerfasst, wenn die Ergebnisse auf mathematischem Gebiet ›nur‹ durchschnittlich ausfallen. 2. Die emotionale Verfassung von Borderlinern ist, insbesondere bei einer stationären Aufnahme, oft außerordentlich labil, was ihre Konzentrations- und geistige Leistungsfähigkeit stark beeinträchtigen kann. 3. Gerade bei Borderlinern ist eine vertrauensvolle Arbeitsbeziehung äußerst wichtig, um eine ausreichende Motivation bei Testungen zu gewährleisten. 4. Borderliner haben häufig sehr wenig Vertrauen in ihre eigene Leistungsfähigkeit. Angst, Selbstzweifel, Unsicherheit und Anspannung können Testergebnisse negativ beeinflussen, und es sind möglicherweise zunächst andere Erhebungen (z. B. gezielte anamnestische Daten im Hinblick auf ›Hochbegabungssymptome‹) sowie der Aufbau einer tragfähigen Therapiebeziehung erforderlich. 5. Die Borderline-Diagnose wird seit etwa einem Jahrzehnt geradezu inflationär gestellt, d. h., für viele Untersucher und Behandler reichen oft einige wenige Symptome aus, um eine Borderline-Störung zu diagnostizieren (Selbstverletzungen, Bulimie, Depressionen, Feindseligkeit, Aggressivität oder Drogenmissbrauch). Im Verlauf der schwierigen und wechselvollen Forschungsgeschichte des Borderline-Syndroms sprach man zeitweilig sogar von einer »Papierkorb-Diagnose« (Kreisman & Strauß, 1992, S. 245: »Dort konnte man jene Patienten ›abladen‹, die man nicht verstand, die sich der Therapie widersetzten oder deren Zustand sich einfach nicht besserte.«). Somit können auch ›unsaubere‹ Borderline-Diagnosen Ergebnisse von Korrelationsstudien verzerren.

Auch hier möchte ich meinen weiteren Ausführungen einige Fallbeispiele voranstellen.

Drei Fallbeispiele

Frau S. ist 31 und beruflich erfolgreiche Juristin. Sie hat bereits fünf Therapieversuche und einen Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik hinter sich. Ihre Diagnose lautete: »Rezidivierende depressive Störung vor dem Hintergrund einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung, Borderline-Typus.« Frau S. litt unter Einsamkeit, starken Stimmungsschwankungen, Selbstzweifeln, anhaltender Traurigkeit, Angstzuständen, Kontakt- und Beziehungs-

schwierigkeiten, Bulimie, heftigen Spannungsgefühlen, bei denen sich sich selbst verletzte (Schnitte in den Unterarm), und Gefühlen der Derealisation (d. h. der Unwirklichkeit) und Depersonalisation (»Ich bin nicht mehr ich; meine Hände gehören nicht zu mir.«). Mit ihrem Partner hatte sie heftige, zum Teil gewalttätige Auseinandersetzungen. Sie fühlte sich ihm in jeder Hinsicht überlegen, wollte ihn verlassen und hatte gleichzeitig panische Angst davor, dass *er* sie verlassen würde.

Über ihre Therapien berichtet Frau S.: »Ich merkte gleich, wenn ein Therapeut unsicher war. Bei den meisten Fragen wusste ich schnell, worauf sie hinausliefen. Ich spielte Spielchen mit ihnen, und sie ließen sich täuschen. Das war einerseits schlimm für mich, andererseits musste ich einfach sicher sein, dass ich ihnen vertrauen konnte. Einer der Therapeuten wurde wütend und betonte ausdrücklich seine fachliche Autorität. Ich sagte ihm, dass das ein Zeichen von Schwäche sei, und er wurde noch wütender. Der zweite Therapeut verliebte sich in mich, und wir mussten die Therapie abbrechen. Die anderen stellten, wie ich fand, die falschen Fragen, verstanden mich nicht oder speisten mich mit billigen ›Psycho-Sprüchen‹ ab. Oft hatte ich den Eindruck, dass sie mir nicht folgen konnten. Ich hatte mir selbst schon so viele Gedanken über meine Krankheit gemacht und so viel darüber gelesen – ich wollte nicht bei Null anfangen, ich wollte endlich zum Wesentlichen, zum Kern meines Problems kommen.«

Natürlich war Frau S. ausgesprochen misstrauisch, ob ich ihr helfen könnte. Sie war sehr belesen, gebildet und intelligent. Sie sprach schnell, und ihre Schilderungen waren sehr kompakt; die Beschreibung ihrer Gefühle war ausdrucksstark und ungewöhnlich eloquent. Frau S. konnte sich sehr differenziert selbst analysieren. In den ersten Stunden berichtete sie Folgendes: »Ich fühle mich oft, als sei ich von einem anderen Stern. Ich bin zum Beispiel unfähig, normale Konversation zu machen und Smalltalk zu halten. Ich verstehe einfach nicht, warum ich das nicht kann. Andere werfen mir immer vor, dass ich zu anstrengend, zu ernsthaft, zu schwierig, zu anspruchsvoll bin. In Diskussionen reizt es mich immer, in Opposition zu gehen. Es macht mich ganz krank, wenn alle immer so konsensgeil sind und sich jeder interessante Disput gleich in allseitiger Übereinstimmung und Harmonie auflöst. Meistens habe ich

die besseren Argumente, aber für mich ist es wie ein anregendes Spiel, ich will nicht, dass man mir Recht gibt, sondern dass man sich mit mir auseinander setzt. Ich weiß, es klingt furchtbar arrogant, aber ich langweile mich so schnell in Gesprächen und schaffe es dann kaum, den anderen noch zuzuhören. Und wissen Sie, was ich dann mache? Ich nehme das Gespräch sozusagen allein in die Hand, weil ich es immer noch spannender finde, mir selber zuzuhören. Was müssen Sie jetzt von mir denken …! Ich wünsche mir jemanden, der gleich stark ist wie ich, mit dem ich mich messen kann, der mir gewachsen ist. Ich lebe wie in einem Kokon, abgeschnitten von der Außenwelt, ich komme mir immer fremd vor. Das Zusammensein mit anderen ist für mich meistens unbefriedigend, gleichzeitig kann ich es kaum aushalten, allein zu sein. Ich klammere mich an andere, kriege aber nie das, was ich mir wünsche. Diese Ambivalenz zerreißt mich manchmal fast. Ich bin eine echte Zumutung für andere, das weiß ich. Ich will mich am liebsten dauernd intensiv austauschen, ich habe ständig so intensive Gefühle und Gedanken, die mich beschäftigen. Aber die meisten kommen da gar nicht mit, sie scheinen alle so friedlich vor sich hin zu leben, nur ich schaffe das einfach nicht. Und dann, es hört sich pathetisch an, aber ich habe so ein starkes Bedürfnis nach Wahrhaftigkeit. Nach echten, ehrlichen Gesprächen; nach Leuten, die ihre Gefühle direkt ausdrücken.«

Ich fragte Frau S., ob es Ausnahmen in ihrem Leben gegeben habe; Menschen, die ihr ebenbürtig erschienen und mit denen diese Art des Austauschs möglich war.
»Ja«, sagte sie sofort, »mein Lateinlehrer im Gymnasium. Er war absolut unbeliebt an der Schule – genau wie ich übrigens. Er war ein richtiges Fossil, vom alten Schlag, aber er mochte mich, und wir haben im Unterricht immer unsere kleinen Philosophie-Diskurse gehabt. Und es gibt einen Onkel, der im Ausland lebt. Der ist genau wie ich. Wir haben wenig Kontakt, aber wenn wir uns sehen, alle paar Jahre, fühle ich mich absolut wohl.«

Frau S. war sichtlich irritiert, dass ich sie nicht wegen ihrer »Arroganz« verurteilte. Stattdessen fragte ich sie, ob je ihr Intelligenzquotient gemessen worden sei. »Natürlich«, antwortete sie, »bei

einer der Therapien und in der Klinik. So was um die 140 Punkte, glaube ich.«
Frau S. selbst schien mit diesem Ergebnis nicht viel anfangen zu können. Ich ließ mir die entsprechenden Unterlagen schicken, und die Ergebnisse erwiesen sich als zuverlässig. Anschließend zeigte ich Frau S. anhand der Gauss'schen Normalverteilung, in welchem (Extrem-)Bereich der Intelligenz sie sich mit ihren geistigen Fähigkeiten befindet, und erklärte ihr alles, was sie über Hochbegabung wissen musste.
Allein diese Informationen führten dazu, dass Frau S. mich nicht ausgiebig »testete« (wie das bei vielen Borderlinern üblicherweise der Fall ist), ihr seelisches Befinden sich innerhalb der ersten zehn Sitzungen bereits deutlich stabilisierte, sie sich im Kontakt mit anderen sicherer fühlte und deutlich an Selbstvertrauen gewann. Natürlich war die Klientin damit nicht geheilt, aber sie selbst äußerte: »Ich kann viele meiner Reaktionen jetzt besser einordnen und verstehen. Meine Gefühlsschwankungen fallen dadurch weniger heftig aus. Es beruhigt mich zu wissen, dass ich nicht völlig unnormal bin.«

Frau T. ist 27, studiert Medizin und verdient sich ihren Lebensunterhalt mit verschiedenen Jobs. Sie kommt wegen Lernstörungen, Prüfungsängsten, Depressionen, Beziehungsproblemen, massiven Spannungszuständen, verschiedenen Formen von Selbstverletzung (Kopf-gegen-die-Wand-Schlagen, Akne-Pickel herausschneiden) und hat bereits zwei erfolglose Therapien hinter sich. In den ersten Gesprächen fällt mir zum einen das ungeheure Rede- und Denktempo von Frau T. auf. Ihre Schilderungen sind intensiv, hoch komplex, lebhaft und sehr differenziert. Sie verfügt über Humor und ein hohes Maß an Selbstironie. Zum anderen wirkt Frau T. schnell gereizt, feindselig und offen aggressiv. Wenn man ihr nicht immer folgen kann oder einen Zusammenhang nicht gleich versteht, reagiert sie zornig und ungehalten. Darauf angesprochen, berichtet sie, dass ihr dies in vielen Kontakten mit anderen Schwierigkeiten bereite; die meisten ihrer Freundschaften würden über kurz oder lang deshalb zerbrechen. Beziehungen zu Männern verliefen immer katastrophal. In ihrer Jugend kam Frau T. mehrmals wegen Drogen und Diebstahl mit dem Gesetz in Konflikt. Auch

neigte sie damals zu Alkoholexzessen. Heute komme dies seltener vor. »Alles, was ich mache, mache ich extrem: Manchmal trinke ich monatelang keinen Tropfen, dann besaufe ich mich drei Abende hintereinander; ich rauche lange gar nicht oder bis zu sechzig Zigaretten am Tag. Entweder ich lerne wie eine Besessene, oder ich liege tagelang zu Hause herum und kann mich zu gar nichts aufraffen.«

Frau T. war seit ihrem vierzehnten Lebensjahr im Heim aufgewachsen, nachdem sie von ihrer offenbar psychisch kranken Mutter über Jahre schwer misshandelt wurde. Im Heim galt Frau T. als gerechtigkeitsfanatisch, aufrührerisch und provozierend. Beiläufig erwähnt sie, dass dort mit ihr psychologische Tests durchgeführt wurden, unter anderem auch ein Intelligenztest mit einem Ergebnis von IQ 139. Frau T. habe damals nachgefragt, was dies genau bedeute, aber die Erzieher hätten ihre Frage brüsk abgewiesen: sie solle sich auf ihren IQ »nichts einbilden«, Intelligenz sei schließlich nicht alles, Frau T. solle sich vielmehr auf ihre sozialen Fähigkeiten konzentrieren. Seither habe sie sich über das Thema Intelligenz keinerlei Gedanken mehr gemacht. Als ich ihr eine erneute Testung vorschlug, lehnte Frau T. zunächst vehement ab. Nach einiger Zeit kam sie jedoch von selbst mit dem Wunsch auf mich zu, einen Intelligenztest zu machen. Das Ergebnis bestätigte ihre Hochbegabung.

Frau T.'s Reaktion auf meine Erläuterungen über Hochbegabung schwankte über mehrere Wochen zwischen zornigem Misstrauen und großer Erleichterung. Ihre Leistungsprobleme rückten mehr in den Hintergrund, und Frau T. gestand ein, dass sie bei fast allen Leuten unbeliebt sei und sich in Kontakten meist unverstanden fühle. »Ich kenne fast niemanden, der so denkt wie ich. Für mich war es immer selbstverständlich, dass man mich bestenfalls als Exotin betrachtet. Mit meinen Auffassungen ecke ich überall an. Viele halten mich für eine Nervensäge, weil ich gern leidenschaftlich und scharf diskutiere, weil ich alles Mögliche in Frage stelle, weil ich immer versuche, an den Kern der anderen heranzukommen und unbedingt Aufrichtigkeit will – von anderen, aber auch von mir selbst. Ich dachte immer, meine Sonderrolle hänge nur mit meiner schwierigen Lebensgeschichte zusammen.« Dies war sicher auch richtig, aber als Frau T. Kontakt zu einer Hochbegabtenvereini-

gung aufnahm, stellte sie fest, dass es doch Personen gab, mit denen sie sich verständigen konnte und die sie nicht als Außenseiter wahrnahmen. Frau T. erlebte hier erstmals, dass ihr scharfer Verstand, ihre Freude am Disputieren und ihr skurriler Humor geschätzt wurden. Damit waren nicht alle Probleme von Frau T. gelöst, aber es hatte einen außerordentlich stabilisierenden Effekt.

Die Therapie von Frau T. verlief insgesamt, ebenso wie die von Frau S., langwierig, aber erfolgreich.

Der Film *»Godwill Hunting«* beschreibt in besonders anschaulicher und umfassender Weise eine hochbegabte Borderline-Persönlichkeit und stellt geradezu ein Lehrstück für Therapeuten, die mit dieser Personengruppe arbeiten, dar. Daher erlaube ich mir, die Handlung des Films als drittes ›Fallbeispiel‹ vorzustellen: Der Protagonist Will ist zwanzig Jahre alt und im Arbeitermilieu aufgewachsen. Durch Zufall erkennt ein Mathematik-Professor die Hochbegabung des jungen Mannes. Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit einer Gruppe Jugendlicher wird Will in einer Gerichtsverhandlung (in der er zu seiner Verteidigung sämtliche historischen Gerichtsurteile zu seinen Gunsten zitiert) zu einer Haftstrafe verurteilt. Der Professor erwirkt seine Freilassung, jedoch unter der Auflage, dass er sich einer Therapie unterziehe.
Es folgt die für Borderliner typische Odyssee zu mehreren Therapeuten. Will ist verschlossen, misstrauisch und provozierend. Den ersten Therapeuten ›erledigt‹ er mit ironischen Täuschungsmanövern. Der zweite wirft ihn hinaus, nachdem Will ihn unvermittelt auf seine verdrängte Homosexualität anspricht. Erst dem dritten Behandler gelingt es, Wills Vertrauen zu gewinnen: Der Therapeut zeigt sich menschlich und aufrichtig, respektiert Wills Stärken, weist ihn aber auch auf seine Schwächen hin. Auf Wills Angriffe reagiert der Therapeut zunächst nicht mit psychologischen Deutungen oder Diagnosen, sondern er nimmt Will als gleichberechtigtes Gegenüber ernst und setzt sich offen mit ihm auseinander. Die Authentizität des Therapeuten ermöglicht es Will, sich allmählich zu öffnen. Schließlich stellt sich heraus, dass Will als Kind schwer misshandelt wurde.
Auch die Liebesgeschichte im Film gestaltet sich typisch für einen

Borderliner: Als seine intelligente, warmherzige Freundin sich fester an ihn binden will, weist er sie zurück, beschimpft sie und nimmt wütend Reißaus.
Will erfüllt also alle Kriterien der Borderline-Persönlichkeit: Er neigt zu impulsivem, selbstschädigendem und feindseligem Verhalten, verschleißt mehrere Therapeuten, machte in seiner Kindheit traumatische Erfahrungen und scheitert in Liebesbeziehungen. Und er ist hochbegabt.

Bevor ich im Einzelnen auf Gemeinsamkeiten bei Hochbegabten und Borderlinern eingehe, möchte ich zunächst einige grundlegende Mechanismen zur Verarbeitung traumatischer Erfahrungen beschreiben.

Die Verarbeitung traumatischer Erfahrungen

Die Seele hat verschiedene Strategien zur Verfügung, wie sie traumatische Erfahrungen zu ertragen und zu bewältigen versucht: Sie kann die Wahrnehmung, zum Beispiel während körperlicher Misshandlung, gleichsam *ausschalten* oder *›taub machen‹*: Die Geschehnisse erreichen das Bewusstsein nicht mehr vollständig, man erlebt sie wie in Trance. Dies ist vergleichbar mit dem Schockzustand bei Unfallopfern. Dieser Schutzmechanismus kann über Stunden oder Tage anhalten. Opfer von sexuellem Missbrauch berichten häufig, sie hätten sich während der Gewalttat von ihrem Körper »gelöst« und den Übergriff unwirklich, wie durch einen dichten Schleier erlebt. Der Organismus sorgt also dafür, dass die Verletzungen nicht in ihrem vollen Ausmaß ins Bewusstsein gelangen. Manchmal resultiert hieraus eine Form von Verdrängung, die ein Leben lang halten kann.
Ein weiterer Mechanismus ist die *Spaltung (Dissoziation)*: Bei lang anhaltenden und wiederkehrenden Misshandlungen versucht die Seele, das Erlebte abzuspalten; dies kann zur Folge haben, dass das »Ich« zerbricht und die Persönlichkeit in zwei odere mehrere Teile zerfällt. Man spricht dann von Persönlichkeitsspaltung oder multipler Persönlichkeit.
Borderline-Persönlichkeiten scheint es jedoch zu gelingen, die *Spaltung* in ihre Persönlichkeit zu *integrieren*. Sie pendeln gleich-

sam immer zwischen normaler und verzerrter Wahrnehmung; sie befinden sich auf einer anstrengenden Gratwanderung und balancieren immer auf der Grenze (daher auch die Bezeichnung ›Borderliner‹, die man mit ›Grenzgänger‹ übersetzen könnte).

Für ein Kind, das von einem Elternteil misshandelt oder sexuell missbraucht wird, ist die Fähigkeit zur Spaltung meist überlebensnotwendig. Die Eltern (in vielen Fällen der Vater) müssen einerseits als Beschützer und Vorbilder wahrgenommen werden können – andererseits erleben die Kinder sie als aggressive Angreifer. Einen Feind, der von außerhalb der Familie angreift, kann man hassen und sich auf diese Weise zumindest innerlich von ihm abgrenzen. Bei einem »Feind« innerhalb der Familie, auf dessen Liebe und Zuneigung man angewiesen ist und den man als Beschützer braucht, ist die kindliche Seele gezwungen, das *positive* Bild der gewalttätigen Eltern aufrechtzuerhalten (vgl. z. B. Miller, 1988; Rijnaarts, 1988; Reinert, 2003; Shengold, 1995).

Borderline-Persönlichkeiten scheinen die Strategie der Spaltung nahezu perfekt zu beherrschen. Welche Grundvoraussetzungen sind aber hierzu erforderlich?
Vor allem braucht es, neutral betrachtet, eine hohe geistige und emotionale Flexibilität: Um die Angriffe des aggressiven Elternteils ertragen zu können, muss das Kind seine Wahrnehmung ausschalten; um sich an das Elternteil anlehnen zu können, muss es sie wieder ›einschalten‹. Manchmal legen Borderliner unbewusst verschiedene, strikt voneinander getrennte Gedächtnisspeicher für ›gute‹ und ›schlechte‹ Erlebnisse an. Um die aggressiven Eltern gleichzeitig als liebende Menschen mit guten Absichten wahrnehmen zu können, benötigt das Kind zudem ein außergewöhnlich hohes Maß an Einfühlungsvermögen; d. h., es wird versuchen, die Motive und Beweggründe des Vaters oder der Mutter aufzuspüren und sie nachzuvollziehen; es muss oft besonders früh die Fähigkeit zum Perspektivwechsel ausbauen, um die positiven Anteile der Eltern erkennen und aufrechterhalten zu können.

Trauma, Begabung und Kreativität

Anhaltende oder vorübergehende traumatische Belastungen scheinen bei bestimmten Persönlichkeiten in mehrfacher Hinsicht zu einer Art beschleunigtem Reifungsprozess zu führen, während andere Betroffene darauf mit Stagnation, Resignation, Regression (Rückentwicklung) oder dem bereits erwähnten ›Auseinanderfallen‹ der Persönlichkeit reagieren. Es scheint, als reagierten Persönlichkeiten mit einer hohen Ausstattung an Sensibilität und Intelligenz auf massive seelische Belastungen mit einer *Reifung aus Not*, einer Reifung unter Hochdruck. Dies kann sowohl die seelische und soziale als auch die geistige Reifung betreffen.

Versteht man das traumatische Geschehen gleichsam als gewaltsame Aufforderung an den Organismus, Höchstleistungen zu vollbringen, um die jeweilige ›Invasion‹ überleben und verarbeiten zu können, muss ein Kind folgende Fähigkeiten entwickeln:

1. Sich in den jeweiligen ›Angreifer‹ einzufühlen und seine Beweggründe zu verstehen. Diese Fähigkeit gilt gewöhnlich als Zeichen hoher sozialer Intelligenz.
2. Das Erlebte aus dem Bewusstsein auszuschließen und einen gesonderten Gedächtnisspeicher anzulegen. Die Einrichtung eines speziellen Gedächtnisspeichers, der nur unter bestimmten Bedingungen zugänglich ist, ist eine außergewöhnliche Leistung des Gehirns.
3. Verhaltensweisen zu entwickeln, wie man künftige Belastungen oder Übergriffe verhindern kann, indem man zum Beispiel die Launen eines gewalttätigen Vaters oder einer psychisch kranken Mutter im Voraus erspürt. Subtile Signale (Tonfall, Mimik, Gestik) von Interaktionspartnern zu decodieren und deren Handlungen vorhersagen zu können, gilt ebenfalls als Voraussetzung für hohe soziale Kompetenz.
4. Bestimmte seelische und körperliche Empfindungen abzuschalten, um den Schmerz nicht fühlen zu müssen. Das Abschalten körperlicher und seelischer Empfindungen zur Abwehr von Schmerzen oder Angst kann eine überlebenswichtige Fähigkeit in Extremsituationen sein und gilt zum Beispiel in asiatischen Kulturen als Zeichen höchster geistiger Reife.

Den Grundgedanken dieser Überlegungen fasst am besten eine 26-jährige hochbegabte Klientin zusammen, die in ihrer Kindheit und Jugend eine Reihe schwerer Traumatisierungen erlebte: »Meine Kindheit war die Hölle, und ich würde etwas darum geben, wenn sie anders verlaufen wäre. Aber ich komme nicht umhin, auch sagen zu müssen, dass mich diese Erfahrungen zu dem gemacht haben, was ich heute bin: Ich habe gelernt, unter extremsten Bedingungen zu überleben; ich habe mich, auch wenn das komisch klingt, im Nahkampf bewährt. Ich sehe natürlich die Verletzungen, die ich davongetragen habe, aber ich erkenne allmählich auch die Fähigkeiten, die mir daraus zwangsläufig erwachsen sind.«

Der Gedanke, dass traumatische Erfahrungen nicht nur bisweilen unheilbare seelische Verletzungen verursachen, sondern zu ihrer Bewältigung bestimmte geistige und soziale Fähigkeiten erforderlich sind oder gar beschleunigte Reifungsprozesse auslösen, mag für viele befremdlich sein. Zumindest aber bieten diese Überlegungen eine wirkungsvolle therapeutische Ergänzung für Borderline-Klienten, bei deren Behandlung das Augenmerk meist ausschließlich auf Defizite und weniger auf vorhandene Ressourcen, Fähigkeiten und Stärken gerichtet ist.
Goertzel & Goertzel (1965) griffen schon vor vielen Jahren einen ähnlichen Gedanken auf: Sie konstatieren, dass hochbegabte Kinder unter familiären Schwierigkeiten und einem problematischen Elternhaus ebenso leiden wie andere Kinder. Manchmal scheine jedoch das Unglück ihr Leistungspotenzial und ihre kreativen Fähigkeiten nicht zu zerstören; in einigen Fällen müsse man sogar annehmen, dass das Leid die Kinder zu kreativen Aktivitäten motiviere. (S. 151) Es wäre naiv zu glauben, dass kreative hochbegabte Menschen immer aus einer harmonischen, geduldigen und fördernden Familie kämen. Das andere Extrem anzunehmen, nämlich dass Kinder Belastungen brauchen, um ihre Talente zu entfalten, halten die Autoren nicht nur für naiv, sondern für gefährlich. Man könne jedoch die Tatsache nicht ignorieren, dass auch aus höchst problematischen Familien kreative hochbegabte Menschen hervorgehen (S. 152).

Winner (1998) geht noch einen Schritt weiter. Zunächst unterscheidet sie zwischen hochbegabten Kindern, die zu Experten aufsteigen, und solchen, die ihre Domäne kreativ gestalten. »Expertentum ist keine Kreativität. Experten arbeiten auf hohem Niveau innerhalb einer anerkannten Domäne, aber sie verändern die Domäne nicht. Um vom Experten zum kreativen Neuerer zu werden, also die ›Grundlagen seiner Domäne zu erschüttern und neu zu gestalten‹, braucht es nicht nur eine extrem frühe Befähigung, sondern auch eine ›rebellische Persönlichkeit‹.« (S. 256)
Die Autorin führt an, dass die Probanden der Terman-Studie (s. Kap. VI; S. 103) zwar überwiegend beruflich erfolgreich gewesen seien, sich jedoch keiner von ihnen als kreatives Genie entpuppt habe. Zwei künftige Nobelpreisträger seien als Kinder sogar von der Studie ausgeschlossen worden, weil ihre Ergebnisse beim Intelligenztest zu schlecht ausgefallen waren. Kreativität, so folgert die Autorin, sei noch von anderen Faktoren als einem hohen IQ abhängig. (S. 259)
Goertzel (1978) fand heraus, dass von über dreihundert schöpferisch herausragenden Persönlichkeiten des zwanzigsten Jahrhunderts nur knapp ein Drittel als frühbegabt identifiziert wurde. *Rund 85 % der hoch kreativen Persönlichkeiten kamen jedoch aus stark stressbelasteten Familien*; diese Belastungen weisen erstaunlich große Ähnlichkeiten mit jenen auf, wie sie in Familienverhältnissen von späteren Borderlinern beschrieben werden: Feindseligkeit, Gewalttätigkeit, Vernachlässigung, Alkoholismus der Eltern, Tod eines Elternteils, Depressionen und ausgeprägte emotionale Instabilität der Eltern.
Neben hoher Begabung, Konzentrationsfähigkeit, Risikobereitschaft, Unabhängigkeit und der Fähigkeit, sich durchzusetzen und Fehlschläge zu verarbeiten, scheint also ein weiteres kennzeichnendes Merkmal herausragend kreativer Menschen eine stressbelastete Kindheit zu sein.
Winner (1998) vermutet daher: »Vielleicht trägt die Stresserfahrung in der Kindheit tatsächlich in gewisser Weise dazu bei, die Kreativität zu fördern, auch wenn die Belastung vermutlich häufiger zerstörerisch als fördernd wirkt.« (S. 272) »Das vielleicht Allerwichtigste ist das Bedürfnis, irgendetwas in Ordnung zu bringen.« (S. 269)

Ergänzend möchte ich hinzufügen: Kreativität ist das Gegenteil von Destruktivität. Manche hochbegabten Menschen scheinen ihr Leben lang zu versuchen, die zerstörerischen Verhältnisse, in denen sie aufgewachsen sind, durch kreative Leistungen ›in Ordnung‹ zu bringen. Hierzu gehören meines Erachtens auch die Borderline-Persönlichkeiten. Natürlich werden nicht alle von ihnen berühmte kreative Erwachsene. Aber ihre beträchtlichen kreativen Potenziale werden von nahezu allen Autoren übereinstimmend konzediert. Reinert (2004) schreibt über Borderliner: »Eigentlich ist, wenn man es einmal fertig bringt, die Umgangsweisen des Patienten neutral und mit Empathie zu betrachten, die Leistungsfähigkeit dieser Menschen hinsichtlich des Überlebens in einer für sie gefährlichen und sie mit Vernichtung ihrer psychischen, evtl. auch physischen Existenz bedrohenden Welt nur zu bewundern. (…) Auf grundsätzlich vorhandene kreative Potenziale auch von ›labilen Borderline-Persönlichkeiten mit ihren überraschend unkonventionellen, zuweilen schöpferisch fruchtbaren Ideenverbindungen‹ weist auch Luc Ciompi (1982, S. 108) hin.« (S. 144) Statt diesen interessanten Gedanken jedoch weiter zu verfolgen, beendet der Autor seine Ausführungen mit dem Fazit: »Aber Kreativität hin oder her: Bei den Kontrollmechanismen des Borderliners handelt es sich um Not-Maßnahmen!« (S. 145) Ohne Frage bewirken extreme Belastungen in der Kindheit in allererster Linie extreme seelische Not. Dennoch verdienen nach meiner Auffassung die kreativen und geistigen Fähigkeiten von Borderlinern besondere Beachtung.

Die sehr differenzierten Überlegungen von Autoren wie Goertzel (1978) oder Winner (1998) zum Zusammenhang zwischen Trauma, Begabung und Kreativität könnten die psychologische Forschung bei der Frage nach Auswirkungen traumatischer Erfahrungen auf Hochbegabte ein gehöriges Stück weiter bringen. Dies gilt auch für die Entwicklung geeigneter Therapiemethoden für Borderline-Klienten: Weist man sie auf ihre Fähigkeiten und Stärken hin, bestätigt man ihnen ihre kreativen Potenziale und ermutigt sie zur Umsetzung ihrer Begabungen, hat dies eine weitaus heilsamere Wirkung, als ausschließlich auf ihre Defizite und ›schweren Störungen‹ zu fokussieren.

Verarbeitung belastender Erfahrungen bei Hochbegabten

In Kap. III. hatte ich beschrieben, dass hochbegabte Kinder und Jugendliche oft automatisch versuchen, sich in ihr Gegenüber einzufühlen und selbst für dessen aggressiven Übergriffe Erklärungen zu finden, die den Angreifer entlasten oder entschuldigen. Ihre hohe soziale Sensibilität und frühe soziale Reife scheinen dies zu begünstigen.
Auch in anderen schweren Belastungskrisen, wie zum Beispiel bei heftigen Auseinandersetzungen oder einer Trennung der Eltern, reagieren hochbegabte Kinder oft in einer Weise, die Erwachsene erstaunt und irritiert.

»Sie ist so ›verkopft‹«, berichtet die Mutter eines neunjährigen Mädchens, »sie geht es so besonnen und rational an. Das macht mir Sorgen, weil ich denke, dass sie an ihre Gefühle gar nicht herankommt.« Das Mädchen erzählte mir, dass sie die Trennung der Eltern zwar als sehr belastend erlebt, aber: »Ich kann beide verstehen, meinen Vater und meine Mutter. Sie kommen einfach nicht mehr miteinander aus, sie haben ganz verschiedene Ansichten. Ich begreife, warum meine Mutter so oft ausrastet. Sie hat ja auch viel Stress und viele Sorgen wegen meinem Vater. Ich verstehe aber auch, dass mein Vater von meiner Mutter oft genervt ist. Er ist eben nicht so zuverlässig, pünktlich und ordentlich wie sie, und sie kritisiert ihn dauernd.«

Auch ich selbst staune immer wieder darüber, wie es hochbegabten Kindern gelingt, ihr Leid in solchen Situationen zu bewältigen. Sie reflektieren und differenzieren sorgfältig, versuchen fair, einfühlsam und verständnisvoll zu sein und bemühen sich um eine objektive Sichtweise. Oft gelingt ihnen dies sogar besser als ihren Eltern. Ein Vater berichtet über seinen hochbegabten Sohn: »Er ist sozial ungeheuer sensibel und geschickt. Er verschafft sich in sozialen Situationen oft blitzschnell einen Überblick und weiß, was die Beteiligten denken und fühlen. Er kann sehr gut vermitteln, Streit schlichten und hat großes Mitgefühl mit anderen. Die Kehrseite ist aber, dass er schon erschrickt oder verunsichert ist, wenn ich mal schweigsam bin oder mürrisch gucke.«

Hochbegabte Kinder haben nach meinen Beobachtungen alle Voraussetzungen dafür, einen so komplexen Mechanismus wie den der Spaltung zu perfektionieren. Zudem sind sie, etwa als Opfer von Misshandlungen in der Familie, darauf angewiesen, permanent überwach zu sein, jede kleinste Stimmungsänderung oder Bedrohung in ihrer Umgebung wahrzunehmen und Strategien auszudenken, wie sie (konkret oder mental) entkommen können. Es wird ihnen damit, pragmatisch gesprochen, ein ungeheures Maß an Flexibilität, Wachsamkeit, Aufmerksamkeit und Erfindungsreichtum abverlangt. Dass hochbegabte Kinder konstitutionell in der Lage sind, dies zu beherrschen, könnte also ein Grund sein, warum sie an der Traumatisierung nicht ›zerbrechen‹, sondern immer an der Grenze hin- und herpendeln.

Dies brachte mich zu der Überlegung, *dass die hohe Intelligenz und ausgeprägte soziale Sensibilität hochbegabter Kinder Bedingungen dafür sein können, unter extremen seelischen und körperlichen Belastungen die typischen Merkmale des Borderline-Syndroms und kein anderes Störungsbild zu entwickeln.*

Weitere Borderline-Strategien

Die seelischen Verletzungen, die Kinder durch Gewalterfahrungen jeder Art davontragen, beeinflussen in der Regel ihr ganzes späteres Leben. Während viele misshandelte Kinder als Jugendliche abstumpfen und ihr Erwachsenenleben in einem Milieu von Gewalt oder Kriminalität verbringen, versuchen Borderliner in der Regel unablässig, einen *»Platz in der Welt«* zu finden. Sie suchen stets nach einem Partner, nach sozialen Kontakten, nach Therapeuten und nach Gründen für ihre Probleme. Viele von ihnen studieren und üben anspruchsvolle Berufe aus.
Häufig erleben sie jedoch, dass sie bei dem Versuch, sich anderen anzuschließen, scheitern. Sie suchen den intensiven Kontakt zu anderen mit einer Hartnäckigkeit, die für sie selbst quälend und für andere befremdlich ist. Die Sehnsucht, beschützt, verstanden und geliebt zu werden, ist oft übermächtig. Ebenso wie der Wunsch, sich zugehörig zu fühlen und eine *stabile Identität* zu finden, indem sie *Resonanz* erfahren, die ihnen Sicherheit und Halt bietet. In

ihrer Kindheit haben Borderliner gelernt, dass die Welt ein gefährlicher, bedrohlicher Ort ist, an dem man nur überleben kann, wenn man stets auf der Hut und ›bis an die Zähne bewaffnet‹ ist.

Während schizophrene, psychopathische oder gewalttätige Menschen möglicherweise resigniert und die Welt als chaotischen, grausamen Ort akzeptiert haben, halten Borderliner typischerweise das Bild von einer ›heilen Welt‹, einer ›Heimat‹ aufrecht. Fast alle Borderliner berichten von dem Gefühl der Heimatlosigkeit und dem starken Wunsch, sich ›zu Hause‹ fühlen zu können.
Die Tragik der Borderliner besteht jedoch darin, dass sie, wenn sie auch nur in die Nähe eines möglichen ›Zuhauses‹ kommen (sei es ein verständnisvoller Therapeut, eine einfühlsame Freundin oder ein liebender Partner), in Panik geraten und den Impuls verspüren, davonzulaufen oder die gerade beginnende Beziehung in einem Wutausbruch zu zerstören. Die Erfahrung von Liebe und Zuneigung kann als außerordentlich schmerzlich erlebt werden; die Angst, die Liebe könnte nicht echt sein oder man könnte sie wieder verlieren, ist zu groß. Dieser Angst und ihrem großen Misstrauen versuchen Borderliner häufig dadurch zu begegnen, dass sie sich dem anderen zunächst von ihren schlechtesten Seiten zeigen. In Borderline-Therapien nenne ich dies die ›Maori-Methode‹:
Bei neuseeländischen Ureinwohnern (Maori) gibt es ein traditionelles Ritual, mit dem man Besucher empfängt: Kommt ein Fremder, vollführen die Dorfbewohner furchterregende Kriegstänze und Gebärden, erschrecken ihn mit lautem Gebrüll und bedrohen ihn mit ihren Waffen. Sie provozieren den Besucher mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln. Erst wenn der Fremde diesen Bedrohungen ruhig und gelassen standhält, ohne seinerseits aggressive Regungen zu zeigen, können die Bewohner sicher sein, dass er keine feindlichen Absichten hat. Unmittelbar darauf laden sie den Gast überschwänglich in ihre Hütte ein und beschenken und bewirten ihn auf das Großzügigste.
Dasselbe Ritual führen Borderliner auf, wenn ihnen ein ›Fremder‹ (z. B. ein Therapeut) begegnet. Scheint er ihnen wohlgesonnen, prüfen sie ihn nur umso gründlicher.

Hieran knüpft die Strategie von *Idealisierung und Abwertung* an. Dieser Mechanismus wirkt in Freundschaften, Arbeitskontakten und Liebesbeziehungen und wird im Therapiekontakt mit Borderlinern besonders deutlich. Die folgende Beschreibung ist demnach für jede Form der ›Beziehungsgestaltung‹ von Borderlinern gültig:

1. Phase: *Misstrauen:* Zu Beginn einer Therapie wird der Therapeut zunächst allen erdenklichen emotionalen und intellektuellen Prüfungen unterzogen. Seine Kompetenz wird in Zweifel gezogen, er wird auf Belastbarkeit hinsichtlich aggressiver und kritischer Äußerungen getestet, auf Widersprüche hingewiesen, zu persönlichen Stellungnahmen überredet und mit überzogenen Forderungen konfrontiert. Der Klient gewährt also Einblick in sein gesamtes ›Waffenarsenal‹. Sollte der Therapeut diesen Prüfungen standhalten, folgt die
2. Phase: *Hoffnung/Idealisierung:* Die Hoffnung auf Verständnis und Unterstützung kann bei Borderlinern mitunter äußerst ungestüm und euphorisch ausfallen. Allein die Möglichkeit, jemanden gefunden zu haben, der einen versteht und einem gewachsen ist, entzündet bei Borderlinern eine heftige Sehnsucht, sich endlich einem anderen Menschen anvertrauen zu können und Halt zu finden. Hieraus erklärt sich die *Idealisierung* des Gegenübers (deren Mechanismus dem Borderliner seit seiner Kindheit ohnedies geläufig ist). Der Therapeut wird gefeiert und hochgelobt und wähnt sich durch diesen ersten vermeintlichen Therapieerfolg bereits in trügerischer Sicherheit.
3. Phase: *Zerstörung/Abwertung:* Erlaubt der Therapeut sich aus Sicht des Klienten jedoch nur den kleinsten Fehler (und hierfür gibt es eine Fülle an Möglichkeiten: allein die Tatsache, dass man als Therapeut nur begrenzte Zeit zur Verfügung hat, kann für den Borderliner eine empfindliche Kränkung bedeuten; ebenso wie ein Moment der Unaufmerksamkeit, das Eingeständnis von Unkenntnis bestimmter Sachverhalte, das Gefühl, vom Therapeuten in einem Detail nicht verstanden zu werden, oder sonstige menschliche Unzulänglichkeiten), gewinnt beim Borderline-Klienten die Angst wieder Oberhand: Er ist erneut enttäuscht worden, er kann sich wieder nicht sicher fühlen, er hat sich im Therapeuten getäuscht und seine Hoffnungen brechen in sich zusammen. Manchmal reicht

Borderlinern ein einziger falscher Satz, ein einziges Missverständnis aus, um eine Therapie (oder eine Beziehung) unwiderruflich abzubrechen.
Der Mechanismus der Idealisierung und Abwertung kann verstanden werden als Wechsel zwischen übermäßiger Sehnsucht und übermäßiger Angst. Die Wutausbrüche und Beschimpfungen, aber auch die psychologisch raffinierten Manöver, die man im Kontakt mit Borderlinern bisweilen zu ertragen hat, verlangen dem Therapeuten häufig das Äußerste ab.
Gelingt es jedoch, auch diese Phase gemeinsam zu meistern, kann es nach weiteren, vielleicht weniger stark ausgeprägten Schwankungen zwischen Idealisierung und Abwertung schließlich gelingen, die vierte Phase zu erreichen.
Die 4. Phase einer weiterhin lebhaften, aber *beständigen Beziehung* findet nur statt, wenn der Therapeut in der Lage ist, die Hintergründe des wechselhaften Verhaltens und der aggressiven Angriffe zu verstehen, die ihnen innewohnende Angst zu respektieren, sie nicht persönlich aufzufassen und ihnen standzuhalten, indem er sich aufrichtig mit dem Klienten auseinander setzt (da ein normaler Beziehungspartner damit in der Regel überfordert ist, zerbrechen die meisten Beziehungen des Borderliners, bevor die ›beständige Phase‹ erreicht werden kann). Eine ausreichend starke Therapeutenpersönlichkeit wird dem Borderline-Klienten für seine emotionale und intellektuelle Kraft Respekt zollen und ihm vermitteln, dass sie trotz möglicher menschlicher Schwächen durchaus in der Lage ist, dem Klienten Halt zu bieten und Unterstützung zu gewähren.

Beziehungsgestaltung in der Therapie mit »Borderlinern«

Zu den vielen Übereinstimmungen zwischen Borderline-Persönlichkeiten und Hochbegabten gehört auch der überraschend ähnliche Verlauf der therapeutischen Beziehung:

1. Borderliner wie Hochbegabte fordern ein hohes Maß an *Authentizität* des Therapeuten. Sie überprüfen seine Aussagen und sein Verhalten auf Echtheit und Ehrlichkeit; sie fordern persönliche Stellungnahmen und reagieren hoch empfindlich auf unechtes Verhalten, falsches Lob oder rein technisch-methodisches Vorgehen.

2. In der exemplarisch geschilderten Therapie von Herrn L. (S. 163) wurde der *typische phasische Verlauf* deutlich, wenngleich die einzelnen Phasen in Intensität und Häufigkeit bei Hochbegabten ohne Borderline-Syndrom weniger stark ausgeprägt sind. Es zeigen sich jedoch eindeutige *qualitative* Übereinstimmungen in der Beziehungsgestaltung mit Borderlinern und Hochbegabten.
3. Das große Misstrauen und eine *überhöhte Aufmerksamkeit für kleinste Details* im therapeutischen Setting sind Hochbegabten ebenso eigen wie Borderlinern.
4. Borderliner und Hochbegabte neigen gleichermaßen dazu, den Therapeuten *kritisch zu hinterfragen*, ihn auf Widersprüche hinzuweisen und ihn in intellektuelle Diskussionen zu verwickeln.

Reinert (2004) beschreibt in sehr anschaulicher Weise seine Erfahrungen mit Borderline-Klienten. Da ich diese Schilderungen für besonders aufschlussreich halte, möchte ich im Folgenden etwas umfangreichere Auszüge zitieren (alle Herv. v. Verf.):

»Häufig verfügen Borderline-Patienten über einen *geradezu unheimlichen Spürsinn für die unbewussten Konflikte des Therapeuten* und können diese dann im Dienste der omnipotenten Kontrolle ausnutzen. (…) Nach meiner eigenen Erfahrung haben Borderline-Patienten (…) *ihre Sensitivität in einem ungeheuren Maße geschult, sind in der Lage, jeden x-beliebigen Gesprächspartner innerhalb von Sekunden in wesentlichen Zügen wahrzunehmen*, sich auf ihn einzustellen und u. U. sehr schnell eine (…) Kommunikation herbeizuführen, die z. B. ungeübte Psychotherapeuten dazu verführen kann, sich mit einem Patienten sehr schnell ›auf einem gemeinsamen Level‹ zu fühlen (…). (S. 143)

Dies scheint der Autor offensichtlich als Gefahr zu empfinden. Heißt das, ein geübter Therapeut wird seinen Borderline-Klienten automatisch ›unterhalb seines Levels‹ einordnen? Und wie gelingt es den als schwer gestört bezeichneten Persönlichkeiten, dem Therapeuten vorzutäuschen, sie befänden sich mit ihm auf ›einem Level‹? Bräuchte es nicht selbst hierzu besondere intellektuelle, psychologische und soziale Fähigkeiten? Diese Fähigkeiten wertet der Autor jedoch als Ausdruck eines »komplett falschen Selbst«, das lediglich die Absicht verfolgt, den Therapeuten »manipulativ zu steuern«. (S. 144) An anderer Stelle schreibt der Autor:

»In Langzeittherapien schwer gestörter Borderliner bin ich es gewohnt, vom Patienten u. U. perfektest kontrolliert zu werden. Extrem war dies der Fall bei der Patientin Laura (…): Diese Patientin verfügte über *geradezu unglaubliche Fähigkeiten, Situationen, Szenen, aber auch Texte in kürzester Zeit aufzunehmen und zuverlässig auch längerzeitig darüber verfügen zu können*. (…) Genauso registrierte die Patientin, was mir anfangs fast unheimlich war, wenn sich an meinem Bücherregal (oder im Behandlungszimmer überhaupt) etwas verändert hatte. (…) Mit *dedektivischer Präzision rekonstruierte sie aus beobachteten Details Einzelheiten meiner Lebensführung und -umstände*. Wenn sie einmal einen Patienten (…) aus meinem Zimmer hatte kommen sehen, registrierte sie anschließend den wohl von diesem Menschen ausgehenden Geruch und konnte dann auch (…) noch lange Zeit später mit großer Sicherheit sagen, wer von meinen PatientInnen am Tage bei mir in Behandlung gewesen war. War mir diese Art einer perfekten Kontrolle (…) anfänglich hochgradig unheimlich und unsympathisch, so gewöhnte ich mich mit der Zeit daran, konnte mich auch zunehmend darüber amüsieren und freute mich innerlich, wenn es der Patientin einmal, was ganz selten war, nicht gelang, eine sich ihr aufdrängende Fragestellung aus eigenem autarken Bemühen zu beantworten. (…)
Luise, eine 40-jährige Patientin mit einer Borderline-Krankheit (…), kontrollierte mich auf eine andere Weise: Mitten in Sitzungen bemerkte sie, ich hätte jetzt dieses oder jenes gesagt. Das widerspräche aber meiner Veröffentlichung XY auf Seite Z, dort stehe nämlich Folgendes: *Dann zitierte sie ganze Passagen aus einer meiner Veröffentlichungen wortwörtlich richtig; mir selbst wäre es unmöglich gewesen, meine eigenen Arbeiten in dieser Weise zu erinnern*.
Die Kontrolle des Therapeuten durch Borderline-Patienten beschränkt sich aber keineswegs nur auf Äußerlichkeiten. So erzählte mir Laura im Laufe ihrer Behandlung (…), es sei auch gut gewesen, dass die Behandlung bei einer früheren Therapeutin zu Ende gegangen sei (…). Denn (…) bei der habe sie *jede Reaktion und zu erwartende Stellungnahme bereits im Vorfeld gekannt*; und damit sei diese Therapeutin für sie steuerbar gewesen; (…)«. (S. 147/148)
Der Patient, so Reinert, wolle den Therapeuten nicht nur »per Kontrolle in seiner Aktivität (…) blockieren, um seine Machtausübung zu behindern«, sondern strebe immer wieder »Situationen an, in denen er den Therapeuten hilflos macht und ihn in zutiefst sadistischer Weise entmächtigt (…)«. (S. 148)

Mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich hier um hochbegabte Klienten, die nicht als solche erkannt wurden. Welche Auswirkungen dies auf das Beziehungsgeschehen einer Therapie haben kann, wird in diesen Ausführungen besonders deutlich.

Nach meiner Auffassung tut ein geübter Therapeut sehr gut daran anzuerkennen, wenn sein Klient sich ›auf dem gleichen Level‹ befindet. Für eine gelungene Beziehungsgestaltung mit Borderline-Persönlichkeiten gelten meines Erachtens dieselben Voraussetzungen, wie ich sie für Hochbegabte beschrieben habe. Nicht zufällig

deckt sich hier vieles mit dem Behandlungskonzept für Borderliner von Beck & Freeman (1995, S. 155–182):
Die Beziehung zwischen Therapeut und Klient spiele in der Therapie mit Borderlinern eine weit wichtigere Rolle, als dies normalerweise der Fall in der kognitiven Therapie sei. Die *Authentizität* und *Aufrichtigkeit* des Therapeuten sei für die Aufrechterhaltung der vertrauensvollen therapeutischen Beziehung von besonderer Bedeutung. Interventionen, die auf *vorgefassten Vorstellungen* des Therapeuten basierten, seien nicht angebracht und es könne leicht passieren, dass Therapeut und Klient sich in einen Machtkampf verstricken.
Es sei, so schreiben die Autoren weiter, zum Aufbau des Vertrauens ein beträchtlicher Aufwand erforderlich; dieses Vertrauen mittels Überredung, Argumenten oder Hinweisen auf den eigenen Ruf herstellen zu wollen, zeitige bei Borderline-Klienten kaum eine Wirkung. »Die effektivste Methode für den Vertrauensaufbau besteht darin, explizit anzuerkennen und zu akzeptieren, dass es dem Klienten schwer fällt, dem Therapeuten zu trauen (…), und darauf zu achten, sich *durchgehend vertrauenswürdig* zu verhalten. Die Kommunikation solle auf »klare und ehrliche Weise« erfolgen (S. 176). Wenn der Therapeut unüberlegt gehandelt habe, solle er seine *Fehler offen zugeben*.
Die Autoren weisen darauf hin, dass Borderline-Klienten *Körperkontakt*, z. B. beim Händeschütteln, sowie direkten *Blickkontakt* oder *Veränderungen* in der Raumgestaltung oftmals als unangenehm erleben und man dies als Therapeut ernst nehmen und berücksichtigen solle.
Diese Schilderungen stimmen nahezu vollkommen mit meinen Erfahrungen in der Therapie mit Hochbegabten überein.
Auch Beck & Freeman führen übrigens ihre Methodik anhand des Fallbeispiels einer Borderline-Klientin aus, die »recht intelligent zu sein schien« und ihr »Diplom an einer angesehenen Universität abgeschlossen« hat (S. 155).

Schlussfolgerungen

> Der unerträgliche Konflikt beweist die Richtigkeit Ihres Lebens. Denn ein Leben ohne inneren Widerspruch ist erst das halbe Leben (…). *C. G. Jung*

Mancher mag einwenden, dass eine Personengruppe, die eine psychologische Praxis aufsucht, keine repräsentative Stichprobe darstellt, da die Betroffenen bereits psychische Probleme haben. Auf diese Weise könnten Ähnlichkeiten mit ›klinischen Syndromen‹ eher nachgewiesen werden als in einer zufällig ausgewählten Gruppierung.
Zum einen verweise ich hier auf die Fülle der *qualitativen* Übereinstimmungen bei Borderlinern und Hochbegabten. Zum Zweiten habe ich in Elternvereinigungen, bei Vorträgen sowie bei Informations- und Elternabenden Gelegenheit, zahlreiche Beobachtungen und Erfahrungen auf ›neutralem‹ Boden zu sammeln. Drittens wird meine Praxis von Hochbegabten und Eltern hochbegabter Kinder häufig zu rein diagnostischen Zwecken aufgesucht, wenn es etwa um schulische Fördermaßnahmen oder Berufswahl geht und kein Therapiebedarf besteht.

Die beschriebenen Borderline-Strategien erklären sich meines Erachtens nicht allein aus traumatischen Kindheitserlebnissen, sondern auch aus den Erfahrungen, welche die Klienten als Hochbegabte machen. Die Betroffenen fühlen sich also in *doppelter Weise fremd in der Welt* und haben demnach allen Grund, ihren Mitmenschen zunächst mit Angst und Misstrauen zu begegnen. Ihre Chancen, jemanden zu finden, von dem sie sich verstanden fühlen, werden durch ihre Hochbegabung und die damit verbundenen Besonderheiten noch verringert. Wie wir gesehen haben, scheitern Hochbegabte oft schon früh in dem Versuch, sich Gleichaltrigen anzuschließen. Im Erwachsenenalter gleichgesinnte Freunde, Partner oder einen geeigneten Therapeuten ausfindig zu machen, kann sich ebenso schwierig gestalten.
Eine eigene, *stabile Identität* zu finden heißt immer auch: sich mit *anderen identifizieren* können, Gleiches und Unterschiede zu ent-

decken und zumindest bei einigen Personen feststellen zu können: »Der andere ist so ähnlich wie ich.« Gelingt dies nicht oder nur unzureichend, scheint die Borderline-Persönlichkeit im Verlauf ihrer Entwicklung weiter zu zersplittern.

»Ich bin keine Person, ich bin ein Konglomerat von Eigenschaften, Impulsen, Meinungen, Erfahrungen. Es gibt nichts Beständiges, ich bestehe aus lauter einzelnen Stücken, aus lauter Widersprüchen; es gibt nichts, was mich zusammenhält, ich kann mich bei mir auf nichts verlassen, ich bin die Unberechenbarkeit in Person, ich habe keine Ahnung, wer ich bin, was ich kann und was ich will.« Das instabile Identitätsgefühl gilt als eines der Hauptmerkmale der Borderline-Störung. Auch Hochbegabte schildern ihr Innenleben oftmals in vergleichbarer Weise, wenn auch in abgeschwächter Form. Was, so frage ich mich wiederum häufig, *ist* eine ›stabile Identität‹? Selbstzweifel gelten gemeinhin als Zeichen geistiger Arbeit. Muss jemand, der von seinen Fähigkeiten überzeugt und sich seiner persönlichen Eigenschaften und Ziele stets sicher ist, einer Person, die an sich zweifelt und ihre Ziele und Wertvorstellungen hinterfragt, zwangsläufig überlegen sein?

Dem fachkundigen Leser, aber auch dem Laien wird bereits eine Fülle von Ähnlichkeiten zwischen Borderlinern und Hochbegabten aufgefallen sein, etwa im Kapitel über die emotionale Hypersensibilität, bei den Schilderungen erwachsener Hochbegabten-Typen oder in der Auflistung gängiger Borderline-Symptome zu Beginn dieses Kapitels.

Hier seien abschließend nochmals die wichtigsten Übereinstimmungen aufgeführt:

1. Das *Gefühl des Andersseins*, des Nicht-dazu-Gehörens herrscht bei Borderlinern ebenso vor wie bei vielen Hochbegabten. Dies mag eine subjektiv verzerrte Wahrnehmung sein, entspricht jedoch bei Hochbegabten meist der Realität: sie sind tatsächlich anders als die Mehrheit und haben es schwerer, Gleichgesinnte zu finden. Dadurch kann der Eindruck enstehen, anders als *alle* andern zu sein.
2. Die extreme *soziale Sensitivität*, das übermäßig starke Mitleiden, die Fähigkeit, Eigenschaften eines Gegenübers schnell zu erfassen, sowie die Neigung zur Überinterpretation sozialer Signale sind Borderlinern ebenso eigen wie Hochbegabten.

3. *Intensive emotionale Reaktionen* werden von Hochbegabten und Borderlinern gleichermaßen beschrieben und stellen bei beiden sowohl eine Quelle der Inspiration und Kreativität als auch die Ursache von Leid dar. Dasselbe gilt für die Empfindlichkeit bzw. Schärfe der Sinneswahrnehmung.
4. Der Widerspruch, gleichzeitig hoch empfindlich zu sein und sich von *extremen Erfahrungen* angezogen zu fühlen, findet sich bei kreativen Hochbegabten wie bei Borderlinern. Bei beiden steht einer hohen Sensibilität eine enorme Kraft gegenüber, belastende Situationen zu ertragen.
5. Gefühle von *Einsamkeit, Leere und Langeweile* können sowohl von Depressionen und Selbstzweifeln verursacht werden als auch von der objektiv bestehenden Schwierigkeit Hochbegabter, Kontakte zu Ähnlichen zu knüpfen und sozial, emotional und intellektuell ausreichend gefordert zu sein.
6. Die Fähigkeit Hochbegabter, sich in *Beschäftigungen* so sehr *zu vertiefen*, dass sie alles um sich herum vergessen, wurde in Kap. II beschrieben. Sollen sie diese Beschäftigung für einige Zeit unterbrechen, reagieren sie ungehalten und bisweilen verzweifelt (»Es gibt kein Morgen!«). Auch für Borderliner scheint es oftmals nur das »Jetzt« zu geben, und es fällt ihnen schwer, ihre »Wahrnehmung auf einer beständigen, zusammenhängenden Serie von Erfahrungen« zu gründen (Kreisman & Straus, 1992, S. 251).
7. Weitere gemeinsame Merkmale sind: *Überschaubare, klare Strukturen* erweisen sich für Borderliner als ebenso hilfreich wie für Hochbegabte; Gefühle des Unbehagens, der Angst oder *Beklemmung in Menschenansammlungen* und auf Festveranstaltungen; die ausgeprägte Neigung zum Widersprechen und *kritischen Hinterfragen*; die Angst vor Veränderungen aller Art; ein ausgezeichnetes Gedächtnis und eine ausgeprägte Detailwahrnehmung.
8. *Erfolg im Beruf, künstlerische und kreative Fähigkeiten* und nicht zuletzt eine *hohe Intelligenz* werden, wenn auch eher beiläufig, im Zusammenhang mit Borderline-Syndromen immer wieder beschrieben. Es erübrigt sich zu sagen, dass dasselbe auch für Hochbegabte zutrifft.

Dies alles deutet darauf hin, dass Borderliner ebenso zu dem Personenkreis gehören, der von erhöhter intellektueller Aktivität sowie sensorischer und emotionaler Hypersensibilität, also von Hochbegabung, ›betroffen‹ ist. Nach meiner Erfahrung ist es gerade für den Erfolg der oft besonders schwierigen Borderline-Therapien unabdingbar, dass die Betroffenen auch diesen Aspekt ihrer Persönlichkeit kennen und verstehen lernen.
Zumindest aber scheint es lohnenswert, die Fragestellung, ob Borderline-Störungen eine für Hochbegabte spezifische Form sind, auf Traumatisierungen zu reagieren, in der psychologischen Forschung weiter zu verfolgen.

Psychotherapie traumatischer Erfahrungen

> Ohne Bewusstwerden seines Schmerzes kann ein Mensch nicht zum Menschen werden. (…) Diejenigen, die ihren Schmerz spüren, bleiben bei ihrem Bemühen, ihre Individualität, ihre Vitalität und ihre Liebe zum Leben zu realisieren. *A. Gruen*

In der Behandlung traumatisierter hochbegabter Erwachsener bzw. Borderline-Klienten sind zunächst der beschriebene Aufbau einer tragfähigen und vertrauensvollen Arbeitsbeziehung sowie die Vermittlung der mit einer Hochbegabung verbundenen Besonderheiten erforderlich. Es kann viele Sitzungen dauern, bis der Betroffene allmählich Vertrauen fasst und offen über sein Innenleben, seine Ängste und seine belastenden Kindheitserfahrungen sprechen kann.
Die Grundlagen der Trauma-Behandlung zu erörtern, würde leider den Rahmen dieses Bandes sprengen, sodass ich hier nur einige Hinweise zum Vorgehen bei Hochbegabten geben kann.

Die besondere Problematik traumatisierter Hochbegabter besteht darin, dass sie sich oft übermäßig stark mit den abweisenden oder misshandelnden Eltern identifizieren; dies hat zur Folge, dass sie erfahrene Abwertungen oder Demütigungen in hohem Maße *internalisieren*, also verinnerlichen, und die erfahrene Gewalt psychisch oder physisch gegen sich selbst richten. Dies äußert sich in unablässiger Selbstkritik, übermäßigen Selbstzweifeln, Selbstverletzun-

gen und Selbstabwertungen; auch selbstzerstörerische Verhaltensweisen wie erhöhter Alkohol- und Drogenkonsum oder frühe Promiskuität zählen hierzu. Die Betreffenden übernehmen die Überzeugung, wertlos, unfähig, abstoßend und nicht schützens- und liebenswert zu sein. Sie setzen die Kritik und Herabsetzungen durch die Eltern gleichsam innerlich fort, selbst wenn sie sich schon lange von ihrem Elternhaus distanziert haben.

Thematisiert man belastende oder traumatische Kindheitserfahrungen, reagieren die meisten Hochbegabten daher zunächst mit dem Versuch, die Eltern zu verteidigen, ihr Verhalten zu erklären oder es zu entschuldigen. Reinert (2004) beschreibt dies im Falle einer Borderline-Klientin mit folgenden Worten: »Marion betätigt sich hier wie eine spitzfindige Winkeladvokatin, um die Interessen der traumatisierenden Eltern zu vertreten.« (S. 135) Diese Winkeladvokatin fand ich in vielen Borderline-Patientinnen wieder, unter denen übrigens Juristinnen besonders zahlreich vertreten waren.

Ich nutze in diesen Fällen die juristischen Fähigkeiten der Klienten, bitte sie jedoch, die Perspektive zu wechseln: Statt als Anwalt der Eltern sollen sie als erfahrene, gerechte Richterin in der ›Verhandlung‹ auftreten. Dies eröffnet den Betroffenen einen objektiveren Blick auf ihre Eltern und *auf sich selbst*. Oft können Borderline-Klienten hier erstmals Mitgefühl mit dem misshandelten Kind empfinden, das gleichsam ›vor der Richterin sitzt‹ und ein gerechtes Urteil erwartet. Auch kann auf diese Weise eine erwachsene, unabhängige und gesündere Sichtweise implementiert werden. Das Gerechtigkeitsempfinden wird gestärkt, und die Klienten lernen, *auch im Hinblick auf eigene Erfahrungen* zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden; sie erhalten die Erlaubnis, die ungerechte Behandlung, die ihnen widerfahren ist, zu verurteilen. Damit gewinnen sie Distanz zu den Überzeugungen, die sie durch das Verhalten ihrer Eltern erworben haben.

Diese Methode mag etwas ungewöhnlich anmuten, ist jedoch lediglich eine konkret-anschauliche Variante der kognitiven Verhaltenstherapie. Der Therapeut kann etwa sagen: »Sie haben jetzt sehr eindringlich die Seite Ihrer Eltern vertreten, sozusagen als ihr Anwalt. Wie würden Sie sich äußern, wenn Sie Ihren Fall aus Sicht einer erfahrenen Richterin verhandeln würden? Was würde die Richterin denken, wenn sie Sie ansieht und wüsste, was Ihnen

widerfahren ist? Nehmen wir an, die Richterin wäre eine einfühlsame, gerechte und gütige Person – was würde Sie zu Ihnen sagen?«
Dies ist ein Beispiel, wie man die ›einfühlsame, gerechte und gütige Seite‹ des Klienten *im Hinblick auf sein eigenes Leid* mobilisiert. Zugleich werden hier die Stärken hochbegabter Klienten genutzt, nämlich ihr gutes Abstraktionsvermögen, ihre Fähigkeit zur objektiven Betrachtung und ihr starker Gerechtigkeitssinn.

Auch in anderer Hinsicht gestalten Borderliner bzw. traumatisierte Hochbegabte ihre leidvollen Erfahrungen zu einem, wie Scheidt (2004) es nennt, »Weltmodell« oder Lebensentwurf aus. Unter meinen Borderline-Klienten finden sich JuristInnen, KünstlerInnen, LehrerInnen, PsychologInnen, ÄrztInnen, ein Theologe und mehrere Angehörige sozialer Berufe (nur zwei von ihnen sind das, was man gemeinhin als ›gescheiterte Existenz‹ bezeichnen würde, und üben keinen Beruf aus, obgleich sie sich verzweifelt darum bemühen). Frau T., die ich auf Seite 196 vorgestellt hatte, studierte Medizin, um als Psychiaterin mit traumatisierten Kindern zu arbeiten. Eine andere Klientin studierte Jura, um misshandelte Frauen vertreten zu können. Eine weitere Juristin erklärte mir, sie habe diesen Beruf gewählt, weil sie zu Hause nie erfahren habe, »was Gerechtigkeit gewesen ist. Was mein Vater sagte und tat, war Gesetz. Ich fühlte, dass er oft unrecht handelte, aber ich konnte es nicht beweisen. Als Juristin kann ich das.«
Ganz offenkundig setzen traumatisierte Hochbegabte all ihre geistigen, sozialen und emotionalen Fähigkeiten daran, um erfahrenes Leid zu bewältigen und es ›in Ordnung zu bringen‹. Auch andere Autoren sprechen von Über-Leistungen und hohen beruflichen Kompetenzen bei Borderlinern; es ist hier jedoch stets von einer Kompensation schwerer Defizite, einem »falschen Selbst« (Reinert, 2004, S. 144) und einer »Fassade der Kompetenz« (Beck & Freeman, 1995, S. 162) die Rede. Ich möchte hier nochmals die Frage aufwerfen: Kann man berufliche Kompetenz wirklich dauerhaft ›vortäuschen‹? Und wäre dies an sich nicht schon eine Kompetenz? Es ist für mich logisch nicht nachvollziehbar, warum die Schwächen eines Borderliners als Ausdruck seines ›wahren Selbst‹, seine Stärken hingegen als ›falsches Selbst‹ interpretiert werden.

Borderliner äußern jedoch selbst oft das Gefühl, nur eine Fassade aufrechtzuerhalten, hinter der sie sich ängstlich, haltlos und unzulänglich fühlen. Aber gerade unter diesen Umständen sind ihre Leistungen *umso mehr* zu würdigen! Ich erkläre den Betroffenen, dass sie *beides* sind: sehr ängstlich und sehr leistungsfähig, sehr unsicher und sehr intelligent, sehr verletzlich und sehr stark. Dies *alles* sind Teile ihres ›Selbst‹, ihrer Gesamtpersönlichkeit.

Aufgrund ihrer intellektuellen Begabungen, ihrer Kreativität und ihrer emotionalen Kraft gelingt es Hochbegabten also oftmals, mittels ihrer Berufswahl eigenes Leid zu bewältigen, statt daran zu zerbrechen und zu resignieren – auch wenn sie dies manchmal fast übermenschliche Anstrengung kostet.
Diese Aspekte mit Borderlinern bzw. traumatisierten Hochbegabten zu erörtern, kann außerordentlich hilfreich und heilsam sein.

Bedarf es einer expliziten Trauma-Behandlung, hat sich bei meinen Klienten ein stark *strukturiertes*, *konfrontatives* und sehr *empathisches* Vorgehen bewährt.
Strukturiert bedeutet, dass mit dem Klienten *klare und sorgfältige Absprachen* getroffen werden und ihm das Vorgehen bei der Konfrontation eingehend erläutert wird. Dies sollte geduldig und behutsam erfolgen. Die meisten Klienten möchten genau wissen, was sie erwartet: »Was ist, wenn ich die Kontrolle verliere? Oder wenn ich zusammenbreche, wenn ich nicht aufhören kann zu weinen?« Der Therapeut kann Folgendes erklären: »Wir gehen Ihre schlimmen Erinnerungen gemeinsam durch, indem Sie sie mir so detailliert wie möglich beschreiben. Ich höre Ihnen genau zu und werde stetig darauf reagieren, mit Ihnen sprechen und Ihnen antworten. Sie werden also nicht ›ins Leere‹ sprechen. Wenn es für Sie zu unerträglich wird oder sie die Kontrolle verlieren, helfe ich Ihnen, wieder ins ›Hier und Jetzt‹ zurückzukommen. Das geht, wenn man sich auf seine Sinneswahrnehmung, eine beruhigende Atemtechnik oder hilfreiche Gedanken konzentriert. Wenn Sie möchten, können Sie einen Ihnen vertrauten Gegenstand mitbringen und in der Hand behalten, sozusagen als Talisman. Oder, wenn Sie damit einverstanden sind, werde ich Ihre Hand währenddessen festhalten, sodass Sie den Kontakt zur Realität nicht verlieren. Wir vereinbaren eine

Doppelstunde und nehmen uns genug Zeit. Falls Sie sich danach nicht mehr beruhigen können, was übrigens sehr selten vorkommt, können Sie sich im Nebenraum etwas ausruhen und ich sehe dann nochmal nach Ihnen.«

Konfrontativ bedeutet zunächst, dass der Therapeut zum vereinbarten Zeitpunkt *Entschlossenheit und Sicherheit* zeigt, das traumatische Geschehen mit dem Klienten durchzugehen. Er muss deutlich signalisieren, dass er stark genug ist, die Schilderungen und Emotionen des Klienten auszuhalten. Die Schilderungen und emotionalen Reaktionen können sehr drastisch und auch für den Therapeuten schwer zu ertragen sein. Beim Klienten darf keinesfalls das Gefühl entstehen, er müsse die Geschehnisse schnell oder nur in groben Zügen beschreiben, um den Therapeuten zu schonen. Der Therapeut muss den Mut aufbringen, während der Konfrontation Schritt für Schritt mitzugehen und gegebenenfalls schmerzliche Details zu erfragen. Im Vorfeld kann er äußern: »Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass es mich nicht erschüttern oder schmerzen wird, aber ich kann Ihnen versprechen, dass ich es aushalte und Sie begleite.«
Empathisch heißt, dass *extrem leidvolle Erfahrungen explizit als solche benannt* werden. Es ist der Heilung seelischer Verletzungen *nicht* förderlich, wenn man, wie es in unserer Kultur üblich ist, schnell von ihnen ablenkt und auf tröstliche Aspekte verweist. Trost ist erst dann wirksam, wenn zuvor ausdrücklich anerkannt wird, dass der Klient schweres Leid zu bewältigen hat.
Es ist selbstverständlich, dass Schilderungen traumatischer Erfahrungen auch im Therapeuten starke Gefühle auslösen. Diese sollten nicht im Dienste der ›therapeutischen Souveränität‹ unterdrückt, sondern – mit einer gewissen Vorsicht – zum Ausdruck gebracht werden. Bei einigen meiner Klienten war es völlig unmöglich zu verhindern, dass mir Tränen in die Augen schossen. Als ich noch relativ unerfahren war, befürchtete ich, dass mir damit ein Fehler unterlaufen wäre. Das Gegenteil war der Fall: Situationen, in denen mir eine weinende Klientin ein Taschentuch reichte und wir über diese Geste lachen mussten oder ein anderer Klient sich tief bewegt für meine Tränen bedankte, gehören auch in der Erinnerung der Klienten zu den stärksten Momenten einer Therapie.

Auch bei der Traumabehandlung scheint mir nicht so sehr die Methode als vielmehr die Haltung des Therapeuten entscheidend zu sein. Sofern sie einen hohen Strukturiertheitsgrad aufweist, kann daher eine verhaltenstherapeutische Methodik ebenso wirksam sein wie tiefenpsychologische oder imaginative Verfahren.

Die Angst des Therapeuten

Beck & Freeman (1995) schreiben: Da Borderline-Klienten »als schwer behandelbar verrufen sind, dient der Borderline-Begriff im Endeffekt oft als allgemeine Bezeichnung für schwierige Klienten oder als Rechtfertigung für den schlechten Verlauf einer Therapie«. Die Autoren fassen mehrere Gespräche zu einem Beispiel zusammen:
»Supervisor: Warum haben Sie Schwierigkeiten mit Herrn Schultz?
Therapeut: Weil er eine Borderline-Störung hat.
Supervisor: Warum gehen Sie davon aus, dass er eine Borderline-Störung hat?
Therapeut: Weil ich so viele Probleme mit ihm habe.« (S. 156)

Unbestreitbar ist, dass hoch intelligente, sehr eloquente und emotional starke Klienten den Therapeuten über das gewöhnliche Maß hinaus fordern und selbst einen erfahrenen Behandler in Bedrängnis bringen können. Mit ›emotional stark‹ meine ich die Fähigkeit, intensive Gefühle auszuhalten und vielfältige extreme Gefühlszustände zu kennen.
Zugespitzt könnte man die Frage stellen: Wer ist klüger – eine Borderline-Klientin, die gelernt hat, unter extremen Bedingungen zu überleben, oder eine gebildete Psychologin mit einer strikt akademischen Laufbahn?
Beide sind auf ihre Art klug, und der Therapeut ist gehalten, dies anzuerkennen, statt sich kraft seiner Position über den Klienten zu stellen.
Die Versuchung, das kritische Hinterfragen des Klienten oder die eigene Unterlegenheit mit akademischen Fachbegriffen, klinischen Stigmatisierungen oder subtiler Abwertung des Klienten abzuwehren, mag für viele Therapeuten groß sein. Kritik am Therapeuten wird dann lediglich als Ausdruck eines ›pathologischen Be-

ziehungsverhaltens‹ oder einer ›gestörten Persönlichkeit‹ gesehen. Dem leistet nicht selten ein geradezu diffamierendes Vokabular in wissenschaftlichen Publikationen Vorschub. Beispielhaft möchte ich hier Kernbergs (1967) Konzept der Borderline-Persönlichkeitsorganisation nennen, wo fortwährend von »behindert«, »niedrig funktionierendem Niveau«, »defekten Mechanismen«, »Funktionsschwächen«, »primitivem Denken« und »primitiven Abwehrmechanismen« die Rede ist.

Nur weil sie den Therapeuten besonders anstrengen, müssen die Betroffenen nicht besonders krank sein.

Auch der schwierigste Borderline-Klient verdient Respekt und menschliche Achtung, und es ist in der Arbeit mit Borderlinern und Hochbegabten unbedingt erforderlich, sorgfältig zwischen Verhaltensweisen als Ausdruck seelischer Störungen einerseits und berechtigter Kritik am Vorgehen des Therapeuten andererseits zu unterscheiden.

Bereits hochbegabte Kinder wissen die Authentizität, und damit auch die Fähigkeit zur Selbstkritik des Behandlers, zu schätzen.

Fühle ich mich als Therapeut unterlegen, kann es durchaus angebracht sein, dies zu geeigneter Zeit anzusprechen oder sogar vorwegzunehmen, indem ich zum Beispiel sage: »Sie verfügen über eine enorme Sprachgewandtheit und eine sehr differenzierte Wahrnehmung. Und Sie haben emotionale Erfahrungen gemacht, die weit über das normale Maß hinausgehen. Wenn bei Ihnen oder bei mir der Eindruck entsteht, dass ich Ihnen manchmal nicht folgen kann, sollten wir das zur Sprache bringen.« Dies kann sowohl für den Klienten als auch für den Therapeuten entlastend sein: Der Klient fühlt sich in seiner Wahrnehmung bestätigt, und der Therapeut ist nicht gezwungen, etwaige Unsicherheiten zu verbergen. Wenn der Therapeut sich dem Klienten jedoch grundsätzlich und langfristig nicht gewachsen fühlt, sollte er sich nicht scheuen, dies zu thematisieren und dem Klienten behilflich zu sein, einen anderen, geeigneteren Therapeuten zu finden. Ganz im Gegensatz zu möglichen Befürchtungen wird dies von den Betroffenen als ein Zeichen hoher Professionalität und persönlicher Stärke aufgefasst.

Es gibt also zwei Störungsbilder, von denen ich annehme, dass sie ohne Kenntnis der mit einer Hochbegabung verbundenen Phäno-

mene nicht adäquat behandelbar sind: Dies sind Borderline-Syndrome und autistische Störungen. Zudem gehe ich davon aus, dass der Schweregrad der jeweiligen Störung weit geringer ausfiele, wenn die Betroffenen sich verstanden und als Hochbegabte erkannt fühlten. Aus diesem Grund habe ich die Problematik von autistischen Menschen und Borderline-Persönlichkeiten besonders ausführlich behandelt. Diese beiden Personengruppen weisen viele Gemeinsamkeiten auf: Dazu gehören die extrem intensiv erlebten Gefühle und heftigen emotionalen Reaktionen sowie die Abwehrmechanismen, um diese aushalten zu können; die geringe Frustrationstoleranz und die Selbstverletzungen; die Überempfindlichkeit der Sinneswahrnehmung und die Angst vor körperlicher Nähe und Berührungen; Gefühle der Isolation und Einsamkeit sowie die Schwierigkeiten im Kontakt mit anderen; die Sehnsucht nach Kontakten und zugleich die Angst davor; die ›Verzerrungen‹ oder Besonderheiten in der Wahrnehmung; und nicht zuletzt die überwiegend hoch ausgeprägten intellektuellen oder künstlerischen Fähigkeiten.
Ein wesentliches gemeinsames Merkmal wäre also eine neuronale Übererregbarkeit, welche sich in *Überaktivität des Denkens, emotionaler Hypersensibilität* und *Überempfindlichkeit der sinnlichen Wahrnehmung* äußert.

Borderline-Syndrome gelten als ›besonders schwer behandelbar‹, autistische Störungen meist als ›unheilbar‹. Allein diese Etikettierungen halte ich für sehr bedenklich; ich gehe sogar so weit zu behaupten, dass sie zur Verfestigung des jeweiligen Störungsbildes mit beitragen. Ein Autist, der zeit seines Lebens wie ein ›geistig Behinderter‹ angesehen und behandelt wird, wird diesen Eindruck zwangsläufig von sich selbst gewinnen und sich entsprechend verhalten; er übernimmt die Haltung, dass er ›unheilbar krank‹ sei. Ein Borderline-Klient, dem eine hochgradig ausgeprägte Persönlichkeitsstörung attestiert wird, wird früher oder später selbst zu der Überzeugung gelangen, ›schwerst gestört‹ zu sein.
Gerade diese beiden Störungsbilder sind mit einem merkwürdigen Tabu behaftet. Von schizophrenen Erkrankungen vielleicht abgesehen, gibt es keine psychischen Diagnosen, die so viel Interesse und Aufsehen erregen und zugleich so eindeutig der Kategorie ›aus-

sichtslose Fälle‹ zugeordnet werden wie autistische und Borderline-Störungen. Im Hinblick auf autistische Kinder wird von vielen Autoren ausdrücklich betont, dass sich die Eltern keinesfalls zu große Hoffnungen auf Besserung machen dürfen. Auch eine Therapie von Borderline-Störungen gilt als wenig aussichtsreich, und man hält Stundenkontingente von bis zu 1500 Sitzungen für durchaus angebracht.
Viele Therapeuten nehmen sehr wohl wahr, dass ihre Borderline-Klienten über herausragende Fähigkeiten und eine ungeheuer ausgeprägte Sensitivität verfügen; und sie verschweigen auch nicht, dass ihnen dies zuweilen unheimlich ist. Schwartz-Salant (1991) spricht von der »Angst und Scheu, die der Mensch empfindet, wenn er sich dem Unbekannten stellt. (…) Die Psyche der Borderline-Persönlichkeiten zwingt uns dazu, in Bereiche einzutreten, deren Existenz nicht ohne weiteres eingestanden wird und die gewöhnlich gemieden werden; es ist eine Welt des Chaos, ohne die es für keinen Menschen Erneuerung geben kann.« (S. 25 ff.)

Hier sind Psychologen und Ärzte aufgefordert, sich zu fragen, was diese Klienten, die im Allgemeinen als hoch interessante und faszinierende Persönlichkeiten beschrieben werden, in *ihnen selbst* auslösen und welchen Einfluss diese Empfindungen auf den Umgang mit ihren Klienten haben. Meine Vermutung ist, dass bei der auffallenden Stigmatisierung von Autisten und ›Borderlinern‹ nicht nur die Angst vor dem Unverständlichen, Andersartigen und Außerordentlichen eine Rolle spielt, sondern auch die Angst vor außergewöhnlicher Begabung.